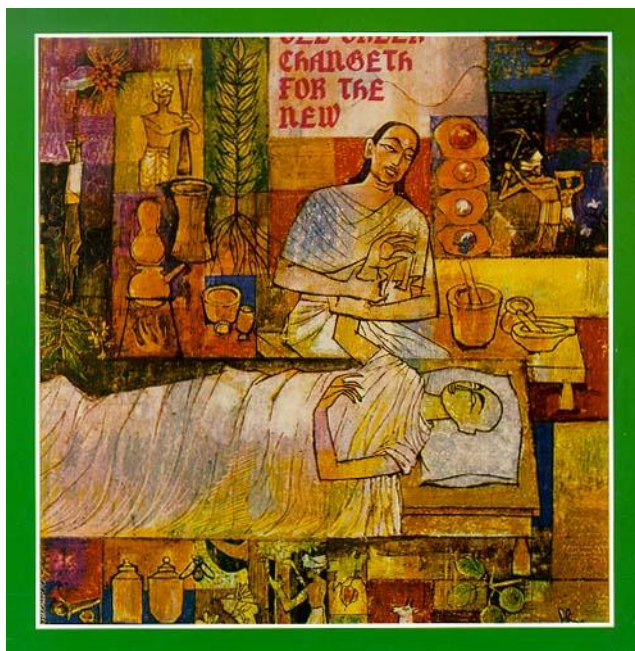




*Curso de Massagem Tradicional
Ayurvédica
Módulo II*



Professor: Valter Cardim

Direitos de Autor

Todo o material deste manual, incluindo textos, imagens e sistema de ensino está registado e como tal, protegido por lei. É proibida a sua cópia, reprodução total ou parcial sem autorização expressa da Associação Luso Brasileira de Ayurveda e Disciplinas Associadas.

O presente manual faz parte do Curso de Massagem Ayurvédica Tradicional, Módulo I, promovido pela ALBA, e não pode ser utilizado para outros fins que não os descritos anteriormente.

Associação Luso Brasileira de Ayurveda – ALBA

Fundada em Março de 2000 em Lisboa, Portugal, a *Associação Luso-Brasileira de Ayurvédica e Disciplinas Associadas*, tem como objectivo proporcionar aos seus associados o estudo e a prática do Sistema Oriental de Tratamento Corporal Ayurvédico, como técnica terapêutica e o estudo da filosofia Védica (Hindu), nas suas várias modalidades: Medicina Ayurvédica, Massagem Terapêutica Ayurvédica e Yoga nas suas várias vertentes, bem como outras técnicas orientais e ocidentais que visem a evolução do homem.

Contactos

Website: <http://www.ayurvedica.org>

E-mail: info@ayurvedica.org

Nota: Este manual pretende informar sobre tradições Ayurvédicas, mais especificamente a arte da Massagem Tradicional Ayurvédica. O seu conteúdo é meramente informativo e não pretende de examinar, diagnosticar e tratar doenças, pelo que a ALBA, não se responsabiliza pelo mau uso ou má interpretação das técnicas aqui descritas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

INTRODUÇÃO AO 2º VOLUME

PARTE A – TEÓRICA

- 1 – MASSAGEM AYURVEDICA, MOVIMENTO DE ENERGIA E CHACRAS
- 2 – OS 21 CHACRAS MENORES
- 3 – O CHACRA DA PALMA DAS MÃOS
- 4 – OS PONTOS DE REFLEXO DOS CHACRAS NO CORPO FÍSICO
- 5 – REFLEXO DOS CHACRAS NO ALTO DA CABEÇA
- 6 – REFLEXO DOS CHACRAS NOS PÉS
- 7 – VÓRTICES DE ENERGIA COMPANHEIROS AOS CHACRAS PRINCIPAIS
- 8 – OUTROS CHACRAS QUE SÃO ACTIVADOS COM A MASSAGEM AYURVEDICA
- 9 – AS VÉRTEBRAS E SUA RELAÇÃO COM OS ÓRGÃOS
- 10 – BLOQUEIOS E DESEQUILÍBRIOS QUE SE APRESENTAM NO CORPO FÍSICO E ETÉRICO
- 11 – A MASSAGEM AYURVÉDICA E OS MERIDIANNOS DA MEDICINA CHINESA
- 12 – TRANSFERENCIA DE ENERGIA E VIBRAÇÕES
- 13 – A MASSAGEM E O SISTEMA LINFÁTICO
- 14 – PONTOS MARMAS – CLASSIFICAÇÃO
- 15 – MASSAGEM AYURVÉDICA – KUNDALINI E OS SETE CORPOS DO CAMPO ÁURICO
- 16 – OS SETE TECIDOS CORPORAIS – SAPTA DHATUS
- 17 – A COLUNA VERTEBRAL
- 18 – ALTERAÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL QUE A MASSAGEM AYURVEDICA PODE AJUDAR A CORRIGIR
- 20 – MASSAGEM AYURVEDICA E O USO DE OLEOS AROMÁTICOS

PARTE B – PRÁTICA - MANOBRAS ESPECIAIS

- 1 – MASSAGEM COM OS PÉS NAS COSTAS
- 2 – MANOBRAS DE TRACÇÃO PARA ABRIR O PEITO
- 3 – MASSAGEM COM OS PÉS NA PARTE POSTERIOR DAS PERNAS
- 4 – MOVIMENTO ALTERNATIVO PARA SUBSTITUIR A MASSAGEM COM OS PÉS
- 5 – TRACÇÕES E ALONGAMENTOS NAS PERNAS – PARTE POSTERIOR
- 6 – TORÇÕES E FLEXÕES NOS PÉS
- 7 – MANOBRAS DE TRACÇÃO PARA ABERTURA DO 4ª / 5ª E 6º CHAKRAS
- 8 – MOVIMENTOS ADICIONAIS

PARTE C – ANEXOS

- I – BIBLIOGRAFIA
- II - TEXTOS COMPLEMENTARES

INTRODUÇÃO AO 2º VOLUME

Como vimos no 1º caderno de apontamentos do nosso curso é muito difícil estabelecer o período temporal exacto na qual teve lugar o nascimento do Ayurveda. No entanto, é **reconhecido como o sistema médico tradicional vigente mais antigo da humanidade.**

Aproximadamente no ano de 3.500 a.C surgiu a civilização no vale do rio Hindu, no que é hoje o Paquistão, lado ocidental da Índia. Há cerca de uns 3.000 anos antes de nossa era, algumas cidades do sub-continente Hindu haviam desenvolvido programas de higiene e saúde ambiental como a provisão de banhos públicos e sistemas de despejo de águas subterrâneas.

Os aspectos essenciais da saúde estavam incorporados nas actividades da vida diária, entre eles a higiene pessoal, a educação sanitária, o exercício físico, os códigos de conduta e autodisciplina, as práticas dietéticas, a saúde ambiental e alimentícia e o tratamento de enfermidades e doenças menores.

Os historiadores dão conta de que uma civilização com desenvolvimento superior aos gregos, às civilizações da antiga Mesopotamia e Egipto, existiu na Índia nesse momento.

Os arianos, sucessores dos assentamentos neolíticos de 5.000 anos atrás, construíram vastas cidades como Mohenjodaro e comercializavam com terras vizinhas via Lothal, seu porto marítimo.

A civilização Hindu, se desenvolveu na margem de Saraswati. Sabe-se que foram grandes adoradores da Mãe Divina e outras deidades, assim como desenvolveram capacidades supra-naturais.

Dado que a religião era o eixo central da vida diária do povo, desenvolveu-se aspectos da ciência que os ajudavam na sua religião. Entre estas se encontram a astronomia, a música, as matemáticas, a geometria, a anatomia e a medicina.

Por volta do ano de 1.400 a.C., a Ciência da Vida, se destacou pelo cuidado completo da saúde através da educação e promoção da mesma, ainda que também realizou avanços no campo da cirurgia e na medicina curativa.

Nas escavações foi achado o Shilajit, um fármaco que ainda hoje em dia se utiliza no Ayurveda e que possui propriedades anti-diabéticas e tónicas.

Neste período se desenvolveu o sânscrito, o antigo idioma literário e clássico da Índia. Significa refinado, perfeito, elaborado. Durante más de três milénios floresceu como a linguagem do conhecimento.

A civilização da Índia floresceu entre 1.500 a.C e 1.200 d.C sob o domínio das dinastias Maurya e Gupta.

Os textos principais, contudo, vigentes hoje em dia, são conhecidos pelo menos há 2.800 anos.

O Charaka Samhita (Samhita = Colecção) é um tratado clínico cujos conteúdos triplicam o publicado por Hipócrates.

O Susruta Samhita versa sobre os tratamentos cirúrgicos. Foi escrito há cerca de 2300 anos.

Se pode identificar na história, diferentes períodos:

1 - Período Védico

2 - Período Arsha

3 - Período Budista

4 - Período de Declínio (posteriormente às invasões muçulmanas, o Ayurveda foi perseguido e entrou num período de declínio).

Esta situação agravou-se sensivelmente com a posterior invasão britânica e a proibição do ensino.

A partir de 1920, o Ayurveda foi ressurgindo na Índia. Há 50 anos, com a independência política, a Ayurveda foi retomando o seu desenvolvimento.

O PERÍODO VÉDICO E O PERÍODO ARSHA

Neste período, a humanidade ganhava um dos mais ricos tesouros: os quatro Vedas eram compilados pelos sábios.

Os Vedas constituem os textos religiosos mais antigos da humanidade.

Estes quatro livros do Conhecimento são: Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda e Atharva Veda.

Destes quatro escritos milenares, o quarto Atharva **Veda**, escrito aproximadamente há cerca de 1.200 anos a.C, é o 1º registro de conhecimento médico neste período.

Desta forma, o Ayurveda é um ramo do Atharva Veda. Nele se encontram hinos, orações e mantras para serem usados nos tratamentos de enfermidades, conjuntamente com as plantas medicinais. Mais de 100 destes versos de cura estão destinados a condições como febre, dores de cabeça, reumatismo, epilepsia, lepra, enfermidades do coração e tuberculose, entre outras.

As forças naturais como o Sol e a água, em combinação com o engenho humano eram utilizados com fins terapêuticos no período védico.

Oito subdivisões do Ayurveda estão documentados no Atharva Veda.

As palavras dos Vedas eram cuidadosamente memorizadas sobre a base de cantos métricos e assim, foram transmitidos de geração a geração por muitos anos até serem finalmente escritos.

Este período se estendeu ao longo de vários séculos e é caracterizado pela aparição de tratados sistemáticos no campo da Ayurveda, realizados por grandes sábios.

Dhanvantari é considerado como o Deus da Ayurveda. Também é conhecido como Kashiraj Divodas, isto é, o Rei de Benares, quem dedicou toda a sua vida ao desenvolvimento da área cirúrgica do Ayurveda.

Os aspectos tanto mágicos como religiosos da medicina nos Vedas foram complementados lentamente com observações baseadas em pensamentos científicos.

Apenas três textos autênticos, dos muitos disponíveis, sobreviveram e chegaram até os nossos dias: Charaka Samhita, Sushruta Samhita e Ashtanga Hridaya Samhita. Apesar dos mesmos terem sofrido algumas modificações por vários autores nos diferentes períodos, a sua apresentação actual tem mais de 1.200 anos de antiguidade.

As práticas da medicina Hindu o vedanta estão descritas há cerca de 2800-3000 anos quando foi compilado o 1º livro, o Charaka Samhita. Posteriormente foi escrito o Sushutra Samhita, sobre cirurgia, com uma antiguidade aproximada de 2.500 anos. Seus conteúdos principais vem da era pré-Budista.

Todos eles estão escritos no idioma Sânscrito.

É possível que os compêndios do Charaka y Sushutra sejam fruto de uma compilação realizada por distintas pessoas ao longo de séculos. Ambos continuam, hoje em dia, sendo os livros de uso comum e fundamentais no estudo universitário do Ayurveda.

Charaka foi um médico que, ao que parece, exerceu a sua profissão na corte do imperador Kusana Kanishka, e é conhecido como autor de um dos primeiros tratados de medicina. Acredita-se que foi anterior ao grande médico hindu da antiguidade, Sushruta.

Composição dos 120 capítulos do Charaka Samhita:

- Aforismos: origem do Ayurveda (30)
- Diagnóstico: causas e sintomas (8)
- "Medidas": fisiologia, metodologia e ética (8)
- Corpo: anatomia e embriologia (8)

- "Órgão sensorial": prognóstico (12)
- Chikitsa: tratamento (30)
- Kalpa: farmácia (12)
- Siddhi: terapia de purificação (12)

O compêndio de Charaka, é principalmente um texto de medicina interna ainda que os outros ramos do Ayurveda também ali são mencionados. Assim mesmo contém muito material de interesse filosófico.

Desconhece-se a vida de Charaka, porém a sua obra, *Charaka Samhita* se compõe de capítulos que abordam temas como a fisiologia, a descrição de enfermidades graves, o diagnóstico e a terapia.

Descreve com detalhe o processo de fecundação e de gestação. Neste tratado encontram-se as bases para os conhecimentos das constituições corporais e mentais e o impacto dos alimentos e as ervas medicinais sobre elas.

Alguns estudiosos postulam que Charaka e Patanjali, o autor dos textos fundamentais do Yoga, tem sido a mesma pessoa, que utilizou distintos nomes para escrever os ditos tratados. Para termos uma dimensão da vastidão do trabalho de Charaka, devemos conhecer que toda a obra de Hipócrates representa só 1/3 dos escritos de Charaka.

Sushutra realizou descrições aceitáveis da malária, da tuberculose e sobre a diabete. Também escreveu sobre o cânhamo, cannabis e *Hyoscyamus*, para induzir a anestesia, e inclui antídotos específicos e tratamentos muito qualificados para as picaduras de serpentes venenosas.

Um antigo fármaco hindu derivado da raiz da planta *Rauwolfia serpentina* foi a fonte de primeiro tranquilizante e anti-hipertensão moderno. A sua obra tem um grande efeito na cirurgia, um campo onde os hindus são reconhecidos por ser os mais destros de toda a antiguidade.

Acredita-se que foram os primeiros a realizar um transplante de pele e cirurgia plástica no nariz.

Fizeram autópsias e aperfeiçoaram técnicas de reconstrução de ossos quebrados com a utilização de cravos.

Identificaram pontos vitais no organismo (marmas) que estão relacionados com os diferentes órgãos e que determinados ferimentos neles pode ser extremamente sério ou fatal.

Vagbhata de Sindh por volta do anos de 630 d.C. realizou uma compilação dos escritos de Charaka y Sushutra em sua Ashtanga Hridaya, o qual foi traduzido em árabe e usado extensamente nesta cultura.

A INFLUÊNCIA BUDISTA

A expansão do Budismo na Índia afectou cada pilar da vida. No período entre 323 a.C - 624 d.C. o budismo gozou de ampla popularidade, o progresso da Ayurveda foi dirigido tanto por hindus como por budistas.

As plantas medicinais eram plantadas na beira das ruas para o uso livre de todos os habitantes. Foram criados hospitais e a arte da correcta nutrição, amplamente descrito no Charaka Samhita.

A ciência veterinária era também praticada neste período. Assim mesmo, Nagarjuna escreveu as bases do Rasa Shastra, que indaga sobre os usos das preparações alquímicas.

No período budista, eram estimulados tanto os cuidados médicos, como nutricionais, porém não era autorizado o uso do bisturi, o que dificultou o desenvolvimento da cirurgia.

O sacrifício e a dissecação de animais não foram autorizados por problemas ético-religioso. Foi dado apoio e estímulo a investigação médica e no estabelecimento de centros de saúde para pessoas e também para animais. O imperador Ashoka, seguidor do budismo, estabeleceu hospitais gerais e também veterinários.

Junto com os missionários budistas, o conhecimento ayurvédico e a cultura hindu se expandiu para além dos limites da Índia.

As nações do mundo civilizado, incluindo Roma, Grécia e China, foram atraídas até a Índia e os estudantes desses países viajaram até a Índia para aprender a ciência e as artes.

Os budistas, que apoiavam todas as formas de ensino, criaram três universidades para ensinar o budismo e outras ciências, incluindo a medicina. Ir aos centros de estudo do Ayurveda era um passo obrigatório aos médicos da Grécia e da China.

A mais famosa destas universidades foi a de Nalanda que foi estabelecida no Século IV e durou até o século XII. Outras grandes universidades foram as de Taxila ou Takshashila e Khasi ou Varanasi.

A Universidade de Nalanda, situada no estado de Bihar, atraía os sábios da China e do sudeste asiático. Prosperou até o século XII, e em seus melhores momentos chegou a ter 2.000 professores e 10.000 alunos junto com grande número de auxiliares. Só 20% dos alunos passava no exame de ingresso.

Entre os seus ensinamentos se incluía o estudos das escrituras budistas e das escolas mahayana e theravada, os vedas, a filosofia, as matemáticas, a lógica, a teologia e a medicina.

As três classes eram gratuitas, já que a universidade era financiada com o dinheiro doado pelos habitantes da localidade e pelos aldeões que também davam os alimentos.

Ao que tudo indica tanto Buda como Mahavira, o fundador do jainismo, visitaram Nalanda.

Ela foi completamente destruída pela invasão turca no ano de 1.197 d.C. Os seus professores e alunos foram assassinados e os restos da universidade arrasada pelo fogo, que durou semanas inteiras.

Takshashila, estava localizada no estado de Punjab. Nutriu o saber dos gregos que a visitaram com assiduidade. Sobreviveu às invasões dos sasânidas no século III, porém foi destruída quase por completo pelos hunos brancos no século V.

Aquando da divisão da Índia em 1.947, foi transformada na capital do Paquistão passando a utilizar o nome de Rawalpindi.

Descrição das Plantas Medicinais

•Vedas **150**

•Charaka Samhita **526**

•Sushutra Samhita **573**

•Ashtanga Hridaya **902**

Desde o começo do Ayurveda tem existido um grande conhecimento das plantas medicinais, das que eram utilizadas para solucionar enfermidades.

Ao comparar com estudos científicos modernos a utilidade terapêutica das mesmas para resolver enfermidades que ainda hoje em dia atormentam a humanidade, nota-se quão precisa era esta medicina.

DECLÍNIO DO AYURVEDA

Por causa das invasões que decorreram na Índia a partir do século VI, o Ayurveda foi perseguido e combatido.

No final do século VI, a Índia foi invadida pelos hunos, dando fim ao período de Ouro da dinastia Gupta.

No ano de 1.192, os muçulmanos procedentes do Afeganistão invadiram grande parte do norte da Índia e fundaram o Sultanato de Delhi.

Depois de resistirem a 17 tentativas, finalmente foi conquistada e dominada pelos turcos, dando lugar a um progressivo declínio do Ayurveda.

Os muçulmanos massacraram os monges e sábios como infiéis, destruíram as universidades e queimaram as bibliotecas. Aqueles que puderam escapar foram para o Tibet e Nepal, onde o Ayurveda havia penetrado no século VIII. Por este motivo, alguns textos ayurvédicos estão disponíveis somente na tradução tibetana.

Com a expansão do budismo (que proibiu o estudo da anatomia) e a conquista muçulmana, a medicina ayurveda entrou num período de declínio e estancamento.

Apesar disso, através dos escritos do médico árabe Avicena, entre outros, foi transmitida para o ocidente um conhecimento apreciável no campo da higiene, da nutrição, entre outros.

A **chegada dos ingleses** foi outro feito a destacar e que contribuiu para o declínio do Ayurveda, como já vimos no caderno I.

PARTE A

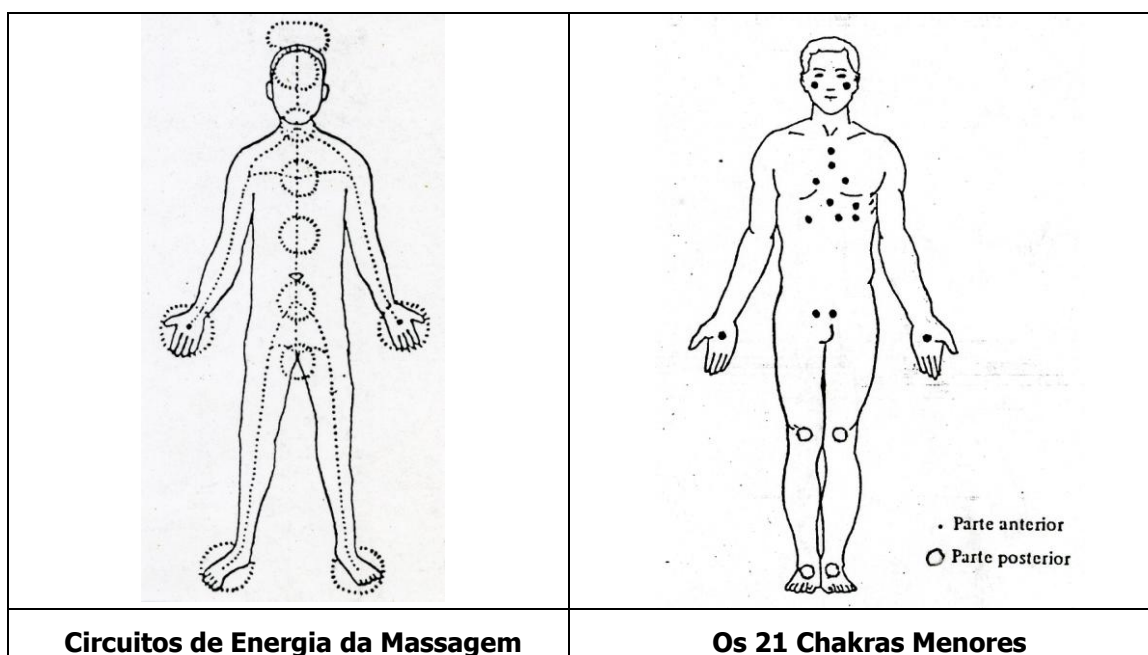
MASSAGEM AYURVEDICA, MOVIMENTO DE ENERGIA E CHAKRAS

A massagem Ayurvédica centraliza a sua movimentação no sentido caudo-cefálico ou seja, estimula a circulação sanguínea e energética em direcção ao coração, activando-o e contribui, não só para o desenvolvimento da glândula timo mas também para a refinação das energias mais densas para o campo subtil renovando, desta forma, todo o complexo energético.

Por ser parte integrante da tradição Indiana, a massagem Ayurvédica tem também como objectivo:

- centralizar e dinamizar os principais vórtices de energias (chakras maiores) do corpo físico
- centralizar e dinamizar os vórtices secundários de energias (chakras menores) do corpo físico.
- concentrar a energia no canal subtil da coluna vertebral activando levemente e progressivamente a ascensão da mesma do 1º para o 7º chakra ou seja, da terra para o céu.

A massagem Ayurvédica trabalha, portanto, com os 7 centros principais, localizados na junção dos dois lados esquerdo e direito do corpo, que estão centralizados na coluna vertebral e com alguns vórtices menores que são auxiliares dos principais. Cada um desses pontos de energia possui uma função específica para o bom funcionamento dos corpos subtil e físico do ser humano e o seu mau funcionamento é assinalado frequentemente com desequilíbrios num desses corpos e principalmente nos órgãos do corpo físico a ele conectados.



OS 21 CHAKRAS MENORES

Os 21 chakras menores encontram-se nos seguintes locais: um à frente de cada orelha, um acima de cada lado do peito, um onde se juntam as clavículas, um na palma de cada mão, um na sola de cada pé, um logo atrás de cada olho (que não se visualiza no desenho abaixo), um relacionado com cada gônada, um perto do fígado, um ligado ao estômago, dois ligados ao baço, um atrás de cada joelho, um perto do timo e um perto do plexo solar.

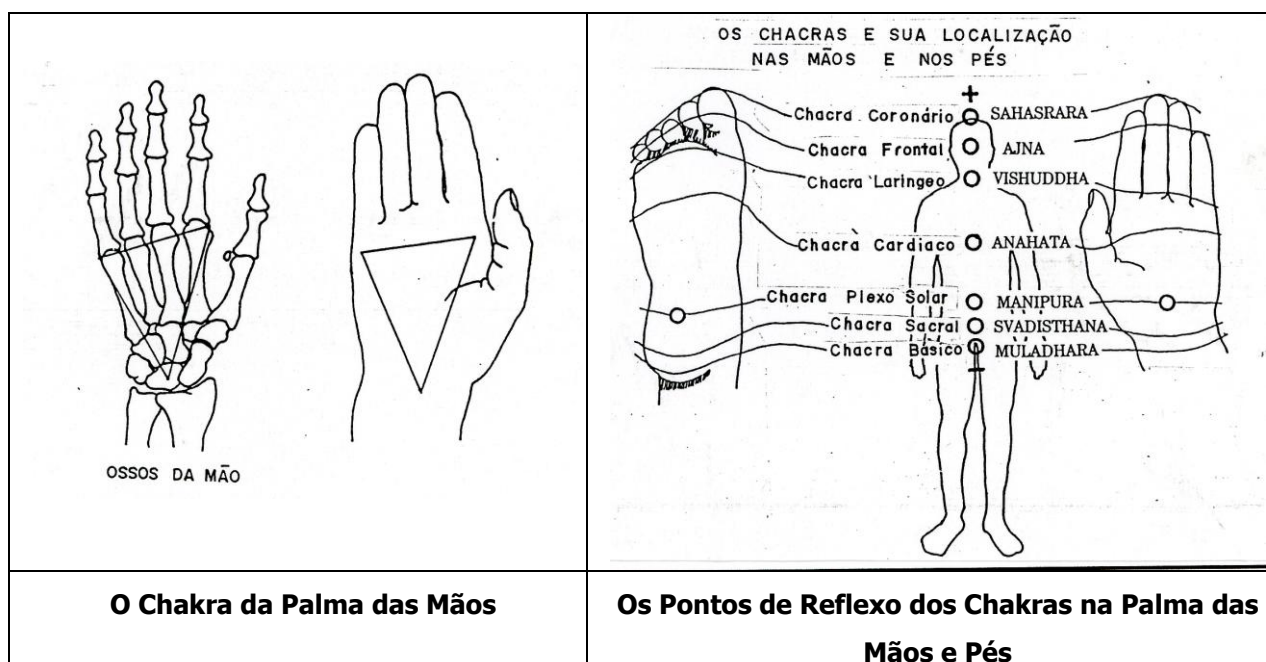
Cada um destes chakras tem uma função específica. Os dois chakras menores, localizados na palma das mãos, são muito importantes para a cura. Por isso o terapeuta deve escolher conscientemente para cada cliente, de acordo com as suas características e desenvolvimento

energético que se pretende obter, um dos dois circuitos básicos da massagem que foram enumerados anteriormente.

O CHAKRA DA PALMA DAS MÃOS

Este chakra é muito importante, pois funciona como um canal emissor das energias internas e cósmicas que circulam pelos canais internos do corpo e como fonte de assimilação das energias da natureza e cósmicas. Para o terapeuta, que trabalha principalmente com a irradiação de energia e luz através da sua mão, ele é o principal canal que vai transformar a energia do seu cliente. Ele é a extensão pela qual o tratamento se torna possível.

É, enfim, o instrumento por onde as energias divinas se exteriorizam de forma concreta, a extensão do ser humano.



OS PONTOS DE REFLEXO DOS CHAKRAS NO CORPO FÍSICO

Os chakras possuem pontos de reflexo na palma das mãos, pés e alto da cabeça (ver os esquemas de reflexo dos chakras na palma das mãos, pés e alto da cabeça). Uma boa massagem nesses pontos dinamiza os chakras actuando sobre os órgãos a ele correspondentes.

As glândulas, bem como todos os órgãos do corpo humano reflectem-se em determinadas zonas do corpo: nas mãos, nos pés, nas orelhas e nos olhos. Portanto, quando massajamos estas zonas podemos reequilibrar glândulas e órgãos e eliminar o excesso de toxinas.

A massagem Ayurvédica ao recentralizar, reequilibrar e dinamizar energeticamente os chakras, obtém como resultado o retorno da saúde em todos os órgãos do corpo físico.

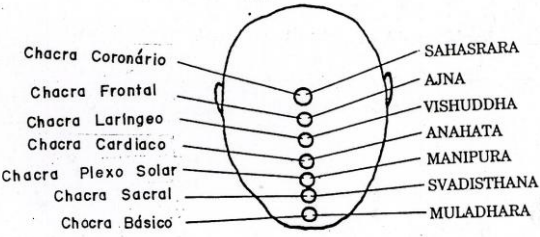
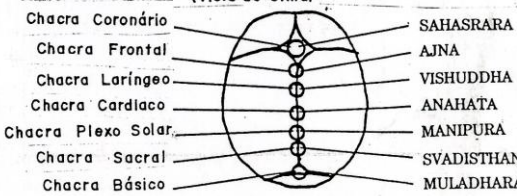
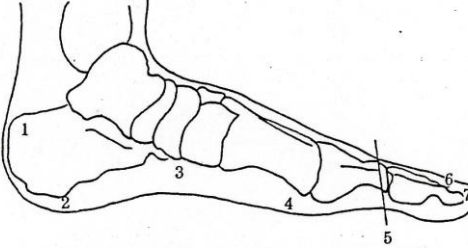
Na terapia Ayurvédica tanto o paciente quanto o terapeuta recebem benefícios quando da realização da massagem.

REFLEXO DOS CHAKRAS NO ALTO DA CABEÇA

Um tratamento progressivo e prolongado com a terapia Ayurvédica auxilia na abertura do 7º chakra e no desenvolvimento e abertura de uma série de pequenos vórtices de energia situados na cabeça e no

rosto. A massagem Ayurvédica no final da sessão actua incisivamente na cabeça e no rosto procurando reacender esses pequenos pontos.

A abertura desses pequenos vórtices é primordial para um maior desenvolvimento espiritual e para uma nova inserção do ser de forma integral e plena na vida física. Os olhos serão o ultimo ponto a ser massajado. A estimulação dos olhos e pálpebras auxiliam enormemente a abertura do 6º e 7º chakras e podem activar, caso o paciente tenha um bom estado de relaxamento no globo ocular, a 3ª visão para o plano espiritual.

LOCALIZAÇÃO DOS CHACRAS NO CRÂNIO (vista de cima)  LOCALIZAÇÃO DOS CHACRAS NO CRÂNIO DE UMA CRIANÇA RECÉM NASCIDA E A FONTANELE (vista de cima) 	 <table border="0"> <tr> <td>1. Chakra Básico</td><td>MULADHARA</td></tr> <tr> <td>2. Chakra Sacral</td><td>SVADISTHANA</td></tr> <tr> <td>3. Chakra Plexo Solar</td><td>MANIPURA</td></tr> <tr> <td>4. Chakra Cardíaco</td><td>ANAHATA</td></tr> <tr> <td>5. Chakra Laríngeo</td><td>VISHUDDHA*</td></tr> <tr> <td>6. Chakra Frontal</td><td>AJNA</td></tr> <tr> <td>7. Chakra Coronário</td><td>SAHASRARA</td></tr> </table>	1. Chakra Básico	MULADHARA	2. Chakra Sacral	SVADISTHANA	3. Chakra Plexo Solar	MANIPURA	4. Chakra Cardíaco	ANAHATA	5. Chakra Laríngeo	VISHUDDHA*	6. Chakra Frontal	AJNA	7. Chakra Coronário	SAHASRARA
1. Chakra Básico	MULADHARA														
2. Chakra Sacral	SVADISTHANA														
3. Chakra Plexo Solar	MANIPURA														
4. Chakra Cardíaco	ANAHATA														
5. Chakra Laríngeo	VISHUDDHA*														
6. Chakra Frontal	AJNA														
7. Chakra Coronário	SAHASRARA														
Localização dos Chakras e da Fontanele no Cranio de uma Criança Recém-Nascida	Reflexo dos Chakras nos Pés														

REFLEXO DOS CHACRAS NOS PÉS

Os chakras, como já dissemos, reflectem-se também nos pés.

Dores em determinados lugares dos pés denotam problemas no chakra que ali tem o seu reflexo e problemas nos órgãos a ele correspondentes. Muitas das meditações Budistas acentuam a importância dos pés, pois a circulação energética no corpo todo depende da activação das energias dos pés, ou seja, a activação das energias reflectidas nos pés dinamiza os vórtices energéticos superiores, abrindo-os para os campos mais subtis.

VÓRTICES DE ENERGIA COMPANHEIROS AOS CHAKRAS PRINCIPAIS

Os chakras principais centrais possuem ao seu redor chakras companheiros. A sua função é auxiliar o principal na gestão das energias que circulam pelo campo energético do indivíduo. Os deslizamentos direccionados que a massagem Ayur-Védica utiliza dinamiza-os e recoloca-os em plena função descongestionando os órgãos a ele ligados. As figuras que mostramos a seguir mostram alguns dos chakras principais e seus companheiros.

O OLHO PSÍQUICO E O OLHO SUB CONSCIENTE

Os pontos energéticos do corpo humano, como já explicitado, ligam-nos aos mundos subtis. Nosso rosto e cabeça possuem pequenos vórtices que nos auxiliam na comunicação com esses mundos. A massagem Ayur-Védica progressivamente auxilia na abertura desses vórtices sem provocar distúrbios energéticos.

OUTROS CHAKRAS QUE SÃO ACTIVADOS COM A MASSAGEM AYURVÉDICA:

CHAKRAS CARDIACOS: A massagem nas costas e coluna direcciona a energia da vida de forma ascendente, do 1º ao 7º chakra, activando indirectamente a abertura dos chakras cardiacos. A massagem no peito actua directamente na abertura desses vórtices. O chakra cardíaco purifica as energias grosseiras do corpo energético transferindo-as para os corpos subtis superiores.

CHAKRAS DOS COTOVELO: São activados indirectamente com a massagem nas costas e directamente quando massajamos o braço.

CHAKRA DOS JOELHOS: São activados directamente quando massajamos as pernas e os joelhos.

CHAKRA DAS OMOPLATAS: São activados quando massajamos as costas e principalmente quando procuramos soltar as omoplatas com massagens e manobras específicas.

MEDITAÇÃO MANTRICA PARA ACTIVAÇÃO E ALINHAMENTO DOS CHAKRAS E PURIFICAÇÃO DOS 7 CHAKRAS E DAS 7 CAMADAS DO CAMPO ÁURICO

Recomendamos que se pratique a seguinte meditação durante, pelo menos, 11 dias seguidos. Escolha, para praticá-la, um local silencioso que tenha alguns cristais limpos e programados para esse fim. Pode-se colocar também uma musica de fundo que facilite o processo. Escolha uma das sequências mantricas abaixo indicadas:

SEQUÊNCIA MÂNTRICA TRADICIONAL N.º 1:

LAM VAM RAM YAM AM OM **AUM**

SEQUÊNCIA MÂNTRICA TRADICIONAL N.º 2:

LA BA RA YM HÁ AH OM

SEQUÊNCIA MANTRICA INDICADA POR YOGI BHAIJAN:

RA MA DA SA SA SE SO HUNG

Recomendamos que se pratique da seguinte forma: sente-se com as pernas cruzadas, costas erectas, mãos nos joelhos. Forme um círculo com o polegar e o indicador e mantenha os outros 3 dedos erectos. Cotovelos esticados, queixo para dentro, olhos fechados e voltados para cima na direcção do terceiro olho. Inspire e repita o mantra numa respiração. Escolha o tom. Pratique sem interrupção procurando cantá-la em voz alta ou mentalmente durante 11 minutos. No final, inale e medite por alguns minutos em silêncio, deite-se e relaxe por alguns minutos. Alongue-se e levante-se de forma lenta.

AS VÉRTEBRAS E SUA RELAÇÃO COM OS ÓRGÃOS

O esquema a seguir apresentado, que não substitui o diagnóstico médico, ilustra as associações vértebra-órgão com os possíveis desequilíbrios que podem ocorrer.

VÉRTEBR A	ÁREAS	EFEITOS
1ª CERVICAL	Fornecimento de sangue para a cabeça, glândulas pituitária, couro cabeludo, ossos da face, cérebro, ouvido interno e médio, sistema nervoso simpático	Dores de cabeça, nervosismo, insônia, resfriados, hipertensão arterial, enxaquecas, esgotamento nervoso, amnésia, cansaço crônico, vertigens
2ª CERVICAL	Olhos, nervos ópticos, nervos auditivos, sinus, ossos mastóides, língua, porção anterior da cabeça	Problemas sinusiais, alergias, estrabismo, surdez, problemas visuais, dores de ouvido, desmaios periódicos, casos de cegueira
3ª CERVICAL	Bochechas, ouvido esterno, ossos da face, dentes, Nervos tri-facial	Nevralgia, neurites, acne ou espinhas, eczema
4ª CERVICAL	Nariz, lábios, boca, tubo eustaciano	Febre do feno, secreções, perda da audição, adenoides
5ª CERVICAL	Cordas vocais, glândulas do pescoço, faringe	Laringite, rouquidão, condições relacionadas com a garganta, como dores ou amigdalite
6ª CERVICAL	Músculos do pescoço, ombros e tonsilas	Rigidez do pescoço, dor na porção superior do braço, amigdalites, coqueluche
7ª CERVICAL	Glândula tireóide, bolsa da região dos ombros, cotovelos	Bursites, resfriados, condições da tireóide
1ª TORÁCICA	Porção do braço abaixo do cotovelo, incluindo mãos, punhos e dedos, esôfago, traquéia	Asma, resfriados, dificuldades respiratórias, respiração superficial, dores na região inferior dos braços e mãos
2ª T	Coração, incluindo válvulas envoltórias, artérias coronárias	Condições funcionais do coração, determinadas condições do tórax, dor na região superior das costas
3ª T	Pulmões, brônquios, pleura, tórax, peito	Bronquites, pleurites, pneumonia, congestão
4ª T	Vesícula biliar, duto biliar comum	Condições da vesícula biliar, icterícia, herpes zoster
5ª T	Fígado, plexo solar, circulação sanguínea	Condições do fígado, febre, hipertensão arterial, anemia, circulação deficiente, artrites
6ª T	Estômago	Problemas gástricos, incluindo nervos, indigestão, pirose, dispepsia
7ª T	Pâncreas, duodeno	Úlceras, gastrites
8ª T	Baço, diafragma	Soluços, baixa resistência
9ª T	Glândula adrenal e supra renal	Alergias, urticárias
10ª T	Rins	Problemas renais, rigidez das artérias, cansaço crônico, nefrite
11ª T	Rim, uréter	Condições da pele, como acne, espinhas eczemas, furúnculos
12ª T	Intestino delgado, circulação linfática	Reumatismo, acúmulo de gases, certos casos de esterilidade
1ª LOMBAR	Intestino grosso, anéis inguinais	Constipação, colites, disenteria, diarreia, alguns casos de ruptura da hérnia
2ª L	Apêndice, abdômen, região superior das pernas	Cãibras, dificuldade respiratória, acidose, veias varicosas
3ª L	Órgãos sexuais, útero, bexiga, joelhos	Problemas vesicais e menstruais, como dor ou períodos irregulares, corrimento, nictéria, impotência, muitas das dores no joelho
4ª L	Próstata, músculos da região lombar, nervo ciático	Ciática, lumbago, dificuldade, dor, dificuldade ou aumento da frequência urinária, dores nas costas
5ª L	Porção inferior das pernas, tornozelos, pés	Circulação deficiente nas pernas, inchaço dos tornozelos, fragilidade ou tornozelos arqueados, pernas frias, fragilidade das pernas, câibras
SACRO	Ossos do quadril, nádegas	Condições do sacro ilíaco, curvaturas espinhais
CÓCCIX	Reto, ânus	Hemorróidas, dores na base da coluna ou ao sentar-se

BLOQUEIOS E DESEQUÍLIBRIOS QUE SE APRESENTAM NO CORPO FÍSICO E ETÉRICO

De acordo com as teorias da biopsicoenergética todo o organismo vivo mobiliza, metaboliza e/ou libera certo tipo de modalidade energética, pelo menos dentro da faixa electromagnética ou etérica. Assim, os seres humanos com as suas acções, pensamentos, e emoções impregnam o meio ambiente em que vivem com as vibrações, cuja frequência e forma de onda são funções directas das causas que lhes dão origem, cada uma no seu nível correspondente. Esses padrões gravados exercem influência – positiva ou negativa – sobre a própria pessoa que os gerou e também sobre os outros seres presentes no recinto. Dependendo da qualidade das energias ambientais, surgem os chamados bloqueios, perigosas situações energéticas que chegam a comprometer a saúde e o equilíbrio físico, psíquico e mental.

O corpo humano está continuamente a interagir-se com as energias ambientais do campo físico comum (magnetismo, electromagnetismo, acções entre campos, ondas de rádio, etc.), pelas constantes formas de pensamento que são produzidas, pelos alimentos que são ingeridos, etc.. Todos estes factores, aliados a constante agitação da vida quotidiana, acarretam acções ou reacções, transformações, ou qualquer outro fenómeno no ser humano. Há ainda que considerar que todos os seres podem influir ou sofrer influência, para além dos factores já enunciados, também em relação às energias de outros seres, devido à inter-relação.

Devemos notar também que existem diferenças quanto ao grau ou intensidade com que uma energia ambiental pode actuar no campo da energia humana. O grau de actuação determina o surgimento de alguma forma de bloqueio. Quando estes surgem e alcançam, em sua manifestação, o nível de penetração, seja dentro do campo energético etérico ou perietérico humano ou até mesmo o corpo físico, a sua remoção só será possível com tratamentos específicos. A massagem Ayurvédica pode ser um dos meios para os remover. Neste caso o terapeuta deverá identificá-los de forma a poder actuar mais consistentemente na sua remoção e também para aconselhar o cliente quanto ao tratamento a seguir, coisas a evitar, etc..

TIPOS DE BLOQUEIOS

Os bloqueios energéticos podem ser classificados em três tipos:

1 - Autogerados: são produzidos pelo próprio ser, por confundir realidades com fantasias, criando atmosferas ou mundos impossíveis ou impróprios, os quais determinam, nos seus diversos campos e vórtices, a criação de circuitos energéticos que se comportam e produzem resultados análogos às suas causas. Estes bloqueios energéticos podem ocorrer devido a uma atitude mal encaminhada, negativa, que se transforma em seguida num mecanismo, à força de repetição. A remoção deste bloqueio é lenta e difícil e depende da transformação de muitos padrões de conduta e do pensamento de quem os produziu.

2 - Externos: são provenientes de energias ambientais, externas ao ser, que se fixam ou penetram de forma inconsciente; isso acontece porque as condições do indivíduo o permitem, tanto pelo seu estado de desequilíbrio como pela sua conduta. Este tipo de bloqueio é o mais fácil de ser curado.

3 - Dirigidos: são provenientes do exterior, e especificamente orientados para penetrar em algum ou alguns sítios do campo energético de determinado indivíduo; o direccionamento comporta e evidencia a intervenção consciente e mais ou menos inteligente de quem produz ou tenta produzi-lo. A sua remoção é a mais difícil de ser feita.

EXEMPLOS DE BLOQUEIOS

Para que o aluno tenha uma ideia dos diversos tipos de bloqueio comentados neste tópico apresentamos alguns exemplos típicos, estudados pela biopsicoenergética, que são muito comuns nos dias de hoje.

EXEMPLO N.º 1

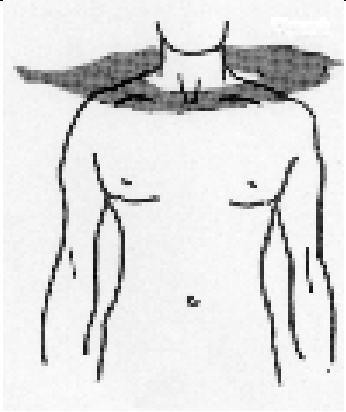
No primeiro exemplo vemos um grande bloqueio na parte superior onde existe uma opacidade que penetra sobre a zona laríngea. Este tipo de bloqueio pode ser considerado como sendo típico de energias ambientais que impõem ideias, ou autoridade, ou que impedem a livre expressão do indivíduo. Os seus

efeitos traduzem-se em inibições frente a certas pessoas ou situações, e também em dificuldades respiratórias, sensações opressivas momentâneas, etc..

Temos outro bloqueio na zona do plexo solar, nível do vórtice solar externo e zonas próximas. É o tipo de bloqueio típico de ambientes hospitalares. Traduz-se geralmente numa absorção de energia, ou drenagem da mesma, a que pode somar-se, paradoxalmente, uma dificuldade do indivíduo afectado em absorver energia natural por meio deste centro de energia.

EXEMPLO N.º 2

No segundo exemplo temos um exemplo de bloqueio grave que atinge a zona laríngea. Não é ainda um bloqueio de forma dirigida mas que assume um nível de imposição autoritária de um ser em relação a quem o sofre.

	
Exemplo N.º 1	Exemplo N.º 2

EXEMPLO N.º 3 No terceiro exemplo temos um bloqueio energético que pode influir no funcionamento normal do corpo etérico.

Ele atinge o nível das camadas internas do corpo etérico onde se verifica que decorre o desprendimento do ápice do chakra coronário do seu receptáculo natural, que é a glândula pineal.

O ápice do chakra, neste caso, toma contactos esporádicos, e a consciência do indivíduo afectado flutua conforme os conteúdos ambientais que coexistem ou se alternam, tomando lugar sobre a glândula, transferindo-lhe energia. O quadro resultante assemelha-se, conforme o grau, ao das esquizofrenias, fobias, etc.. Pode tratar-se de um bloqueio externo ou de um bloqueio dirigido.

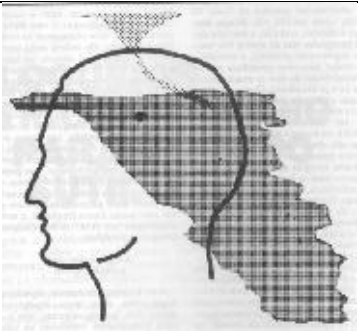
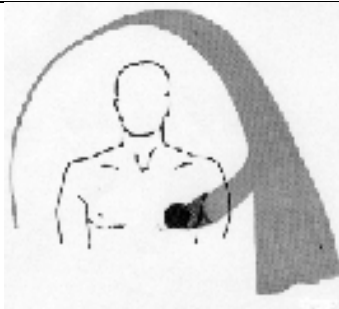
EXEMPLO N.º 4

No quarto exemplo há também um bloqueio que pode influir no funcionamento normal do corpo etérico.

Neste caso mostra-se as reacções que podem ocorrer em pessoas sensíveis que tomam contacto com objectos velhos ou antigos.

O chakra cardíaco é o ponto mais vulnerável a ser atingido. Esse contacto produz nas pessoas imagens fantasmagóricas e até mesmo certas percepções, tais como o soar de campainhas, rangidos, passos, ruídos, etc..

Este tipo de bloqueio poderá se complicar se a pessoa se identificar com a situação aceitando-a como sua. A aura fica com cascões ou larvas que circulam pela aura a partir do coração.

	
Exemplo N.º 3	Exemplo N.º 4

EXEMPLO N.º 5

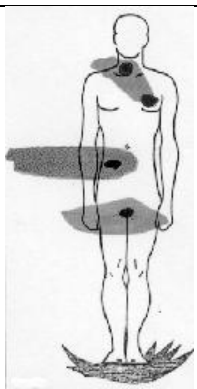
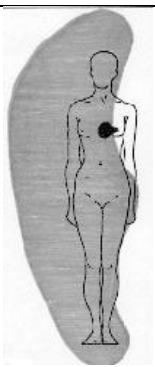
No quinto exemplo temos também um bloqueio que pode influir no funcionamento normal do corpo etérico.

Neste caso, vemos que a energia do vórtice cardíaco se projecta bloqueando o vórtice laríngeo. É um caso típico de autobloqueio, sobretudo nos seres que possuem valores relativamente altos. Isto significa que quando o indivíduo quer explicar algo por meio da palavra, muito facilmente confunde ou transmite impropriamente o que quer expor.

Este autobloqueio é comumente acompanhado de inflexões vocais vacilantes e de energias expulsadas pelos vórtices dos ombros e dos ouvidos, no mesmo sentido em que se dá o bloqueio. Vemos também na figura, um bloqueio que produz uma opacidade na zona hepática. Este relaciona-se com os vórtices hepáticos aferente e eferente, embora mais no nível perietérico. É também um bloqueio externo típico de hospitais. Vemos ainda na figura uma opacidade sobre a zona do vórtice sacro. Trata-se de um bloqueio externo próprio de pessoas que frequentam ambientes de psicologia erótica e pornográfica (casas de encontros, *strip-teases*, prostíbulos, etc.).

EXEMPLO N.º 6

No sexto exemplo temos também um bloqueio que pode influir no funcionamento normal do corpo etérico. Neste caso decorreu um deslocamento da energia perietérica. É um tipo particular de bloqueio, e a sua etiologia é variada. As zonas desprotegidas ficam sem "combustível" e os vórtices devem orientar-se de forma anômala para continuar tomando-a.

	
Exemplo N.º 5	Exemplo N.º 6

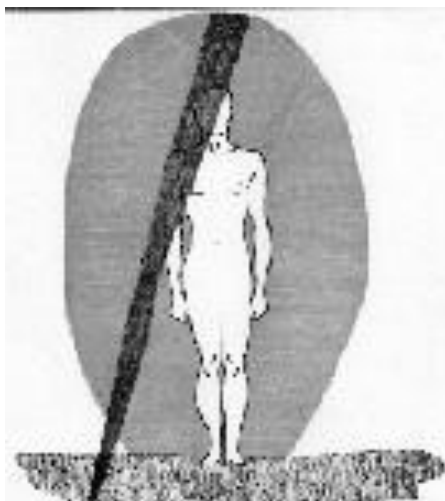
Vemos na ilustração 6 que a zona do ombro e do braço esquerdo está desprotegida; o chacra cardíaco orienta-se com a sua boca para o lugar onde ainda existe energia perietérica. Esta configuração produz sintomas e quadros muito variados, conforme o grau e a mobilização da energética deslocada.

EXEMPLO N.º 7

Na sétima ilustração mostramos também um bloqueio que pode influir no funcionamento normal do corpo etérico.

Mostramos apenas um dos casos típicos de um bloqueio dirigido. Apresenta-se na forma de larva que vai crescendo com o apoio e alimentação do plano energético terra, e que vai penetrando no campo perietérico, sempre com sentido ascendente.

Na figura vê-se que o bloqueio foi ascendendo sucessivamente até ingressar no vórtice do ombro direito, com a consequente diminuição da efectividade desse braço, e em seguida até a zona cerebral, o que geralmente é acompanhado pela diminuição da audição do ouvido direito, menor visão do olho direito, aumento na queda de cabelos do lado direito, etc.. Na ilustração vemos um caso sério que já está avançado. A sua progressão cobre a zona craniana originando os mesmos efeitos descritos para o exemplo 3.



Exemplo N.º 7

O leitor poderá ver outros tipos de bloqueios nos livros de Barbara Ann, principalmente no intitulado "Mãos de Luz" da editora Pensamento.

Convém lembrar que a manutenção de uma conduta e um padrão de vida vibracional sadios afastam as influências bloqueantes e negativas, sejam elas externas, inconscientes ou dirigidas. Se o potencial vibracional do chacra mais débil do indivíduo é superior ao potencial vibracional da energia bloqueante, não ocorrerá nenhum bloqueio. Deve também precaver-se de influências ambientais desarmônicas por meio da elevação do índice energético vibracional com o uso de defumadores de sândalo, incensos, etc., segundo o clima que queira impor-se ao ambiente ou recinto.

Para além das indicações sugeridas até aqui, convém lembrar que a massagem Ayurvédica é uma excelente terapia para aumentar o padrão vibracional da pessoa, colocando os vórtices dos chakras em rotação, equilíbrio, alinhando-os e contribui de forma muito promissora com a remoção dos diversos tipos de bloqueio que se apresentam nos corpos físicos e subtis.

A MASSAGEM AYURVÉDICA E OS MERIDIANOS DA MEDICINA CHINESA

Uma das perguntas mais comuns nos cursos de formação que ministro é se a massagem Ayur-Védica actua nos pontos dos meridianos. A massagem Ayur-Védica actua principalmente nos chacras magnos e seus vórtices energéticos auxiliares e também nos meridianos, contudo, de forma global, ou seja, não mexe nos pontos tal como o “Shiatsu” ou o “Do in”. Ela manipula o meridiano em toda a sua extensão, e consequentemente desbloqueia todos os pontos energéticos. Por outro lado é de grande valia conhecer também a relação entre os meridianos e os pulsos. Ambos são de grande valia para o terapeuta durante a realização do tratamento pois pode indicar com maior precisão qual deles está em desequilíbrio.

A MEDICINA AYURVÉDICA E OS PONTOS MARMAS

De acordo com o *Sushruta Samhita* existem 107 *marmas* no corpo humano. Os *marmas* referem-se às firmes uniões e pontos de encontro dos cinco princípios orgânicos: músculos (*mansa*), vasos (*sira*), ligamentos (*snayu*), ossos (*ashti*) e articulações (*sandhi*). Essas uniões constituem o assento da força vital ou prana.

O *Sushruta Samhita* classifica ainda os *marmas* de acordo com sua relação com a força vital. Os pontos *marmas* são tão importantes que uma ferida num ponto *marma* que se encontre numa mão ou numa perna pode conduzir à morte. O estudante que quiser aprofundar este assunto poderá ler volume 2, capítulo 6, versículos 2-9 do *Shshuta Samhita*.

De qualquer maneira, o massagista não tem obrigação de se aprofundar sobre este tema. Deve apenas conhecer que os pontos *marmas* sustentam o organismo: *Vayu* - elemento do ar, *Soma* - princípio lunar do organismo, *Tejas* - princípio ardente do organismo, *Gunas (Sattva)* - a criação, *Rajas*, a conservação, *Tamas* - a desintegração.

Qualquer lesão num dos *marmas* pode conduzir a deformidades, dor, delírio, alucinação, estupor, a um estado de coma ou morte. Também conduz a enfermidades mentais, assim como a perda de um ou mais *dhatus*, que são os responsáveis pela manutenção das funções dos diferentes órgãos, sistemas e partes vitais do corpo, que podem ocasionar os mesmos problemas.

A massagem, em geral, nutre os *dhatus*, a massagem dos *marmas* proporciona uma ajuda específica para eles e, portanto, para todo o organismo.

TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA E VIBRAÇÕES

A massagem é uma interacção de energias entre dois corpos que são também duas forças electromagnéticas. Quando damos ou recebemos uma massagem, não só manipulamos músculos, pele e ossos, como também trabalhamos com as energias, tanto físicas como mentais. Existe uma clara interacção entre a psique do que dá a massagem e a do que recebe. Para compreendermos isto, necessitamos recordar uma lei muito simples: a energia flui do nível superior para o inferior.

O processo da transferência de energia é muito simples. A pessoa que se submete à massagem deixa que o seu corpo entre em estado de relaxamento. Consequentemente o seu sistema defensivo cede com facilidade permitindo assim que a energia do massagista se introduza no seu corpo e seja absorvida por ele. Se existir qualquer tipo de resistência de uma das partes, a massagem não produz muitos benefícios. O paciente deve permitir que o massagista trabalhe sem oferecer resistência. Deste modo, o profissional trabalhará com afecto e cuidado, com o fim de manter o seu nível vibratório alto para não ficar influenciado por fantasias ou pensamentos pessoais de nenhum tipo. Devido ao seu compromisso com este acto de serviço, o massagista está automaticamente num nível superior ao do receptor. Desta forma, de acordo com a lei natural, a energia transmite-se do corpo do que executa a massagem até ao que recebe. Uma fina descarga de energia eléctrica flui da ponta dos dedos e palma da mão do profissional e é imediatamente absorvida pela pele do paciente. Através de uma fina rede de nervos subtis chamados *nadis*, especificamente os *nadis pranavaha manovaha*, descarregam-se e absorvem a energia *pranica* e a energia psíquica. Os *marmas* possuem, neste sistema, um importante papel na absorção da energia e, portanto, do campo psicossomático do receptor da massagem. Às vezes, durante uma sessão de massagem dos *marmas*, eliminam-se os bloqueios de energia e o paciente experimenta trocas emocionais, como alegria, aflição e alívio.

Se o massagista não permanece centrado durante a massagem e se deixa levar pelo mundo da fantasia, estas transmitem-se de forma imediata para o paciente. Se o massagista começa a pensar nos seus próprios problemas, o receptor começará a sentir problemas de uma natureza similar.

Os massagistas que tem adoptado esta prática como uma profissão e atendem muitas pessoas diariamente, podem restabelecer a sua energia depois de cada massagem. Isto consegue-se ingerindo alimentos nutritivos como o leite fresco, yogurte ou alguma bebida produzida a partir do arroz, frutos secos e uvas passas e dedicando um tempo para o relaxamento antes e depois de cada sessão. Colocar-se na posição que se chama a postura do cadáver (*shavasana*), respirar profundamente e meditar ouvindo o som da própria respiração durante 15 minutos devolverá ao praticante toda a sua energia. Escutar música relaxante, durante a massagem e o relaxamento é muito útil. O massagista deve dar-se uma automassagem em seus dedos e realizar movimentos rítmicos com as munhecas antes de cada sessão.

Assinala-se ainda que os praticantes de massagem terapêutica podem ficar susceptíveis de colher a enfermidade do cliente se não estiverem mentalmente fortes e não possuam o conhecimento e a força necessária para curar a doença. O estudo da constituição do corpo humano e o conhecimento dos *marmas* e óleos específicos ajudam o massagista a concentrar-se e trabalhar com segurança.

A atitude do massagista desempenha um papel muito importante durante a massagem. Se o objectivo é só o de ganhar dinheiro, o profissional cansar-se-ia. Pelo contrário, se o massagista ao dar a massagem tem consciência da responsabilidade do seu trabalho considerando a sua profissão como um meio para servir a humanidade, então a experiência será alegre e menos cansativa, ele desfrutará. O massagista deve estar física e mentalmente são. Uma pessoa com vibrações suaves dará uma massagem especialmente benéfica. Não se deveria dar massagem a uma pessoa com a qual não se simpatiza à primeira vista e vice-versa.

A famosa história épica sobre a vida de *Rama* que é contada no *Ramayana*, é um exemplo fabuloso sobre a importância da massagem na recuperação do corpo cansado. Segundo este épico as facções inimigas perderam inumeráveis batalhas simplesmente porque donzelas massajavam os fatigados soldados, às vezes várias delas de uma só vez. Logo a seguir tomavam banho no rio para se refrescarem. Elas, tal como as descreve *Valmiki*, tinham corpos esbeltos e bem proporcionados e olhos que resplandeciam com a luz.

Actualmente, na Índia considera-se o poder curativo do tacto como potencializador do prazer sexual e, por isso, os homens geralmente massajam os homens e as mulheres massajam-se entre si. Deste modo evita-se o desgaste de energias que implicam fantasias sexuais. Para evitar as fantasias quando se dá uma massagem ao outro sexo, o praticante deve concentrar-se na própria respiração, no ritmo da mesma e nas batidas do coração. Se a massagem trabalha como um instrumento para transferir a Divina energia para o corpo do receptor, esta atitude modifica o nível de energia do corpo do receptor, por isso não vai dar vazão às fantasias.

Na vida familiar é muito importante que as crianças e os jovens façam massagem nas pessoas mais velhas. Se ensinarmos esta arte para as crianças, podemos praticá-la como entretenimento em qualquer momento. Sua energia é pura – não se entregam a fantasias e nem sofrem de perda de energia.

Os profissionais da massagem deveriam descobrir o que lhes faz perder energia e que tipo de receptores lhes despertam a inspiração. Só através da experiência podem aprender o que devem evitar e como proporcionar mais benefícios sem se esgotarem. Podem massajar membros de ambos os sexos, se eles não lhes causam nenhuma dificuldade. Se se experimenta perda de energia ou cansaço, devem evitar as fantasias. De forma igual aos médicos, os massagistas devem adoptar uma atitude neutra ao tocar em pessoas de qualquer sexo. Como regra geral é preferível não aplicar massagem quando o próprio nível de energia é baixo.

Podemos concluir que a massagem é um serviço, um *dharma* - virtude religiosa superior. Um massagista deve converter-se num servidor desinteressado e deveria trabalhar sem ter em conta o seu ego.

A MASSAGEM E O SISTEMA LINFÁTICO

A massagem trabalha directamente e simultaneamente nos três sistemas do corpo humano: o sistema sanguíneo / vascular, o sistema nervoso e o sistema linfático.

Ainda que aparentemente a massagem trabalhe unicamente com o toque na pele e na musculatura, na realidade ela actua em todos os vasos do corpo. A Ayurvédica considera o corpo humano composto por inumeráveis canais – *srotas* - que nutrem os diversos tecidos do corpo. Estes canais estão conectados com os pontos *marmas* e com os órgãos internos. A massagem estimula a actividade neles e melhora a circulação dos nutrientes que através deles se dirigem em direcção aos órgãos correspondentes. Segundo a Ayurvédica, estes canais transportam a *vayu* – ar -, *pitta* – bilis - e *kapha* – mucosidade, e, portanto, são o sustento do organismo humano. Qualquer obstrução no fluxo deste canais pode conduzir a uma enfermidade. Receber regularmente uma massagem pode manter a circulação dos fluidos vitais.

O coração trabalha como uma estação central de bombeamento, fazendo circular o sangue carregado com ricos nutrientes por todo o organismo. O sistema nervoso reage e transmite os estímulos e informações para todo o corpo, permitindo com que ele se adapte ao que acontece no exterior. O sistema linfático não dispõe de um centro de controle principal. Por esta razão, o sistema mais directamente influenciado pelo sistema de massagem é o que mais vai ser prejudicado se forem aplicadas técnicas que não são apropriadas.

A Ayur-Védica considera que a linfa é de natureza *kapha*. A palavra *kapha* traduz-se geralmente como “mucosidade” ou “fleuma”, porém, o seu significado engloba também os líquidos linfáticos. *Shlesaka kapha*, uma combinação de líquidos linfáticos e sinoviais que se encontram em todas as articulações do corpo - é um líquido doce, pegajoso, frio, suave e branco que actua como lubrificante. Ajuda a reduzir a fricção que se produz numa articulação protegendo-a do desgaste e de possíveis rompimentos. *Shleska kapha* flui também pelo sistema nervoso, proporcionando aos nervos a capacidade de receber e transmitir sinais. Colabora no desenvolvimento dos anti-corpos e por isso é fundamental para o sistema imunológico. O sistema que actua através dos vasos e gânglios restitui as proteínas que se perderam dos capilares sanguíneos que se encontram nos espaços intercelulares e transfere as graxas e lubrificantes absorvidos desde os intestinos para todo o sistema circulatório.

O sistema linfático não é um sistema independente. Corre em paralelo com o sistema circulatório. O sangue recolhe oxigénio dos pulmões, nutrientes do trato gastrointestinal e hormonas das glândulas endócrinas, conduzindo-as para todos os tecidos do corpo, desde os capilares sanguíneos até aos líquidos dos tecidos. Uma vez ali, as substâncias nutritivas transportam-se para as células tecido onde se produz um intercâmbio para eliminar os dejectos. A linfa recolhe então os materiais do líquido do tecido, elimina as bactérias e devolve-as ao fluxo sanguíneo. O tecido linfático que se encontra nos gânglios, o baço e a glândula timo têm a função de proteger o corpo de células e substâncias estranhas. O sistema linfático, com o seu exército de linfócitos, fagócitos e tecidos produtores de anti-corpos, oferece uma linha directa de defesa para o corpo.

O sistema linfático não é um circuito complexo, mas sim de uma direcção: o líquido penetra no fluxo sanguíneo, porém o sangue ou a linfa do sangue não pode introduzir-se nos vasos linfáticos. Os gânglios não contêm válvulas e distinguem-se de modo não uniforme no corpo. O massagista deve recordar-se de que os gânglios linfáticos, que produzem o líquido linfático, se encontram em redor das articulações do corpo. É possível os estimularmos massajando no sentido circular em redor das articulações. Ao friccionar profundamente uma articulação gera-se calor, melhora a circulação e faz com que o gânglio segregue o seu fluído; e, por sua vez, logra-se que as proteínas, a glicose, os minerais, o oxigénio e os anticorpos sejam absorvidos pelo sangue. Os gânglios linfáticos podem excitar-se com outras formas de calor externo, como uma sauna ou a aplicação de fomentos - calor local húmido.

Também é possível estimular este complexo sistema mediante a prática regular de exercícios com respiração profunda e pela compressão periódica dos gânglios linfáticos individuais ou os pontos *marmas*.

Quando se estimula o fluxo linfático com um óleo de massagem, o massagista pode dar vigor à química do sangue e ajudar a que o corpo se desintoxique por si mesmo, eliminando as toxinas através do suor e da urina. Desta forma, a massagem actua como um purificador da acumulação de toxinas no organismo. É importante notar ainda que, com o aumento do fluxo linfático, há uma diminuição do fluxo sanguíneo. Os médicos ayurvédicos geralmente aconselham a massagem para os pacientes que sofrem de problemas cardíacos e de tensão alta. É igualmente útil para quem padece de um fluxo sanguíneo lento já que estimula a circulação e melhora o fluxo de nutrientes em direcção ao sangue.

PONTOS MARMAS - CLASSIFICAÇÃO

Existem no corpo um total de 107 pontos *marmas*, assim distribuídos: vinte e dois encontram-se nas extremidades inferiores - onze em cada perna -, vinte e dois nos braços - onze em cada braço -, doze no peito e abdômen, catorze na coluna e trinta e sete na zona do pescoço e cabeça.

Portanto eles são divididos em cinco classes:

- **Onze *marmas mansa* – localizados nas articulações vulneráveis dos músculos**

Quatro *Talhridaya* / Quatro *Indravasti* / Um *Guda* / Dois *Stanrohita*

- **Quarenta e um *marmas sira* – localizados nas veias ou anastomosis**

Dois *Manya dhamni* / Dois *Neela dhamni* / Oito *Matrika* / Quatro *Sringataka* / Dois *Apanga* / Um *Nabhi* / Dois *Parshva sandhi* / Dois *Vrihati* / Quatro *Lohitaksha* / Quatro *Urvi* / Um *Sthapni* / Dois *Apastambha* / Um *Hridayam* / Dois *Phana* / Dois *Apalapa* / Dois *Stanmula*

- **Vinte e sete *marmas snayu* (uniões do ligamentos vitais)**

Quatro *Ani* / Dois *Vitapam* / Dois *Kakshadhara* / Quatro *Kuruchcha* / Quatro *Kurchshirah* / Um *Vastih* / Quatro *Kshipra* / Dois *Ansa* / Dois *Vidhuram* / Dois *Utkshap*

- **Oito *marmas asthi* – localizados nas uniões dos ossos**

Dois *Katika tarunam* / Dois *Nitambatwo* / Dois *Ansa phalak* / Dois *Shankh*

- **Vinte *marmas sandhi* – localizados nas uniões vulneráveis dos ossos**

Dois *Janu* / Dois *Kurpara* / Cinco *Simantakas* / Um *Adhipati* / Dois *Gulpha* / Dois *Manibandha* / Dois *Kukundaraya* / Dois *Avarta* / Dois *Krikatika*

NOMES E LOCALIZAÇÕES DOS MARMAS

OS ONZE MARMAS LOCALIZADOS EM CADA PERNA

1. *Kshipra* - entre o primeiro e segundo dedos do pé.
2. *Talhridaya* - em cada parte central da planta do pé.
3. *Kuruchcha* - na parte carnosa da planta do pé.
4. *Kurchshira* - no calcanhar e na borda exterior do pé.
5. *Gulpha* - atrás de ambos os lados da articulação do tornozelo.
6. *Indravasti* - na parte central da panturrilha.
7. *Janu* - na articulação do joelho.
8. *Ani* - em cima e nos lados da rótula.
9. *Urvi* - na parte central da coxa.
10. *Lohitaksha* - na região inguinal.
11. *Vitapam* - na raiz do escroto.

OS ONZE MARMAS SITUADOS EM CADA BRAÇO

1. *Kshipra* - entre o polegar e o indicador.
2. *Talhridayam* - na parte central da palma da mão.
3. *Kuruchcha* - em cima de *kshipra*, na raiz do polegar.
4. *Kurchshira* - na parte central da articulação do pulso, na base do polegar justamente debaixo do pulso.
5. *Manibhanda* - na articulação do pulso.
6. *Indravasti* - na metade do antebraço.

7. *Kurpara* - na parte interior da articulação do cotovelo.
8. *Kurpara* - na parte interna do braço, justamente debaixo do cotovelo.
9. *Urvi* - na metade da parte superior do braço.
10. *Lohitaksha* - na dobra da axila.
11. *Kakshadhara* - na axila.

OS DOZE MARMAS SITUADOS NO TÓRAX E NO ABDOMEN

1. *Guda* - na ponta do osso caudal.
2. *Vastih* - na bexiga.
3. *Nabhi* - no umbigo.
4. *Hridayam* - no apêndice xifóide.
- 5/6. *Stanmula* - embaixo do mamilo.
- 7/8. *Stanrohita* - acima do mamilo.
- 9/10. *Apalapa* - encima e na lateral da zona do mamilo.
- 11/12. *Apasrambha* - entre o mamilo e o esterno.

OS CATORZE MARMAS DA COLUNA

- 1/2. *Katika tarunam* - na base das nádegas e na crista pélvica.
- 3/4. *Nitamba* - na crista ilíaca exterior.
- 5/6. *Kukundaraye* - nas articulações sacro-ilíacas.
- 7/8. *Parshva sandhi* - em cima de *katika tarunam*, na cintura alta.
- 9/10. *Vrihati* - de ambos os lados da 10ª vértebra torácica.
- 11/12. *Ansa phalak* - nas omoplatas.
- 13/14. *Ansa* - nos ombros.

OS TRINTA E SETE MARMAS SITUADOS NO PESCOÇO E NA CABEÇA

- 1/2. *Neel dhamni* - na parte frontal da laringe.
- 3/4. *Manya dhamni* - de ambos os lados da tiróide.
- 5-12. *Ocho Siramatika* - nas artérias de ambos os lados do pescoço.
- 13/14. *Vidhuram* - embaixo das orelhas.
- 15/16. *Phana* - junto de cada orifício nasal.
- 17/18. *Apanga* - na borda exterior do olho.
- 19/20. *Avarta* - na parte exterior da sobrancelha.
- 21/22. *Shankh* - na fonte.
- 23/24. *Utkshepa* - em cima da orelha.
25. *Sthapni* - no terceiro olho.
- 26-30. *Simantakas* - nas articulações dos ossos do crânio.
- 31/32. *Krikatikas* - na base do crânio.
- 33-36. *Sringataka* - no paladar brando.
37. *Adhipati* - na coroa.

MASSAGEM AYURVÉDICA – KUNDALINI E OS SETE CORPOS DO CAMPO ÁURICO

A medicina ayurvédica possui na massagem corporal um grande factor de auxílio na prevenção de doenças e age, inclusive, para restabelecer o equilíbrio físico-mental-psíquico-espiritual do indivíduo. Ela harmoniza os corpos energéticos, previne doenças estimulando as defesas naturais do organismo, actua nos sistemas glandulares e endócrino, além de tratar das fraquezas gerais do coração, fadiga, desequilíbrios nervosos, perturbações mentais e emocionais, e harmonizar a sexualidade. É extremamente agradável e relaxante. Consiste numa técnica de massagem profunda aliada a manobras de tracção, alongamentos e estimulação de pontos de órgãos vitais auxiliando na elevação da energia Kundalini até ao chacra do coração (Anahata) para provocar a expansão da consciência.

Faz-se muitos alongamentos na coluna, que é por onde a Kundalini se manifesta, levando o paciente a ter "insights" dessa energia. Com o tempo, ocorre um aumento da intuição, clareza mental e o paciente passa a viver num estado de maior equilíbrio nos níveis físico, espiritual e psíquico.

A Kundalini é uma energia de vida com capacidade de provocar a elevação do ser.

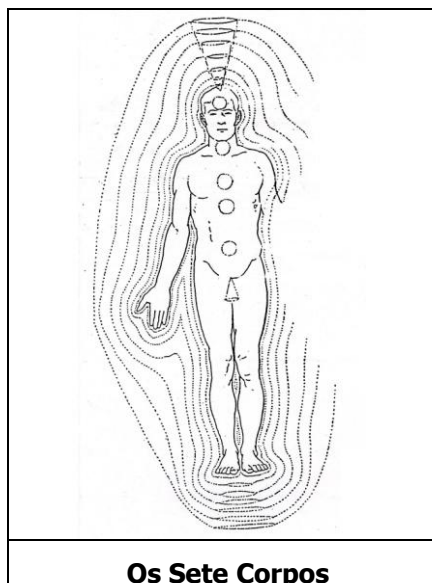
A partir das mãos do terapeuta, encontra-se toda uma série de correspondências com planos extrafísicos, níveis de consciência trabalhados pela massagem. As qualidades de cada dedo funcionam com esse propósito, e de acordo com os problemas da pessoa. Ou seja: o polegar está relacionado com o elemento éter e lida com a espiritualidade, o indicador, com o elemento ar e trabalha com o pensamento, o dedo médio, com o elemento fogo e relaciona-se com a iniciativa, o dedo anelar com o elemento água e lida com o amor, o sentimento; o dedo mínimo, com o elemento terra e trabalha com a sensação. Usa-se bastante a imposição das mãos, sendo que a postura do massagista deve favorecer o seu estado de meditação durante a prática, bem como activação dos seus próprios chacras – havendo uma sensível interacção energética entre massagista e massajado.

Outra forma de activar a kundalini é através da meditação. Qualquer uma das sequências mantricas que vimos anteriormente são extremamente poderosas neste sentido. A meditação é também um meio extremamente poderoso para reequilibrar os campos energéticos e purificar o carma da pessoa e, se aliadas com a prática da massagem surtem efeitos extremamente benéficos para equilibrar a pessoa em pouco tempo.

A Ayurvédica divide ainda o corpo humano físico e subtil em 7 níveis. São nestes níveis que um tratamento que a Medicina Ayurvédica e, principalmente, a massagem vai actuar.

Esses corpos interagem-se nos níveis interiores do corpo e nos níveis superiores extrafísicos. Todos estes corpos estão ligados entre si de forma intrínseca. No nível físico estão englobados os níveis mais densos e materiais até, inclusive, o plasma. Nos níveis subtis o primeiro a ser atingido é o próprio corpo físico com os seus sete sub-níveis até ao mundo do "eu sou" – sétimo corpo.

O próprio direccionamento energético que a massagem determina no corpo físico, atinge, consequentemente, os níveis dos corpos subtis. As diversas manipulações e movimentos executados pela massagem reinserem os sete níveis dos corpos físico e subtil dentro dos padrões de vibração harmónica do Cosmos. Todos os corpos se reanimam e passam a funcionar, se estiverem desarmónicos, dentro dos padrões de vibração da natureza.



OS SETE TECIDOS CORPORAIS – SAPTA DHATUS

Os *dhatu*s são as variedades básicas de tecidos que compõem o corpo físico humano. A palavra *dhatu* vem da palavra sânscrita que significa “aquele que entra na formação do corpo”; a raiz *Daa* (*dha*) significa “suporte”, aquele que aguenta.

A formação dos *dhatu*s no corpo humano são a expressão perfeita manifestada da natureza e inteligência divina que ao agir, de acordo com uma ordem precisa e segundo leis naturais, que o próprio homem ainda não conseguiu desvendar, produzem o corpo físico humano.

Os *Dhatu*s primários são em número de sete: tecidos reprodutivos (*Sukra dhatu*); medula do osso e tecidos nervosos (*Majja dhatu*); ossos (*Asthi dhatu*); tecidos gordos (*Meda dhatu*); tecidos do músculo (*Mamsa dhatu*); forma as células do sangue (*Rakta dhatu*); plasma (*Rasa dhatu*).

A principal característica da histologia Ayurvédica, ou seja o conceito da formação do tecido humano, é a de que cada um deles é formado a partir do tecido prévio em ordem ascendente de complexidade. Assim sendo, quando a comida é ingerida, ela é digerida até chegar ao intestino delgado na forma líquida, *ahara rasa*, ou essência da comida. Com a ajuda do *ahara rasagni*, cada *dhatu* tem o seu próprio *agni*, este *ahara rasa* é convertido em *rasa dhatu*, plasma sanguíneo – o primeiro e mais simples tecido.

Agora, *rasa dhatu* – catalisado por *rasagni* – é transformado em *rakta dhatu*, onde forma as células do sangue, o segundo tecido corporal essencial fundamental. *Rakta dhatu* por seu lado, com a ajuda de *raktagni*, torna-se *mamsa dhatu*, músculo, e assim, sucessivamente, até atingir o *sukra dhatu* – os tecidos reprodutores.

Juntos, os *dhatu*s e *upadhatu*s constituem a corpulência física do corpo. O *upa dhatu*s incluem cabelos, unhas, ligamentos, etc.; eles são estruturalmente importantes mas usualmente não são implicados nas condições de doçura do corpo.

Cada *dhatu* consiste de *paramanus*, células infinitesimais sem conta. Cada *paramanu* contém inumeráveis *suksma srotas*, canais, poros, através dos quais cada um recebe nutrientes e energias subtis e elimina materiais de desperdício. Pelo facto de os *dhatu*s serem saturados com poros, o corpo humano pode-se dizer, está preenchido com poros *srotomaya*. Os *srotas* de cada *dhatu* são únicos na sua estrutura e função e nos materiais que se movem através deles. O estado de saúde de cada *dhatu* bem como o seu relativo *vridhhi* / *kshaya* (excesso / deficiência, aumento, diminuição) é estabelecido pelo médico ayurvédico.

OS SETE CORPOS DOS NÍVEIS SUBTIS

Além do corpo físico e seus 7 níveis, a massagem Ayurvédica actua ainda em mais seis corpos, que são classificados como corpos subtis. Por isso, ela é tida também como uma massagem espiritualmente iniciática. Ela especifica, inclusive, as principais características e o tipo de postura que deverá ser adoptado com cada um desses corpos, se estiverem desequilibrados, aquando do tratamento.

O primeiro corpo é o físico, *Anna Maya Kosha*. É constituído de alimento, e a sua capa muscular, os seus nervos e ligamentos e estrutura óssea armazenam as tensões dos corpos superiores. O elemento relacionado com ele é a terra e está ligado com as gónadas e os órgãos sexuais. Numa massagem ele reage aos amassamentos, torções, alongamentos, tamborilamentos, pressões e também com determinadas pedras de uso terapêutico.

O segundo corpo é o energético etérico ou pranico, *Prana Maya Kosha*. É constituído de energia, comanda os órgãos dos sentidos e contém os elementos éter, ar, fogo, água e terra, no aspecto pranico. O seu elemento fundamental é a água e está relacionado com as glândulas supra-renais e região próxima do umbigo. Pode ser trabalhado pela massagem Ayurvédica, quando ela produz deslizamentos pelo sistema de meridianos e dinamiza determinados pontos em cima destes meridianos ou, ainda, pela pressão em determinados pontos *marmas*.

O terceiro corpo é o do desejo, *Kama Maya Kosha*. É o corpo das emoções telúricas que se manifestam pelo instinto. O seu elemento é o fogo e está relacionado com o estômago (Plexo Solar). Pode ser trabalhado com a massagem Ayurvédica com deslizamentos de forma precisa e pressão em pontos em toda a área do plexo solar, por alongamentos que fazem a abertura do plexo solar e, também, com a chama e energia de uma vela acesa.

O quarto corpo é o da felicidade, *Ananda Maya Kosha*. É o corpo das emoções afectivas e amorosas. O seu elemento é o ar e está relacionado com o tacto e o coração. Pode ser trabalhado pela massagem Ayur-Védica com deslizamentos em toda a região da caixa torácica e também pela pressão em determinados pontos nesta região. Pode, ainda, ser trabalhado pela respiração consciente, com determinadas técnicas de relaxamento e por alongamentos que fazem a abertura do plexo cardíaco.

O quinto corpo é o mental, *Manas Maya Kosha*. Seu elemento é o éter e está associado aos ouvidos e à garganta. Pode ser trabalhado pela massagem com deslizamentos em toda a região dos ouvidos e pescoço, por pressões em determinados pontos desta região e por alongamentos que fazem a abertura do plexo laríngeo. Pode, ainda, ser trabalhado por meio de determinados sons, mantras e músicas harmoniosas.

O sexto corpo é o do conhecimento, *Jñana Maya Kosha*. É a manifestação da sabedoria pura. Este corpo só reage a mantras superiores ou aos mantras dos chakras, contudo, pode também ser estimulado com pressões que se realizam no final da massagem na cabeça, testa e olhos.

O sétimo corpo é constituído de intuição pura, *Buddhi Maya Kosha* – o “eu sou”. É trabalhado apenas pela iniciação e reage a símbolos inconscientes, como mandalas, yantras e mulamantras como o OM. Quando a massagem é realizada por um terapeuta iniciado nos planos subtis ele pode abrir e activar esse corpo. A massagem na cabeça ajuda também na estimulação dos vórtices que ali se situam e que fazem a conexão com o sétimo corpo.

Os sete corpos interagem-se e são campos energéticos conectados com os sete chakras. A massagem Ayurvédica ao trabalhá-los directamente com pressões nos seus vórtices realinha-os e faz com que os sexto e sétimo corpos subtis passem a funcionar melhor e a responder com maior intensidade aos padrões vibratórios superiores. Decorre também uma purificação e um maior desenvolvimento de todos estes sete corpos, para além de ser muito eficaz no tratamento dos problemas respiratórios, de coluna, de artrite, assim como para amenizar enxaquecas, cansaço físico e mental e inúmeras outras doenças. Ela mobiliza as secreções pulmonares, fortalece a musculatura torácica e activa várias glândulas, como o timo e as supra-renais.

A COLUNA VERTEBRAL

Em sânscrito a coluna vertebral denomina-se *meru danda*. *Meru* é uma montanha lendária que se supõe ser o centro do macrocosmos; *danda* traduz-se como “pau”. A coluna é o centro do microcosmos, a sede das actividades neuromotoras do corpo. Do mesmo modo que a montanha *Meru* sustenta o corpo do macrocosmos, o nosso *meru danda* – ou seja, nossa coluna vertebral – sustenta o nosso corpo.

Construída como o cascavel da serpente, é capaz de realizar todo o tipo de movimentos serpentiados. Para manter a sua forma correcta, a coluna deve mover-se por meio de exercícios, yoga e dança e deve manter-se sempre erecta. Em todas as desordens físicas e mentais, os pacientes não são capazes de manter a coluna recta.

A maior parte das pessoas não estão conscientes da forma de sua coluna vertebral e não se sentam com a coluna recta; com frequência esta é a causa de muitos problemas fisiológicos e psicológicos. Em geral, a coluna começa a deformar-se depois dos quarenta e cinco anos devido em parte ao processo de envelhecimento natural e a deficiências vitamínicas. Desenvolver uma consciência perceptiva com relação à coluna vertebral e mantê-la erguida sem suportes que não são naturais, são os primeiros passos para desfrutar de uma vida sã.

As vértebras da coluna criam um canal que aloja e protege a medula espinal. Ela está em conexão com o tronco do cérebro e com o cérebro no crânio e o sistema nervoso central (o cérebro e a medula espinal) e é o centro de controle para todo o complexo do sistema nervoso, que percorre todo o corpo. Os nervos motores e os nervos simpáticos e para simpáticos, que se relacionam com as funções da actividade ou do descanso, ramificam-se desde a medula e juntam-se através das vértebras e do sacro. Desde o sacro ramificam-se em direcção ao resto do corpo, estimulando os tecidos dos músculos e dos órgãos e diminuindo as actividades destes últimos. A correcta postura da coluna é a chave para o bom funcionamento do corpo. A coluna é a base da juventude e do vigor; quem a mantém de forma erecta permanecerá forte, pensará e actuará correctamente e desfrutará de uma vida energética.

Uma massagem executada de forma correcta na coluna, com manipulações nas vértebras pode curar os nervos débeis e desordens psíquicas. É interessante observar que, em momentos de tristeza e pessimismo, a coluna curva-se. Em momentos de agudez mental, inspiração e alegria, a coluna mantém-se automaticamente erguida. A circulação do líquido cérebro espinal, um líquido vital que é gerado no cérebro e é bombeado dali através da medula, é essencial para manter a forma correcta da coluna. Exercícios físicos, como andar, praticar yoga ou dançar, colaboram na circulação e, portanto, quem os praticar sentir-se-á inspirado e renovado. Este líquido, que é a nutrição do sistema nervoso, contém muitas enzimas que contribuem para o desenvolvimento e é responsável pela saúde física e mental. Um método efectivo para manter uma boa circulação deste líquido é rodar a coluna da maneira como se realiza no *hatha yoga*.

Ao tratar a coluna, deve-se ter cuidado em não dar uma massagem demasiadamente intensa nem tão pouco exageradamente suave. Se a massagem e a pressão forem muito fortes não será bem tolerada, poderá ocasionar um efeito adverso sobre os nervos e o cérebro. Uma massagem na coluna sem óleo não é efectiva. Se administrada correctamente – com óleo, paciência e pressão correcta -, o óleo será absorvido facilmente e ajudará a aumentar a sua flexibilidade. Se esta prática for administrada diariamente, ou pelo menos três vezes por semana, protegerá durante toda a vida a coluna de contrair rigidez e evitará que ocorram desordens nos rins, fígado, estômago, pulmões ou cérebro.

A massagem na coluna é especialmente importante porque a coluna é a sede dos centros psíquicos ou chakras. De acordo com as escrituras do Tantra e do Yoga, antigas ciências para alcançar estados superiores de consciência, a base da coluna é o assento da energia espiritual latente chamada *kundalini*. Não é possível despertar a kundalini através da técnica da massagem, porém, os chakras, que estão relacionados no plano físico com as glândulas endócrinas, podem ser influenciados pela massagem. A massagem da coluna induz a trocas na química corporal e liberta a tensão do corpo.

Se considerarmos o corpo como uma árvore invertida, segundo a descrição do *Bhagavad Gita*, o cérebro transforma-se nas raízes e a coluna é o tronco. Como o tronco erecto de uma árvore canaliza a força gravitacional através dele, a coluna suporta o corpo e protege-o de ser distorcido pela força gravitacional.

ALTERAÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL QUE A MASSAGEM AYURVÉDICA PODE AJUDAR A CORRIGIR

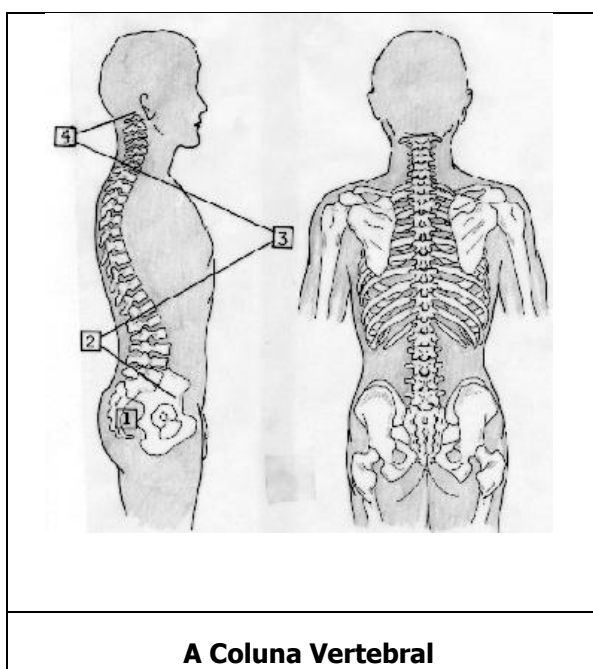
Ao longo dos anos a coluna vertebral, de acordo com as nossas emoções, tensões, postura incorrecta e maneira incorrecta de sentar e trabalhar, sofre alterações que ocasionam distúrbios físicos de várias ordens. Essas incorrecções podem ocasionar problemas físicos e energéticos nos vários órgãos que tem conexão com as vértebras atingidas, para além de pressão e extensão de outros. Ao analisarmos a coluna de uma pessoa podemos constatar as várias mudanças que a sua coluna vertebral foi sofrendo ao longo da sua existência e que medidas deverão ser tomadas para a realização da correcção do problema.

Numa pessoa que se posicione de pé, tendo a coluna vertebral sadia e harmoniosamente pousada, veremos no plano coronal o conjunto da coluna alinhado verticalmente. Esta posição marca o eixo de simetria do corpo.

CURVAS QUE PODERÃO OCORRER

No plano sagital, deverá a coluna apresentar quatro curvas, a seguir enumeradas:

- 1. Curvatura Sacral:** esta curva de concavidade anterior é composta pelo conjunto de 5 vértebras sacrais e de 3 a 5 vértebras (rudimentares) coccígeas, que se apresentam fixas devido à soldadura de suas vértebras sacrais.
- 2. Curvatura Lombar:** região de grande mobilidade e muito susceptível ao desequilíbrio é constituída por 5 vértebras denominadas lombares. Apresenta a lordose lombar com concavidade posterior.
- 3. Curvatura Dorsal:** região onde se situa o vórtice do chakra cardíaco por isso muito importante. É composta por 12 vértebras dorsais. A região dorsal ou torácica apresenta pouca mobilidade e a cifose, isto é, concavidade anterior.
- 4. Curvatura Cervical:** região de grande mobilidade e com tendência a apresentar a lordose (concavidade posterior), devido a postura incorrecta, principalmente nos dias de hoje onde o trabalho de escritório solicita exageradamente estas vértebras. É constituída por um conjunto de 7 vértebras.



COLUNA VERTEBRAL E SUAS CURVAS PLANOS SAGITAL E CORONAL

Com a massagem Ayurvédica, todas as disfunções da coluna vertebral, dependendo da gravidade, poderão sofrer minoramento ou mesmo correcção completa. O manuseamento e soltura dos tecidos, o alongamento de tendões e músculos podem corrigir naturalmente as deformações que a coluna apresente devolvendo ao corpo a sua postura natural. Como benefício teremos o reequilíbrio de todos os órgãos físicos e o retorno da circulação energética e subtil ao seu movimento natural e correcto.

MASSAGEM AYURVÉDICA E O USO DE ÓLEOS AROMÁTICOS

Os óleos essenciais podem ser de grande valia nos tratamentos ayurvédicos. Como sabemos, a pele tem afinidade com os óleos, os quais são por ela rapidamente absorvidos. Assim, portanto, ao massajarmos o corpo com óleos aromáticos, podemos combinar eficazmente as propriedades terapêuticas das essências com os efeitos benéficos da própria massagem. Desta forma, se escolhermos um tipo de óleo adequado estaremos contribuindo para que o corpo do paciente se recupere mais prontamente.

A aplicação de óleos com composição de essências aromáticas tem como objectivo prioritário dirigi-las para as áreas do corpo onde elas são necessárias e, portanto, durante a execução de uma massagem pode-se aplicar essa composição de forma localizada e de acordo com o problema da pessoa.

A aplicação com óleos essenciais requer, para que se dê uma penetração dérmica eficiente, que a própria pele esteja num estado razoável de saúde. Se os fluídos da pele e do corpo se encontram num estado de congestão tóxica, ou seja, a pessoa apresenta-se com excesso de peso, cansaço, demasiada sonolência e erupções na pele, o jejum ou a dieta podem ser administrados juntamente com o tratamento de Aromaterapia.

COMPOSIÇÃO DOS ÓLEOS DE MASSAGEM COM ÓLEOS ESSENCIAIS

Os óleos essenciais não devem ser usados directamente sobre a pele. Para os tratamentos através das massagens eles devem ser diluídos numa percentagem de 2,5%, ou seja, 1 gota de essência por 2 ml de óleo vegetal. Por exemplo, se for utilizar óleo de massagem compostos com óleos essenciais adopte a seguintes dosagens:

	%	ml
Óleo Essencial:	2,5	2,50 = 50 gotas
Óleo Vegetal Excipiente:	97,5%	97,50
	-----	-----
	100,0%	100,0 ml de mistura total

Para fazer a composição do óleo proceda da seguinte maneira: a quantidade de óleo essencial deverá ser colocada num frasco e a seguir preencher-se com o óleo vegetal na quantidade calculada. O óleo vegetal age como um veículo de diluição dos óleos essenciais, permitindo assim, que estes sejam eficazmente utilizados sobre a pele. A sua composição deverá incluir um óleo que nutra a pele e que seja especialmente rico em vitaminas juntamente com um óleo vegetal mais leve, como o óleo de amêndoas doces, azeite, óleo de soja ou óleo de sementes de girassol. Deve-se incluir também, numa proporção de 5 a 10%, um antioxidante natural muito eficaz, como por exemplo, o óleo de gérmen de trigo, o qual é muito rico em vitamina E. Assim, evita-se que ocorra oxidação e rancificação dos óleos de massagem, os quais ficam com um odor desagradável, perdendo-se também significativamente, o seu valor terapêutico.

Para que o óleo de massagem mantenha o perfume pelo maior tempo possível, no frasco ou fora dele, deve ter o cuidado de o “fixar” correctamente, ou seja, a sua mistura deverá incluir, pelo menos, um óleo de baixa volatilidade, como o óleo de sândalo, patchouli ou de cedro.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DOS ÓLEOS ESSENCIAIS NOS DIVERSOS DISTÚRBIOS DO CORPO

Os óleos essenciais podem ser utilizados para os mais diversos problemas que o corpo apresente, desde que compostos de forma adequada.

Os distúrbios que ocorrem no aparelho digestivo podem ser sanados através de lavagens locais, massagens aromáticas na espinha – especialmente sobre as áreas dorsal e lombar – e também através de compressas locais na área do estômago ou do abdômen.

Para distúrbios cardiovasculares pode-se ministrar compressas sobre a área do coração, massagens na espinha – especialmente sobre a área dorsal – e, também, por banhos aromáticos.

Para distúrbios no aparelho respiratório pode-se aplicar inalações, massagens na espinha – especialmente sobre a área cervical ou dorsal e, também, compressas locais.

Para problemas que se apresentam no aparelho urinário pode-se aplicar banhos nos quadris, massagens na região sacrolombar, e ainda, compressas locais.

Para auxiliar o parto eles são também de extremo valor. Podem ser aplicados em compressas na parte inferior do abdômen, e em massagens sobre a região inferior das costas.

Para os problemas do sistema reprodutivo, os óleos podem ser usados em massagens, banhos de quadris e em duchas vaginais.

Para tratar do excesso de tensão nervosa e do *stress* deve-se fazer um bom óleo de massagem relaxante com matérias-primas de boa qualidade, como o óleo de amêndoas doces, óleo de noz, óleo de ratânea, óleo de germen de trigo, óleo de soja e uma mistura de óleos essenciais com propriedades calmantes, o qual deve ser aplicado através de massagens superficiais e profundas por todo o corpo.

ALGUMAS COMPOSIÇÕES DE ÓLEOS DE MASSAGEM COM ÓLEOS ESSENCIAIS PARA PROBLEMAS ESPECÍFICOS:

Para todas as composições apresentadas a seguir a diluição da essência aromática deverá ser feita num frasco que tenha 100 mililitros de um tipo de óleo vegetal excipiente.

Para dores reumáticas faça a seguinte composição:

Óleo Essencial de Limão ----- 10 gotas

Óleo Essencial de Eucalipto ----- 10 gotas

Óleo Essencial de Alecrim ----- 30 gotas

50 gotas

Para obter um óleo tônico para os músculos e que alivie as dores musculares componha da seguinte maneira:

Óleo Essencial de Junípero ----- 12 gotas

Óleo Essencial de Lavanda ----- 24 gotas

Óleo Essencial de Alecrim ----- 14 gotas

50 gotas

Para obter um bom óleo relaxante geral adote a seguinte composição:

Óleo Essencial de Gerânio ----- 20 gotas

Óleo Essencial de Lavanda ----- 20 gotas

Óleo Essencial de Manjerona ----- 10 gotas

50 gotas

Há inúmeras receitas que podem ser executadas. Tendo um bom conhecimento das propriedades curativas dos óleos essenciais pode preparar uma grande quantidade de óleos terapêuticos específicos para a massagem.

ÓLEOS ESPECIAIS PARA MASSAGEM AYURVÉDICA

Os óleos para a massagem Ayurvédica devem ser preparados por profissionais especializados e que sejam de inteira confiança. É necessário que seja dada grande atenção ao uso de todas as plantas indicadas nos textos ayurvédicos antigos, tendo o cuidado de não eliminar nenhuma, mesmo as mais difíceis de se obter. Os médicos ayurvédicos em conjunto com os sábios *vaidyas* indianos sabem combinar e preparar com precisão os óleos e outros produtos, fazendo com que estes sejam subtilezas de extraordinário valor. Actualmente já existem óleos específicos para cada tipo de constituição.

APLICAÇÃO DOS ÓLEOS DE MASSAGEM NA AYURVÉDICA

O óleo deve ser aplicado, de preferência, aquecido e por todo o corpo e músculos, massajando de acordo com os movimentos da sequência da massagem e com movimentos circulares nas articulações e algumas outras localizações, como, por exemplo, na barriga. Após completar a massagem em todo o corpo, o paciente deve permanecer com o óleo, repousando, por mais 5 a 10 minutos e só deve tomar banho depois de duas horas.

ÓLEO DE MASSAGEM VATA

Este óleo único acalma, humedece e aquece a constituição *Vata*, que tem tendência a ser fria, seca e nervosa. Ele vem sendo usado há séculos por toda a Índia e tem sido indicado, principalmente, para dar vitalidade à pele *Vata*, promover a eliminação das toxinas e estimular a circulação.

Na fabricação do óleo de massagem *Vata* deve-se combinar os seguintes ingredientes:

Ashwagandha | *Balamool* | *Bilwa* | *Patala* | *Kantakari* | *Brihati* | *Goksbura* | *Neem* | *Tintuk* | *Punarnava* | *Prasarini* | *Agnimantha* | *Kosshtha* | *Chandan* | *Moorva* | *Vacha* | *Jatamansi* | *Saindhava* | *Rasna* | *Deodaru* | *Shaliparni* | *Prushniparni* | *Tagar* | *Shatavari* | Óleo de Sésamo | Óleos essenciais.

ÓLEO DE MASSAGEM PITTA

Este óleo de massagem é preparado com sândalo branco e é conhecido pelas propriedades que possui, por purificar, tranquilizar e refrescar a pele da constituição *Pitta* que costuma ser particularmente sensível a ambientes irritantes, com propensão a inflamações, erupções cutâneas e manchas. Este óleo ajuda a equilibrar os *Pitta*, promovendo-lhes a eliminação das toxinas e criando uma sensação revigorante.

Na fabricação do óleo de massagem *Pitta* deve-se combinar os seguintes ingredientes:

Sveta Chandan (Sândalo Branco) | *Laksba* | *Bala* | *Yastimadhu* | *Ketaki* | *Sariva* | *Ela* | *Satapushpa* | *Usheer* | *Devadaru* | *Kostha* | *Aguru* | *Musta* | *Chamaka* | *Tvak* | Óleo de Sésamo | Óleo de Jojoba | Óleos essenciais.

ÓLEO DE MASSAGEM KAPHA

Este óleo de massagem foi formulado para estimular, revitalizar e aquecer a constituição *Kapha*; promove a eliminação da retenção de água no organismo e revigora os músculos e a circulação. Contém dois dos mais famosos tonificantes para a pele, que são reconhecidos pela Ayurveda, o *nirgundi* e o *karavira*, assim como extractos de folhas de *Neem*. Restabelece e dá vida à pele e ajuda a cicatrizar pequenas feridas.

Na fabricação do óleo de massagem Kapha deve-se combinar os seguintes ingredientes:
Nirgundi (*vitex nigundo*) / *Karavira* (*Nerium indicum*) / *Neem* / *Datura* / *Karanja Taila* / Óleos essenciais.

VER TABELA COM OS PRINCIPAOS ÓLEOS ESSENCIAIS E SUAS PROPRIEDADES EM ANEXOS

PARTE B – PRÁTICA - MANOBRAS ESPECIAIS**A SER REALIZADA UNICAMENTE POR PROFISSIONAIS QUE TIVERAM TREINAMENTO ADEQUADO**

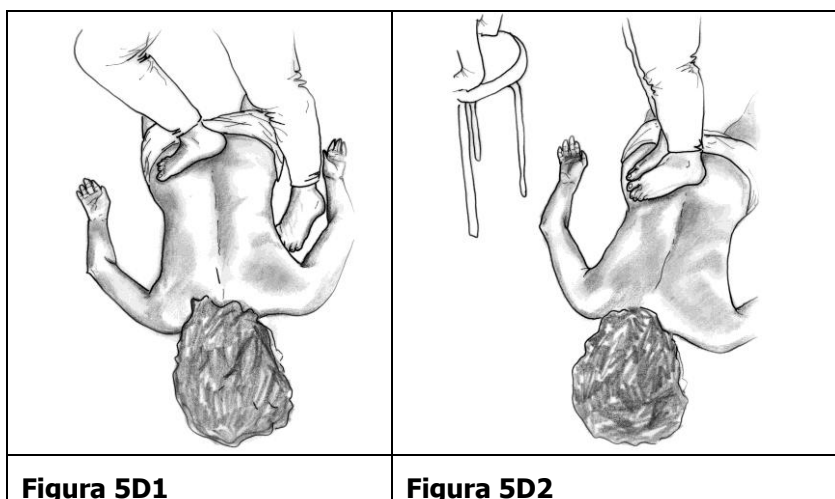
Estas manobras devem ser encaixadas durante a sequência normal da massagem no local a elas destinadas. O terapeuta pode eventualmente não realizá-las ou, realizar apenas as que o paciente, devido aos problemas apresentados, necessitar. Se o paciente tiver muitos problemas o terapeuta pode variar as manobras a cada sessão.

MASSAGEM COM OS PÉS NAS COSTAS

A SER REALIZADO QUANDO FOR FINALIZADA A MASSAGEM COM AS MÃOS NAS COSTAS E NO PESCOÇO. A SEGUIR MASSAJA-SE COM OS PÉS.

PARA REALIZAR A MASSAGEM NAS COSTAS O TERAPEUTA DEVERÁ SUBIR PARA O CORPO DO PACIENTE PISANDO PRIMEIRO AS NÁDEGAS

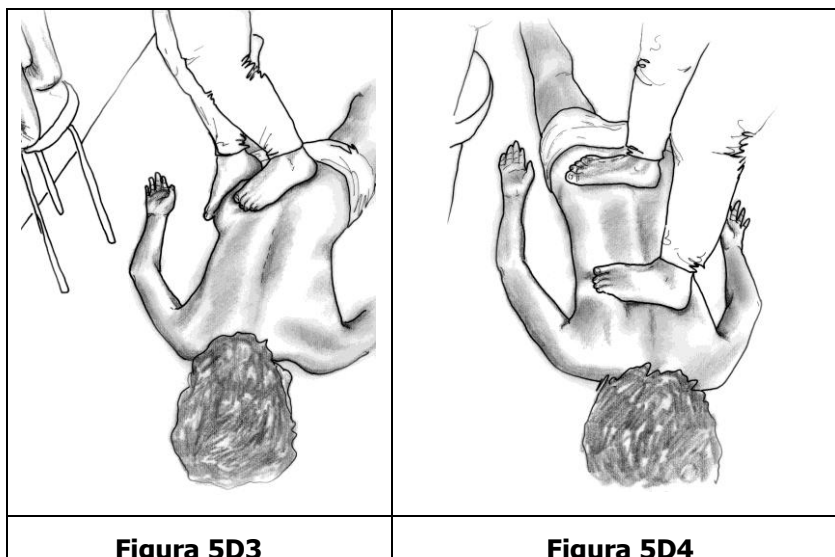
O paciente mantém-se deitado com os braços estendidos lateralmente ao longo do corpo, **sendo imprescindível que a cabeça fique voltada de lado e, opostamente, ao lado do corpo a ser massajado com os pés**. Para executar a massagem com os pés, o terapeuta deverá segurar-se, com as duas mãos, num banquinho. Esse apoio servirá para manter o equilíbrio do terapeuta e para dosar o peso de parte do seu corpo que vai estar em cima do paciente. Figuras 5D1 – 5D2.



O terapeuta coloca primeiro, firmemente, a planta dos dois pés, um do lado ao outro, paralelamente, em cima da região glútea e próximos da base da coluna do paciente. Figuras 5D1 – 5D2.

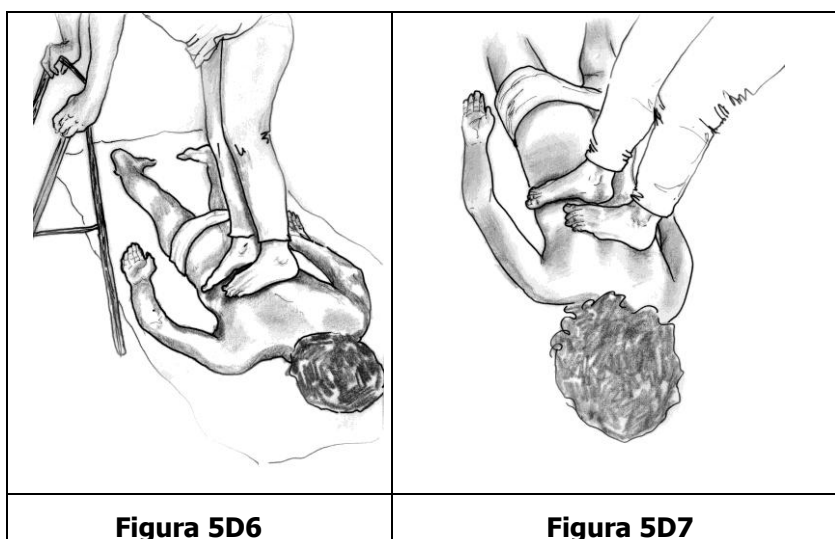
O terapeuta inicia a massagem com deslizamentos alternados da planta dos pés nas laterais das nádegas do paciente, do centro para fora. A rigidez muscular demonstra se há ou não tensão muscular e problemas na região. Repete-se esse movimento várias vezes procurando alongar toda a musculatura da região das nádegas. Figura 5D3.

Depois da soltura dos músculos glúteos o terapeuta passa a realizar massagens por toda a região das costas. Sobe um dos pés para a região próxima da escápula e a seguir o outro pé colocando-o paralelamente. Figuras 5D4 e 5D6



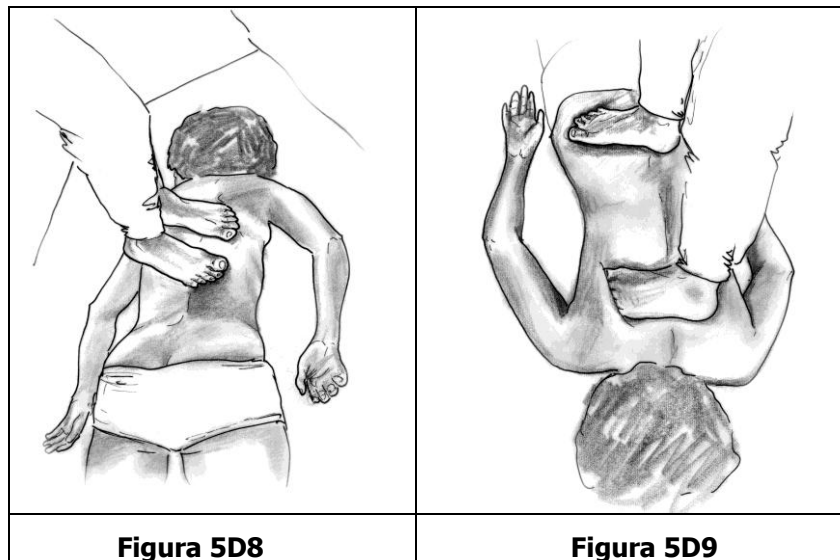
O terapeuta inicia a massagem com movimentos deslizantes alternados dos pés, do centro, próximo da coluna, para fora. Repete esse movimento várias vezes e por toda a região das costas até que haja soltura dos tecidos rígidos e tensos. O terapeuta só deve pisar na região do tronco ou seja, onde se situa a caixa torácica. Deve evitar colocar muito peso em cima da coluna distribuindo-o sobre os braços que estão apoiados no banquinho. Figura 5D6.

Estes movimentos devem abarcar toda a região das costas e ter os seguintes direccionamentos: do centro para fora, conforme ilustração anterior e de cima para baixo, conforme ilustração ao lado. Figura 5D7.



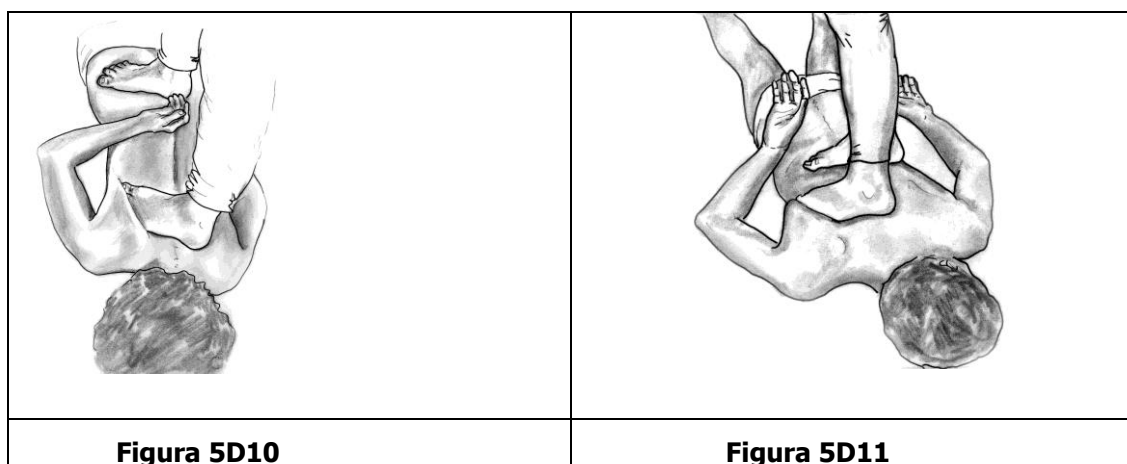
Para realizar a massagem com os pés na região próxima das vértebras flutuantes e do rim, o terapeuta mantém fixo um pé próximo da região da escápula e somente desliza o outro pé sem colocar muito peso, procurando massajar toda essa região e soltar toda a musculatura. Figura 5D8.

Realizamos, a seguir, a abertura da escápula com o auxílio de um dos pés. Para realizar esta abertura, os braços do paciente deverão estar estendidos ao longo do corpo. Pousamos um pé sobre os glúteos, que permanece fixo e, com o outro procuramos abrir a escápula introduzindo o outro pé para dentro da omoplata. Ao realizarmos este movimento mantemos o estiramento da musculatura dorsal que fica entre os dois pés. Figura 5D9.

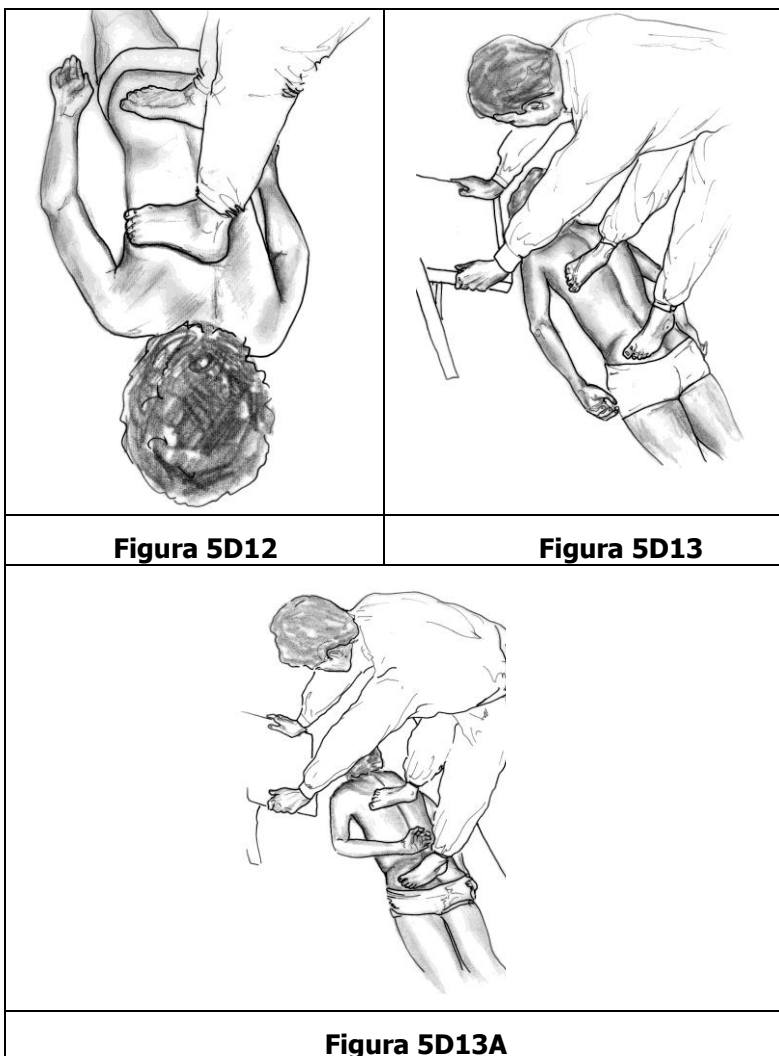


Caso a escápula, por tensão e rigidez muscular esteja colada, o terapeuta deve colocar o braço do paciente sobre as costas. Essa postura facilita a abertura da mesma. Damos seguimento ao movimento já descrito anteriormente tentando alongar a musculatura ao redor da escápula. Um pé permanece em cima das nádegas e o outro pé é introduzido para dentro da omoplata. Se houver dificuldade massaja-se a musculatura ao redor da escápula procurando introduzir o pé aos poucos. Figura 5D10.

Em caso de rigidez e após ter executado o movimento anterior, o terapeuta pode trabalhar um pouco mais a soltura da musculatura dorsal deixando o braço do paciente em cima das nádegas e os seus pés em cima da caixa torácica, próximos da escápula. Massaja-se com o pé superior a musculatura ao redor da escápula e aos poucos procura-se introduzi-lo na omoplata. A musculatura dorsal localizada ao redor das omoplatas, com os dois pés colocados próximos um do outro, é estirada ao máximo. Figura 5D11.



Em caso de muita rigidez e pouca mobilidade dos músculos e de toda a coluna, o terapeuta prepara essa região, inicialmente, com massagens e com deslizamentos dos pés nas costas sem tentar abrir de uma vez a escápula. Neste caso, o terapeuta fica em pé, distribuindo o peso do corpo no meio da coluna, um dos pés mantém-se fixo enquanto o outro massaja as costas, na região à volta da escápula, usando a borda lateral do pé e dos artelhos, que tentam entrar lentamente sob as escápulas. Esses movimentos com o decorrer dos tratamentos auxiliarão no alongamento dos músculos e na abertura da escápula. Pode ser realizado com o braço estendido ao longo do corpo (Figura 5D12 – 5D13) ou com o braço em cima do corpo, conforme ilustrações da figura 5D13A.

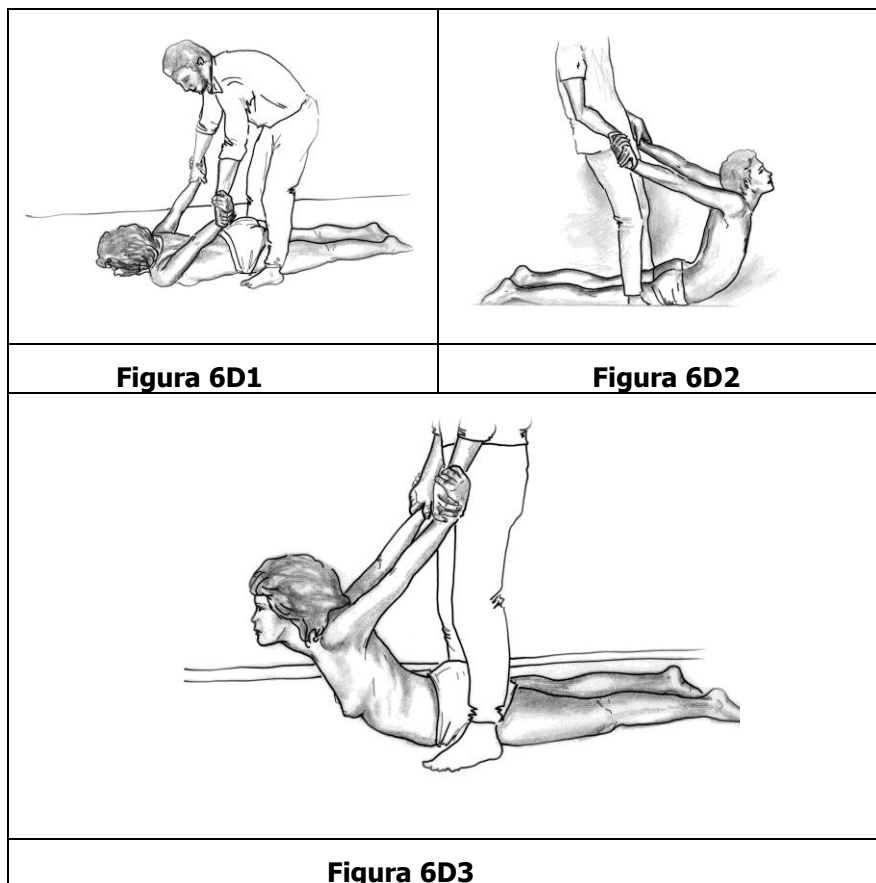


MANOBRAS DE TRACÇÃO PARA ABRIR O PEITO

O paciente fica deitado em posição ventral, com os braços estirados para traz. O terapeuta coloca-se em pé na altura do quadril do paciente. Ambos seguraram-se mutuamente com as mãos na região dos pulsos. Figura 6D1.

O terapeuta eleva o tronco do paciente, solicitando ao mesmo, que mantenha a cabeça ao máximo voltada para traz. Os olhos deverão estar voltados em direcção ao centro da testa. Para evitar que o paciente deslize, o terapeuta segura e pressiona com os pés o quadril do paciente. O paciente deve manter o corpo e o abdômem relaxados, a respiração solta e pelo abdômem. Essa posição é ótima para

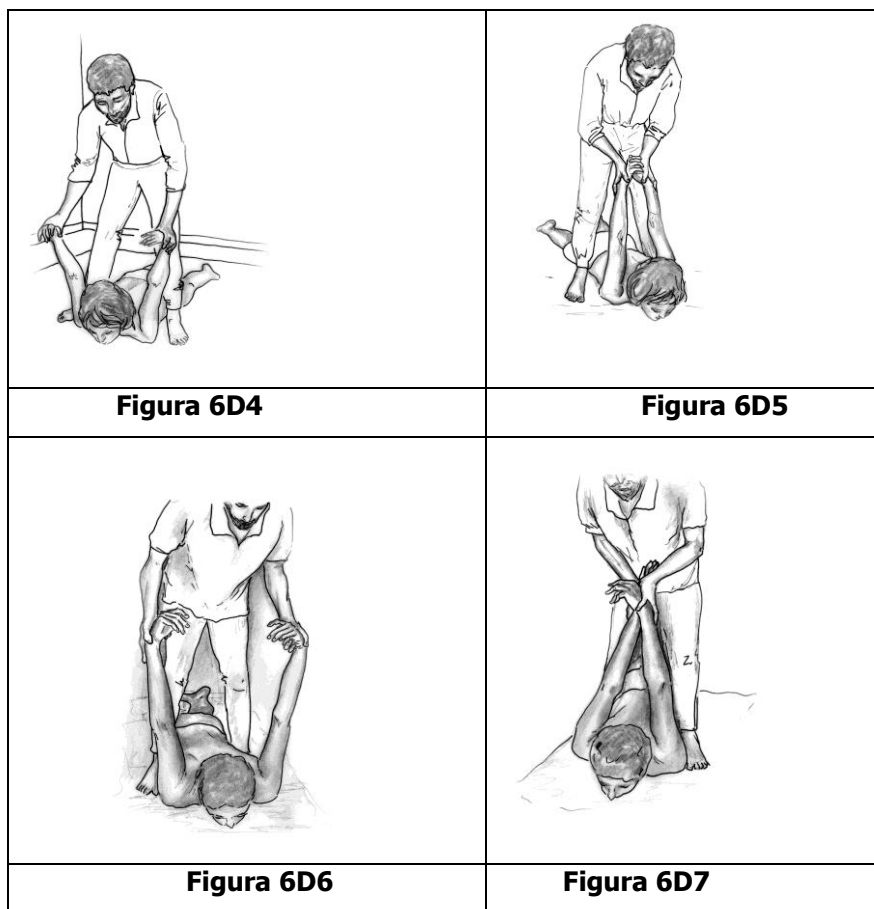
abrir o peito, chakra cardíaco, chakra laríngeo e canaliza a energia para o 6º chakra, além de alongar músculos e tendões. O terapeuta mantém esta posição pelo menos de 10 a 15 segundos e lentamente, sem balançar a coluna do paciente retorna à posição normal pedindo ao paciente para que coloque o queixo no chão. Sem soltar a mão do paciente o terapeuta inicia um novo movimento. Figura 6D2 – 6D3.



O terapeuta posicionado acima da cintura do paciente, que está com o queixo no chão e com os braços ainda estendidos, soltos e relaxados, passa a segurar o dorso da mão do paciente. O terapeuta procura levar os braços do paciente para a frente, na direcção da cabeça, até ao limite máximo, forçando um pouco a extensão do mesmo. Figura 6D4 – 6D5.

Retorna um pouco para traz e realiza-se a aproximação dos braços, devendo as mãos juntar-se no centro do corpo. Nesta posição estende-se novamente os braços para a frente até ao limite. Figura 6D6.

O terapeuta leva o braço do paciente até à posição central e procura realizar o cruzamento dos braços, de um lado e do outro. A seguir lentamente solta o movimento e coloca os braços do paciente ao longo do corpo. Figura 6D7.

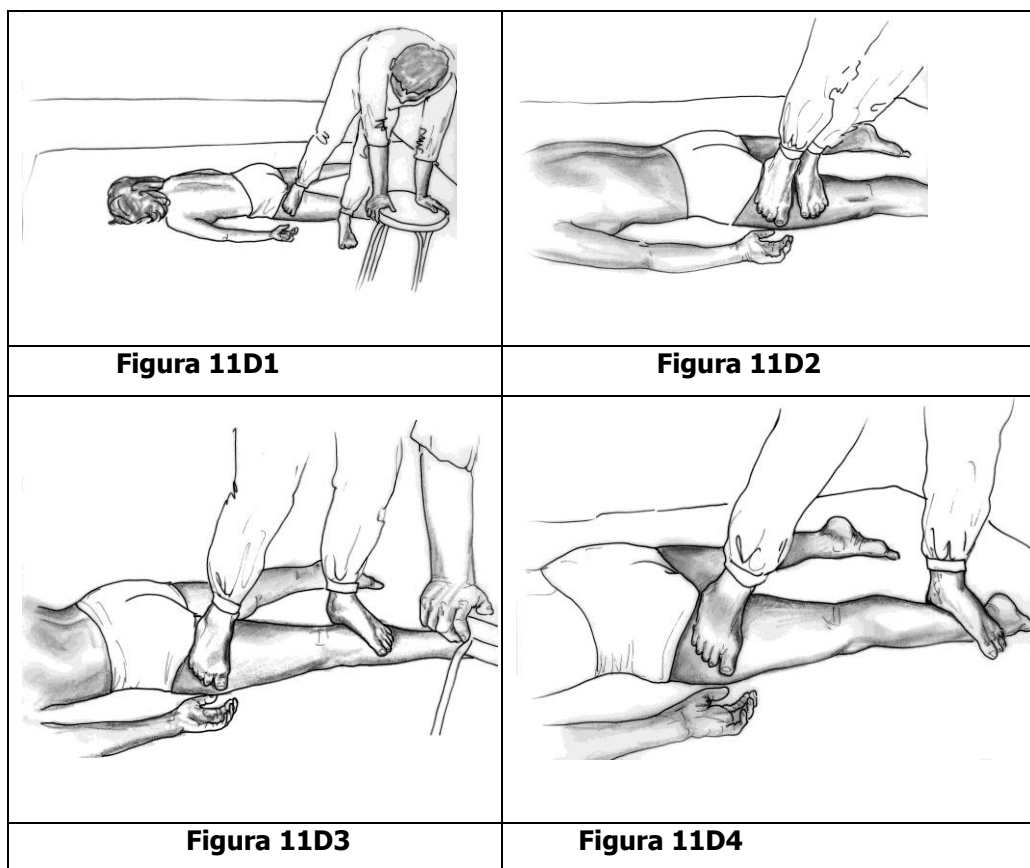


MASSAGEM COM OS PÉS NA PARTE POSTERIOR DAS PERNAS

Também com o auxílio de um banquinho ou de uma cadeira, o terapeuta realiza massagem com a planta dos pés na parte posterior das pernas do paciente. Figura 11D1

Para realizar esta manobra, o paciente deverá ter os dedos dos pés voltados para o interior da perna, ou seja em rotação interna. O terapeuta apoia as suas mãos sobre o banquinho ou cadeira e transfere parte do seu peso sobre ela. Apoia um pé primeiramente sobre a região superior da coxa, próxima dos glúteos, e o outro paralelo ao primeiro, realiza deslizamentos alternados com os pés para fora. De modo algum pisa ou realiza peso na região próxima do joelho e no joelho. O terapeuta deve fazer esses deslizamentos até à região que precede a articulação do joelho. Figura 11D2.

Para alongar a panturrilha o terapeuta deixa um dos pés apoiado na parte superior da coxa do paciente e, com o outro, realiza deslizamentos, pelo menos três vezes, com certa pressão, da região situada logo abaixo do joelho até atingir a região próxima do calcanhar, procurando estirar ao máximo toda a musculatura situada nesta região. Repetem-se estes movimentos na outra perna. Figura 11D3 – 11D4



A seguir o terapeuta passa a realizar o alongamento dos pés.

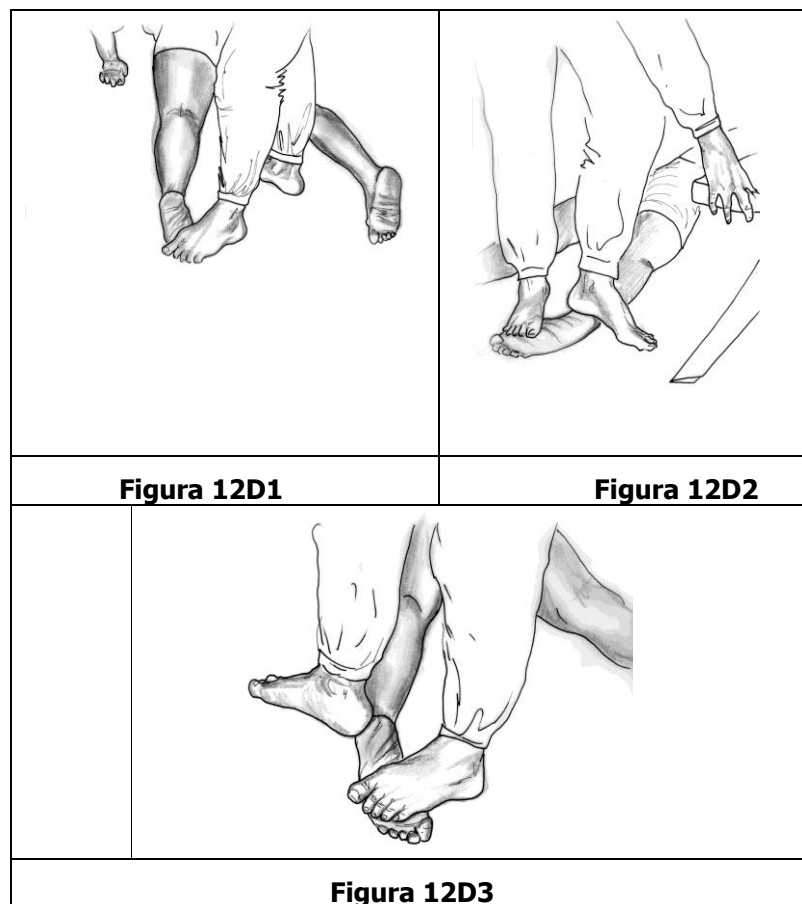
Tracções nos pés e calcanhares

POSIÇÃO CORRETA DOS PÉS: Os dedos deverão estar voltados para a parte interior da perna.

O terapeuta apoia as mãos sobre uma cadeira ou banquinho que serve para lhe dar equilíbrio e coloca um de seus pés, ou mais especificamente o arco de seu pé no arco do pé do paciente, que está com o pé em rotação interna. Figura 12D1.

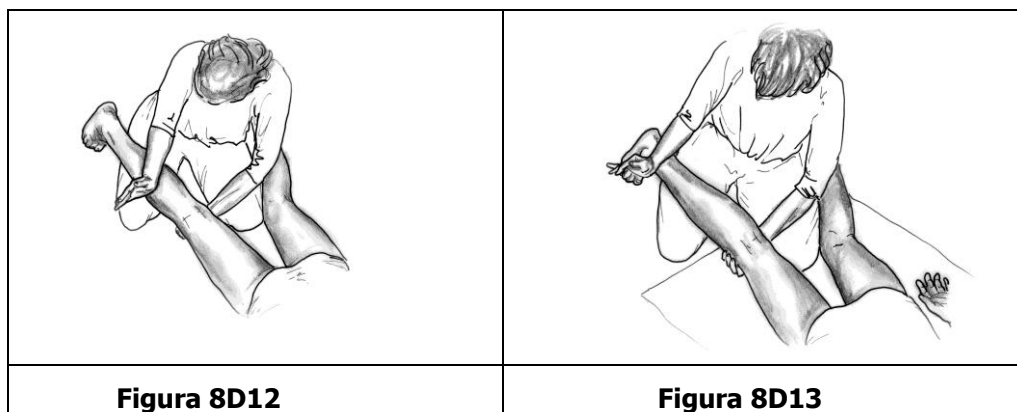
Com o outro pé, o terapeuta empurra com o seu calcanhar o calcanhar do paciente em direcção ao solo e mantém-no em rotação interna máxima. A seguir, solta o apoio do arco do pé para relaxar e reinicia o movimento. Esse movimento é repetido pelo menos três vezes. Figura 12D2.

A seguir, o terapeuta segue a mesma sequência inicial, só que desta vez, empurra o calcanhar do paciente para cima, em direcção a si, e mantém-no por algum tempo antes de o soltar. Repete-se também esse movimento pelo menos três vezes. Figura 12D3.



MOVIMENTO ALTERNATIVO PARA SUBSTITUIR A MASSAGEM COM OS PÉS

Caso o paciente não possa receber massagem com os pés podemos realizar o alongamento dos músculos dos gêmeos com o auxílio do antebraço. O terapeuta apoia a perna do paciente na sua perna, segura com uma das mãos o joelho e com o antebraço faz deslizamentos que percorrem toda a extensão da barriga da perna (região posterior da perna), do joelho em direcção ao calcanhar. Esse movimento é realizado diversas vezes. Deve-se realizar uma pressão no início, no mínimo média e depois mais vigorosa, para atingir as camadas mais profundas. Figura 8D12 – 8D13



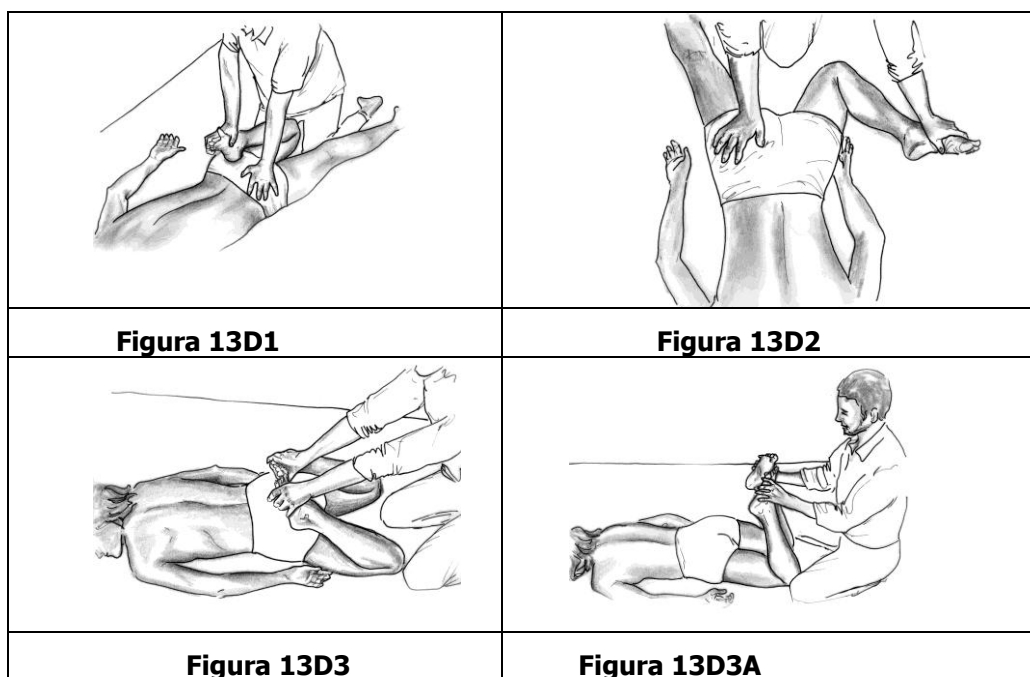
TRACÇÕES E ALONGAMENTOS NAS PERNAS – PARTE POSTERIOR

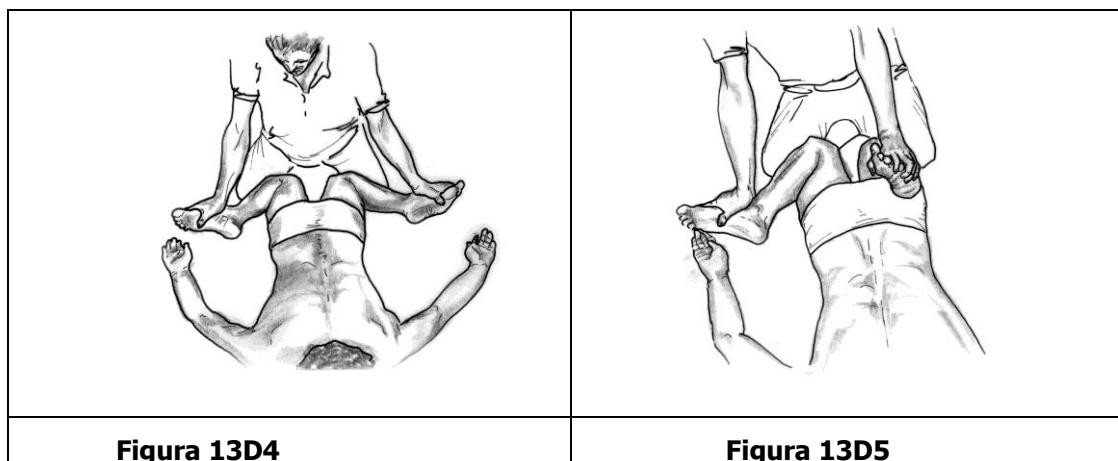
O paciente deverá estar em decúbito ventral.

O terapeuta fica de joelhos atrás do paciente, no centro das pernas. Pega na região anterior do pé próxima dos dedos dos pés do paciente, empurra a perna do paciente, com flexão do joelho, até que o calcanhar encoste na região glútea. A outra mão do terapeuta estabiliza a pelve do outro lado evitando compensações, realizando assim alongamento da musculatura extensora do joelho. Figura 13D1.

Quando a extensão estiver no ponto máximo o terapeuta segura por alguns segundos e realiza a rotação do joelho, mantendo o joelho em flexão e roda a perna externamente enquanto fixa o outro lado com a palma da mão em cima dos glúteos. O ideal é alongar até que o pé do paciente toque no chão. Realiza-se a mesma manobra do lado oposto. Figura 13D2.

A seguir, o terapeuta realiza o alongamento das duas pernas do paciente ao mesmo tempo. Da mesma forma que as manobras anteriores, o terapeuta posiciona-se atrás dos joelhos do paciente. Segura os dois ante-pés do paciente e, a seguir, empurra-os em direcção às nádegas procurando flexionar os joelhos, até que os pés toquem nas nádegas. Para que não ocorra o afastamento dos joelhos o terapeuta comprime os dois joelhos do paciente entre as suas duas pernas, se achar necessário. Esta manobra pode também ser realizada de forma mais solta, sem a compressão dos joelhos, como mostra a ilustração. Figura 13D3A – 13D3.





A seguir, procura abrir ambas as pernas, para realizar a rotação de ambos os joelhos para fora, procurando fazer com que os pés toquem no chão. Figura 13D4.

O terapeuta pode também rodar uma perna de cada vez. Eleva as duas pernas empurrando-as até que os ante-pés toquem nas nádegas. A seguir roda um dos pés para fora até que toque no chão, se for possível, enquanto o outro pé permanece em cima da nádega. Neste movimento trabalha-se em simultâneo as duas pernas de forma diferente. Numa alonga-se a parte frontal dos pés e os músculos da parte frontal das coxas, enquanto que na outra trabalha-se a rotação do joelho, a abertura do quadril e os músculos laterais da perna. A seguir, o terapeuta inverte a posição. Figura 13D5

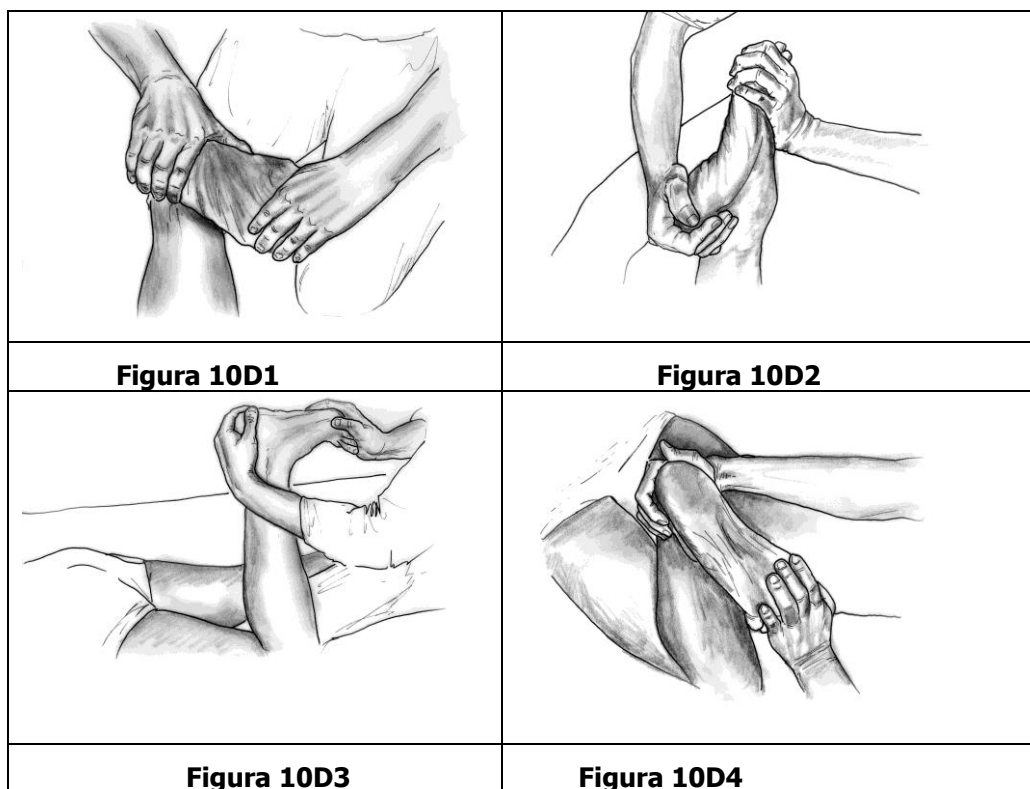
TORÇÕES E FLEXÕES NOS PÉS

Paciente em decúbito ventral e joelho flectido a 90 graus. O terapeuta coloca-se atrás, de joelhos e, se necessário prende o joelho do paciente entre os seus joelhos, para obter maior estabilidade e executa as seguintes manobras:

Com as mãos apoiadas no pé do paciente, uma no calcanhar e a outra em cima dos dedos, o terapeuta gira o calcanhar para dentro e o ante-pé para fora e mantém a tracção por algum tempo - movimento para torção lateral do pé. Figura 10D1

Em seguida, repete o movimento em sentido contrário - para torção medial interna dos pés: calcanhar para fora e ante-pé para dentro. Figura 10D2

Na mesma posição, o terapeuta fixa com uma das mãos o tornozelo, e com a outra mão localizada na ponta do ante-pé, faz a flexão e extensão máxima do pé para baixo, procurando manter durante alguns segundos a posição. Este movimento realiza também o alongamento do Tendão de Aquiles e musculatura plantar. Figura 10D3 – 10D4

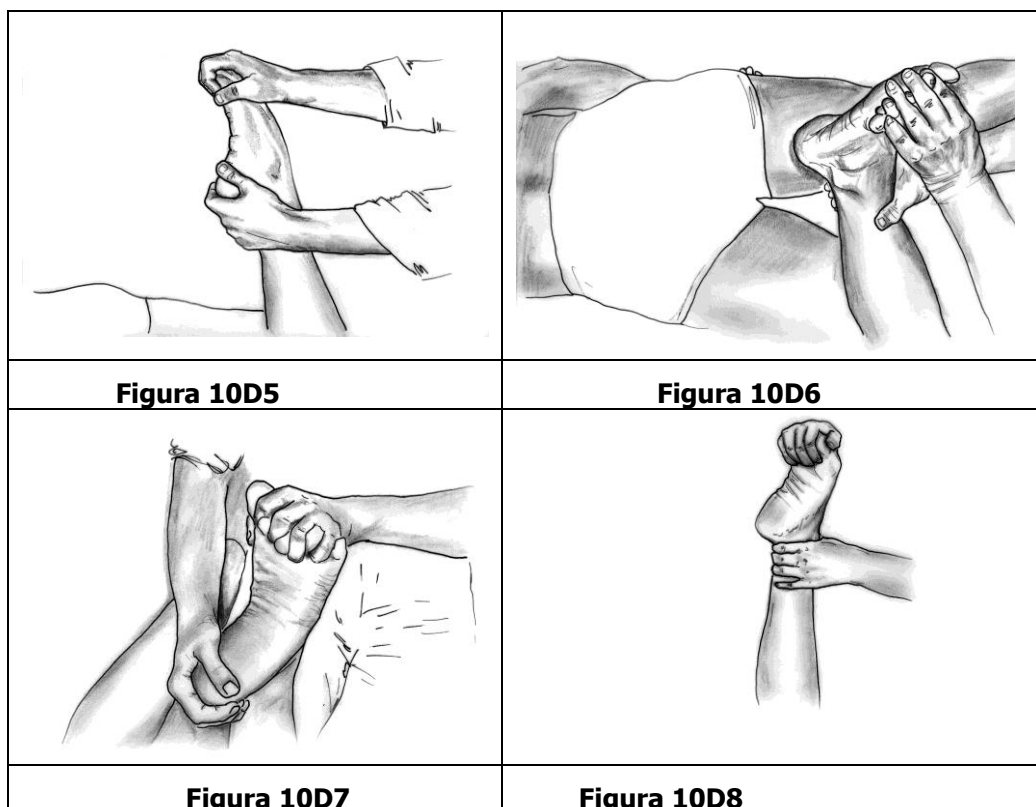


O terapeuta executa, a seguir, o movimento contrário obtendo assim a flexão plantar, com alongamento de toda musculatura dorsal do pé. Os artelhos são alongados conjuntamente. Figura 10D5

Na mesma posição o terapeuta realiza a abertura dos dedos do pé do paciente colocando os dedos de sua mão entre os artelhos do paciente, realizando assim alongamento e soltura da musculatura interóssea associada a Flexão Plantar, e com a outra mão, fixa o tornozelo e faz movimento de rotação horário e anti-horária do pé. É muito recomendada para indivíduos com artelhos muito tensos. Figura 10D6

Para finalizar o trabalho no pé o terapeuta dá continuidade ao movimento anterior, ainda com seus dedos no meio dos dedos do pé do paciente, executa a torção dos dedos para cima e para dentro, alongando assim os dedos e a musculatura dorsal do pé. Figura 10D7

Ao soltar realiza a torção de todos os dedos ao mesmo tempo para obter um resultado em conjunto. O terapeuta passa, a seguir, para a fase seguinte. Figura 10D8



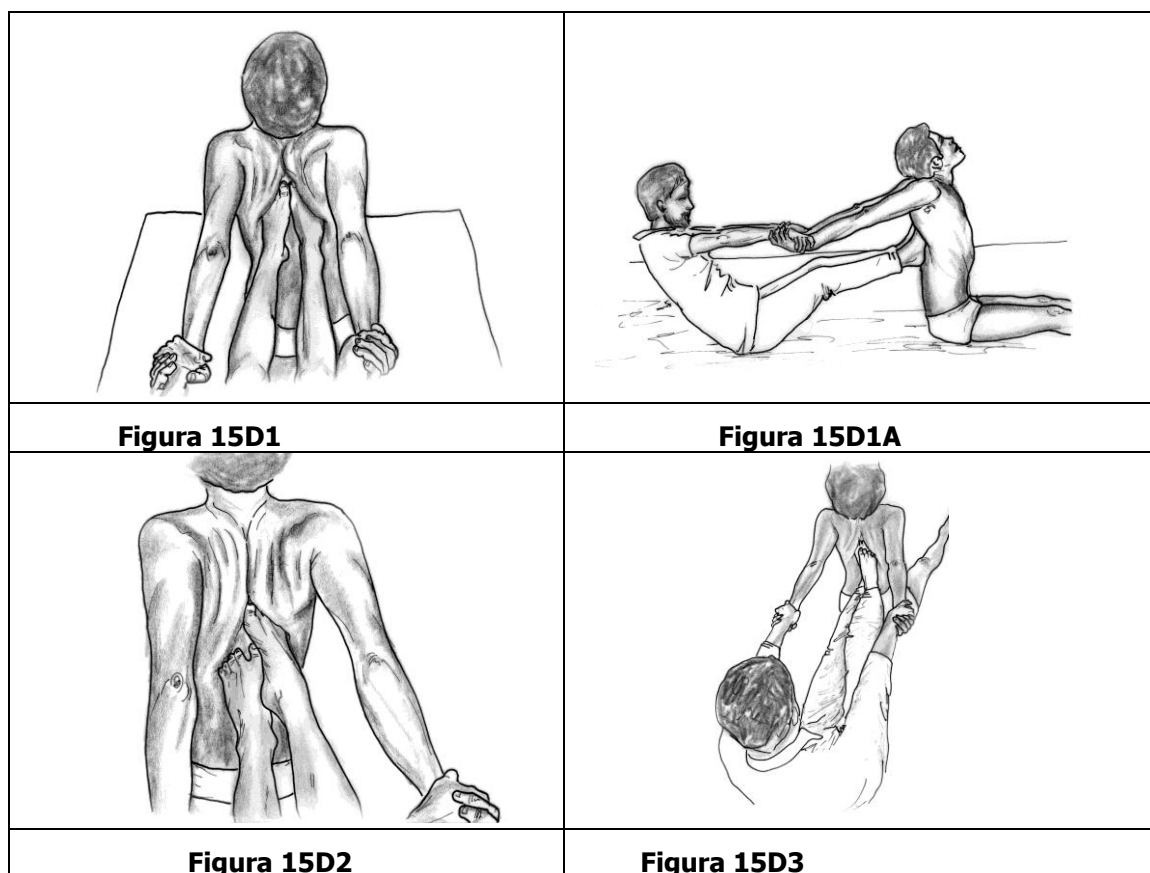
MANOBRA DE TRACÇÃO PARA ABERTURA DO 4º / 5º CHAKRAS E 6º CHAKRA

Manobra de tracção para abertura do peito, liberação de escápulas e alongamento da coluna:

O terapeuta solicita ao paciente que mude lentamente de decúbito ventral para decúbito dorsal e solicita ao mesmo, a seguir, que se sente com as costas rectas, pernas esticadas e semiabertas e braços estendidos para traz. O terapeuta senta-se atrás e mutuamente, paciente e terapeuta, seguram-se nos punhos. O terapeuta coloca os seus pés apoiando-os e introduzindo-os nas escápulas e, gradativamente, vai estirando os pés ao mesmo tempo que tracciona os braços do paciente para traz. Os pés deverão entrar progressivamente sob as escápulas, a tracção deve ser máxima, para com isso abrir o peito, a garganta e rectificar a coluna. O paciente deve olhar o máximo que puder para cima e para trás, centralizando seu olhar em direcção ao centro da testa. O terapeuta solicita que o mesmo mantenha o corpo solto e a barriga relaxada, a respiração livre e pela barriga. Esta posição deverá ser mantida por alguns segundos, pelo menos 3 respirações completas, e aos poucos o terapeuta vai afrouxando a tracção sem soltar os braços do paciente para iniciar uma nova posição. Figura 15D1.

Para executar o movimento que dá continuidade à posição anterior, lentamente, o terapeuta passa um dos seus pés para o centro da coluna do paciente, na altura do chakra cardíaco, vértebras dorsais ou lombares, dependendo dos problemas na coluna que o paciente possua, e a seguir coloca um pé sobre o outro. Figura 15D2.

O terapeuta tracciona novamente os membros do paciente, forçando para que a coluna se rectifique e o peito se abra. O paciente assume a mesma postura anterior e mantém-se da mesma forma. Após pelo menos mais 3 respirações completas, lentamente, o terapeuta dissolve a posição soltando os braços. O terapeuta solicita ao paciente para se manter estabilizado nesta posição por alguns segundos, com a coluna recta e peito aberto, para não colapsar o tronco, tendo como objectivo fazer com que o paciente sinta essa nova postura. A seguir solicita que o mesmo se deite lentamente e inicia a massagem na parte dianteira do corpo. Figura 15D3.



ALONGAMENTOS, TRAÇÕES, ETC..... NAS PERNAS – PARTE ANTERIOR

Em todas as trações na parte anterior do membro inferior, a coluna deve estar totalmente encostada no chão. Caso haja compensação, é necessário trabalhar mais a região lombar, que está encurtada. Durante o tratamento escolhemos uma das manobras que mais se adapta ao problema do paciente. Nesta primeira fase aprendemos apenas um tipo de alongamento, o mais básico de todos, e na fase seguinte os demais.

1º) Alongamento da musculatura adutora da coxa: o terapeuta posiciona-se junto aos pés do paciente, pega as duas pernas elevando-as e flexionando-as, colocando os pés do paciente no chão, segurando-os com os seus pés para fixá-los e, realiza uma abdução de ambas as pernas. A seguir, o terapeuta segurando nos joelhos do paciente, faz uma leve pressão para baixo em ambos os joelhos, abrindo-os para fora, até ao limite do paciente e, para forçar um pouco mais o alongamento, sobe nos pés do paciente. Se o terapeuta for muito pesado, sobe apenas com um dos pés controlando o peso do corpo. Segura por alguns segundos e solta. Figura 18D1.

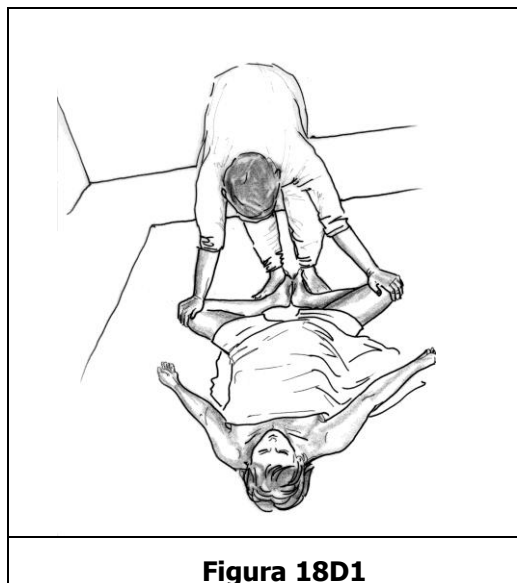
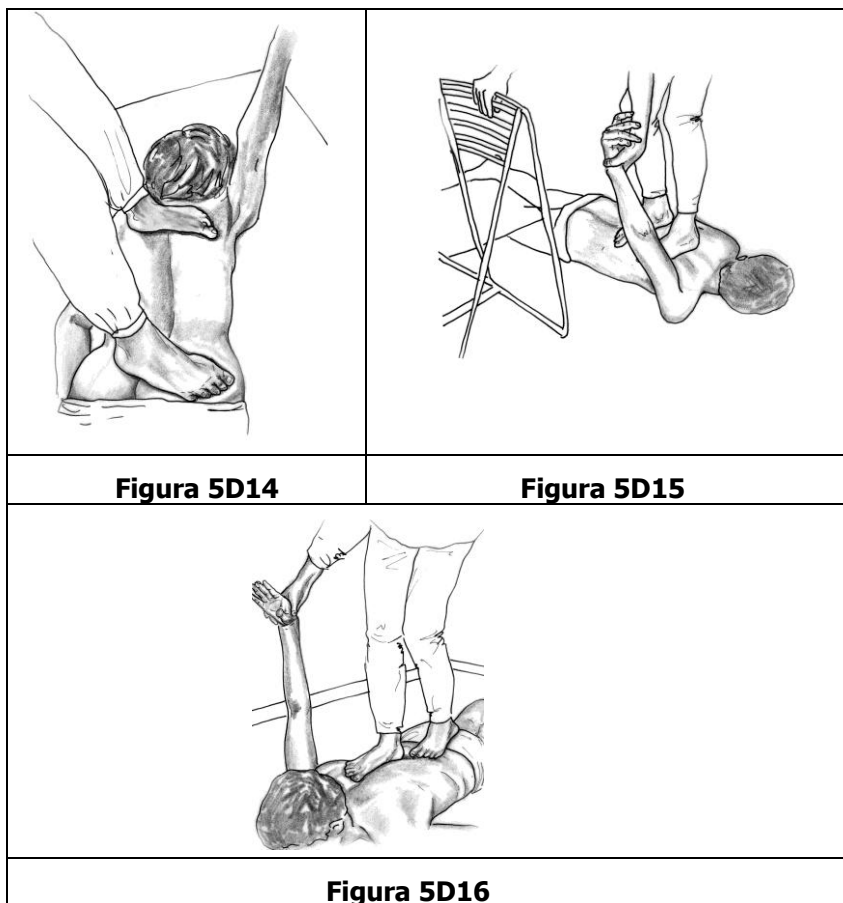


Figura 18D1

MOVIMENTOS ADICIONAIS

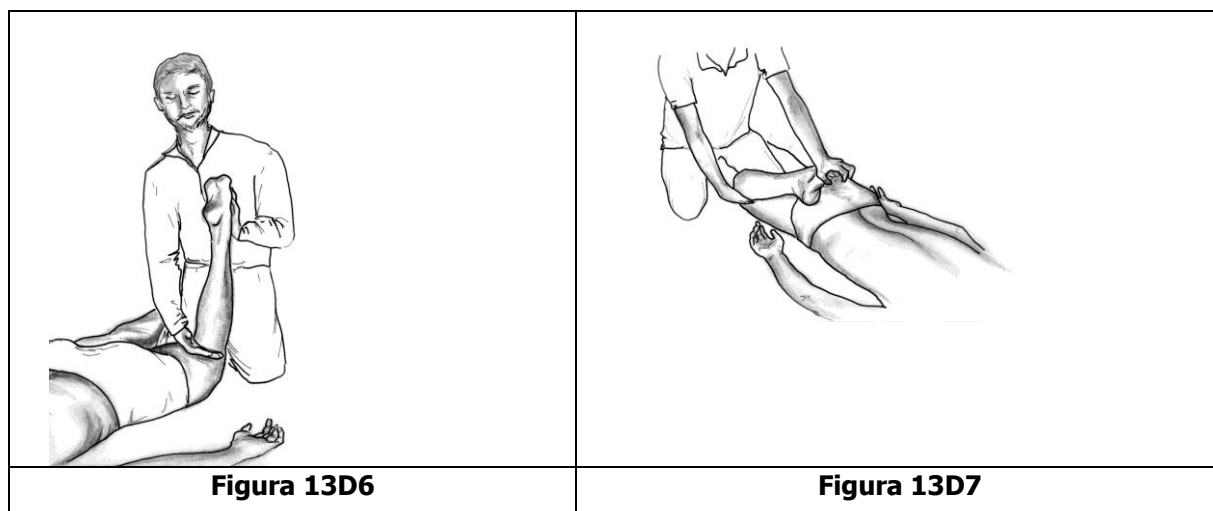
Quando os músculos já possuem mobilidade suficiente e o terapeuta já consegue introduzir com facilidade o pé dentro da omoplata pode-se, como alternativa, para abrir mais intensamente as omoplatas e dar maior mobilidade à musculatura e soltura da caixa torácica, realizar este movimento alternativo. As mãos do terapeuta seguram-se num banquinho ou cadeira para dar apoio. Um pé do terapeuta fica fixo em cima das nádegas ou em cima da caixa torácica e o outro é introduzido para dentro da omoplata. Uma das mãos do terapeuta permanece fixa em cima do banquinho, para dar sustentação ao movimento e ao terapeuta, enquanto que a outra busca a mão do paciente no chão para realizar a tracção posterior do braço com abertura da escápula. O terapeuta levanta o braço do paciente com a palma da mão para cima (membro superior em rotação interna), no máximo de extensão, sem dor articular, e faz o movimento de abdução da escápula exercendo tracção máxima sobre os músculos peitorais, se possível, e puxa o braço até ao seu limite máximo para cima para que o pé penetre mais profundamente na escápula. Esta manobra é realizada em continuação da abertura da escápula e só deverá ser feita quando já tivermos a mesma parcialmente ou totalmente aberta. A seguir, solta-se lentamente o braço ao longo do corpo e repete-se os deslizamentos com os pés nas costas e passa-se para o outro lado. **O terapeuta deve lembrar-se de que o rosto do paciente deve estar sempre voltado para o lado contrário a ser massajado.** Figura 5D14 – 5D15.

Um outro movimento que pode ser realizado nesta posição para alongar os músculos sem abrir a omoplata e ao mesmo tempo trabalhar a coluna em toda a sua extensão é este: o paciente fica deitado com os braços estendidos ao longo do corpo e com o queixo no chão. O terapeuta, com o auxílio de um banquinho, para apoiar-se e não perder o equilíbrio, segura com uma das mãos no mesmo. Coloca um dos pés no centro das nádegas do paciente e mais à frente coloca o outro pé. A outra mão do paciente pega o braço do paciente no chão e aos poucos vai levantando-o com a palma da mão para cima (membro superior em rotação interna), no máximo de extensão, sem dor articular, e aos poucos vai levando-o para a frente e andando sobre a coluna até atingir a região próxima a 7ª cervical. Segura por alguns segundos e retorna o braço do paciente à posição normal. Repete o mesmo processo com o outro braço. Figura 5D16.

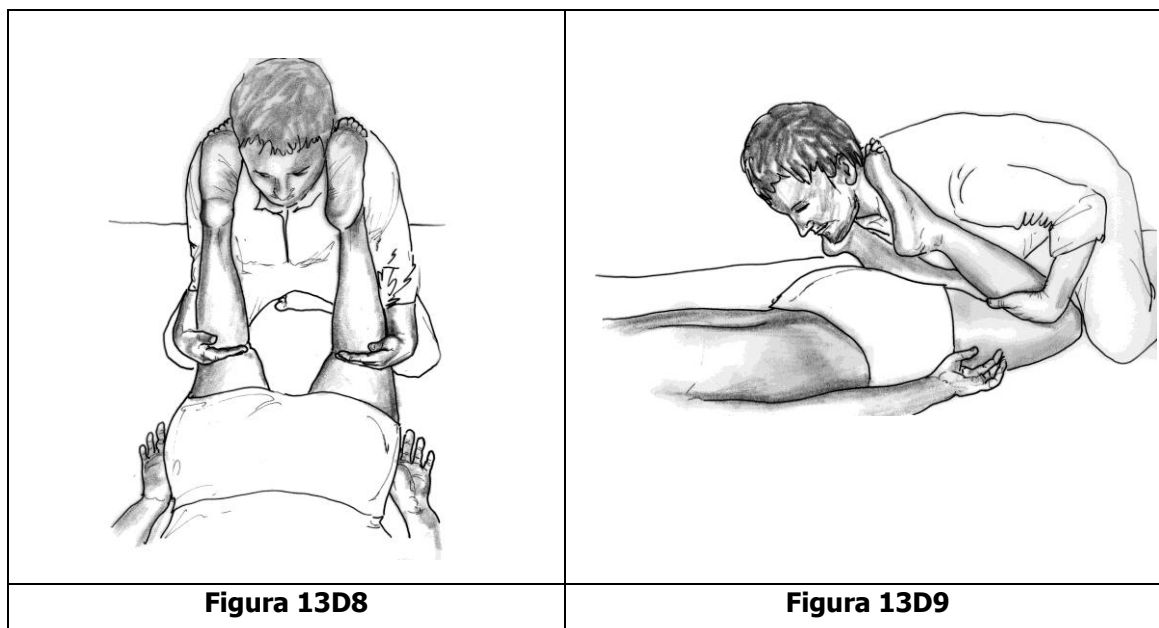


PERNAS – PARTE TRAZEIRA

Se o alongamento do paciente estiver em ponto máximo, o terapeuta pode ampliar ainda mais a extensão, colocando a mão aberta ou os dedos no cavo poplíteo. A seguir, empurra a perna do paciente, com flexão do joelho, até que o calcanhar encoste na região glútea. Figura 13D6 – 13D7.



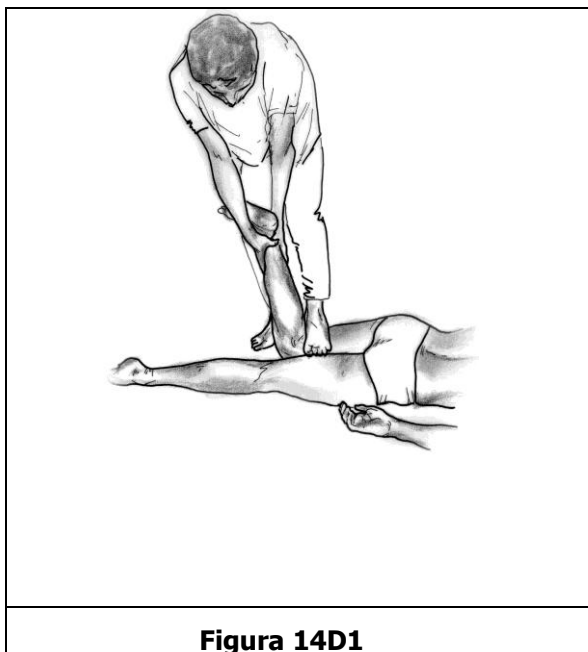
Pode realizar esta manobra nas duas pernas ao mesmo tempo. O terapeuta coloca as duas mãos entre os joelhos do paciente e suportando os dois pés do paciente no seu ombro, vai empurrando o seu corpo gradativamente em direcção aos glúteos, através da flexão do seu tronco. Figura 13D8 – 13D9.



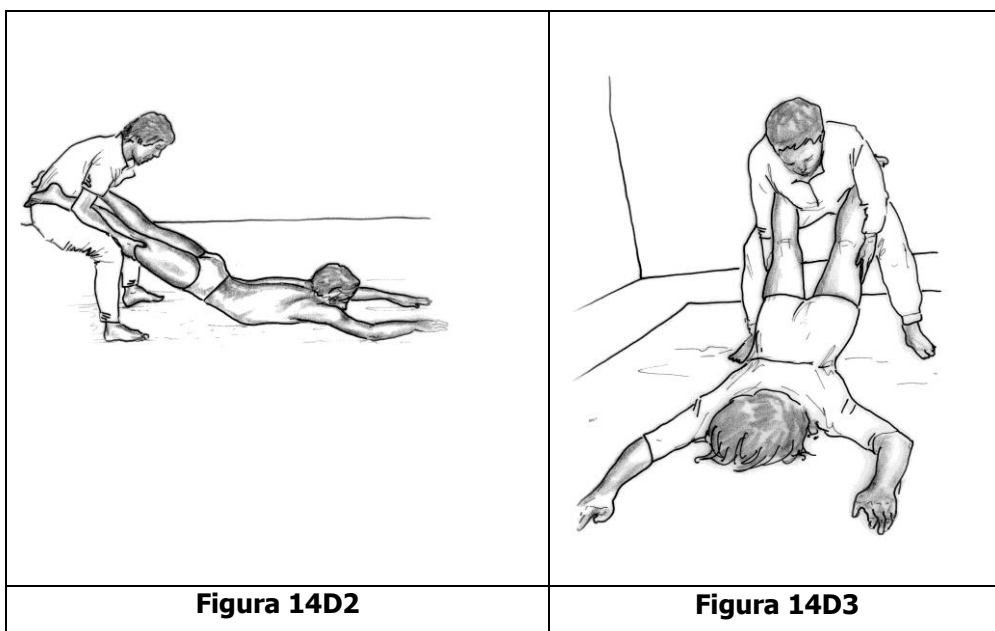
OUTROS ALONGAMENTOS A SEREM EFECTUADOS DE ACORDO COM OS PROBLEMAS APRESENTADOS PELO PACIENTE:

Estes alongamentos são opcionais. Se o terapeuta achar conveniente e o paciente necessitar deve-se introduzir apenas uma manobra por secção, mantendo-a até atingir o objectivo desejado. Assim que os objectivos forem atingidos, o terapeuta pode escolher outra manobra que o paciente necessite.

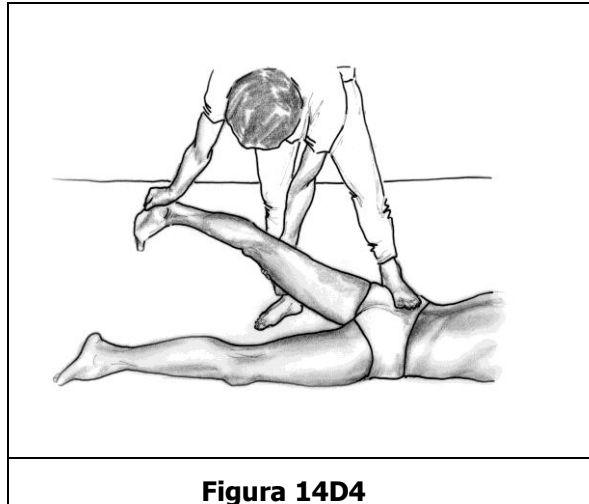
O paciente ainda em decúbito ventral. O terapeuta deve ficar em pé, entre os membros inferiores do paciente. Pega a perna do paciente na altura do tornozelo e faz a flexão do joelho a 90 graus. Apoia a planta de um dos seus pés na região que fica na articulação do joelho, e faz movimentos para frente e para trás, um rolar sobre a coxa, enquanto as suas mãos, que estão segurando no tornozelo e ante pé, puxam a perna do paciente para cima. Figura 14D1.

**Figura 14D1**

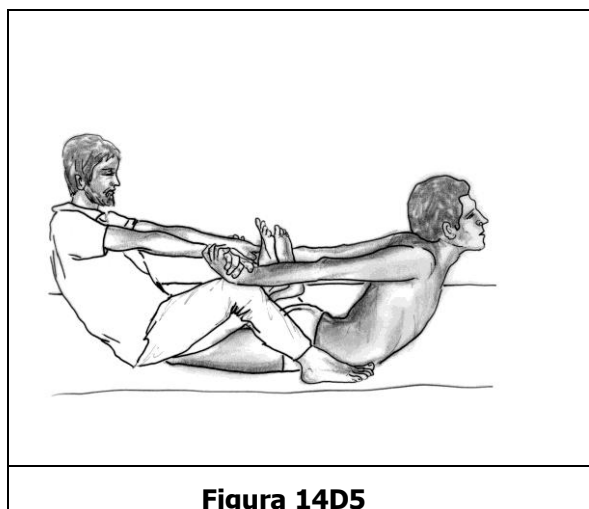
Tracção lombar. O paciente deitado em decúbito ventral, bem relaxado, com os braços estendidos para a frente. O terapeuta coloca-se atrás do paciente, em pé, em flexão de joelhos, apoia os joelhos do paciente nas palmas das mãos e eleva lentamente os membros inferiores em extensão para que fiquem apoiados no seu colo. O terapeuta vai adoptando uma posição de flexão do joelho ficando quase de cócoras, e transfere o peso do corpo para traz, realizando uma tracção de toda a região lombar. Este movimento adquire um vai e vem lento para que seja obtido um maior alongamento da musculatura das pernas. Ao puxar, o terapeuta solicita ao paciente que contraia o anus e prenda a respiração para obter assim um maior efeito na circulação da energia para os chacras superiores. Este movimento é altamente benéfico para quem possui a bacia fora do lugar e auxilia também na extensão dos músculos da perna. Figura 14D2 – 14D3.

**Figura 14D2****Figura 14D3**

Extensão do joelho. Paciente deitado em decúbito ventral. O terapeuta fica na lateral do paciente, na altura do joelho. Fixa um dos pés sobre a pelve do paciente, do lado que vai ser alongado, e pega o joelho do paciente na porção anterior com uma de suas mãos. Com a outra mão segura no calcanhar, levanta a perna e faz pressão para baixo para estender o joelho. A pressão é feita pela mão que está segurando no calcanhar. A outra mão unicamente segura o joelho. O terapeuta mantém um certo tempo a pressão e quando estiver em tracção máxima, antes de soltar, realiza um vai e vem com intervalo para estender um pouco mais o joelho e alongar a musculatura posterior da perna. Figura 14D4.

**Figura 14D4**

Abertura do peito com extensão máxima da região anterior da perna e articulação dos joelhos. O terapeuta posiciona-se sentado na parte posterior do paciente, que está deitado em decúbito ventral. Com as duas mãos segura as pernas do paciente, na altura do ante pé, empurrando-as em direcção às nádegas do paciente e a seguir prende-as com as suas pernas. Paciente e terapeuta seguram-se pelo punho. O terapeuta passa a puxar o corpo do paciente para traz orientando-o para manter a cabeça em direcção ao céu e os olhos em direcção ao centro da testa. Pede para que solte a respiração e relaxe a barriga. Esta manobra de tracção, para além de estender os músculos, abre o chacra do plexo solar, cardíaco, laríngeo e terceiro olho. O terapeuta mantém esta posição pelo menos durante três respirações completas e lentamente vai soltando. Figura 14D5.

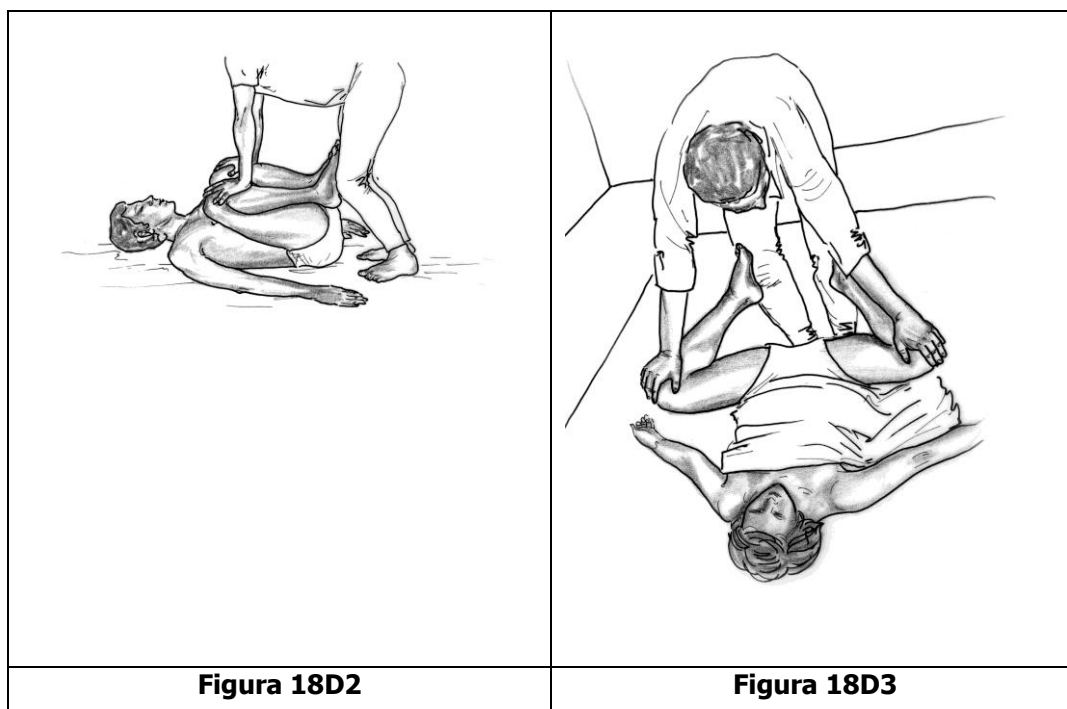
**Figura 14D5**

As manobras específicas para os membros inferiores, região posterior, são indicadas para problemas de joelho, ciática, renais, etc.. Alonga as musculaturas situadas na parte anterior do corpo e auxilia a eliminar toxinas, e abre os vórtices de energia frontais. Lembre-se de que estas manobras só serão realizadas opcionalmente. São complementares à massagem. Faça apenas uma por secção, se o paciente necessitar.

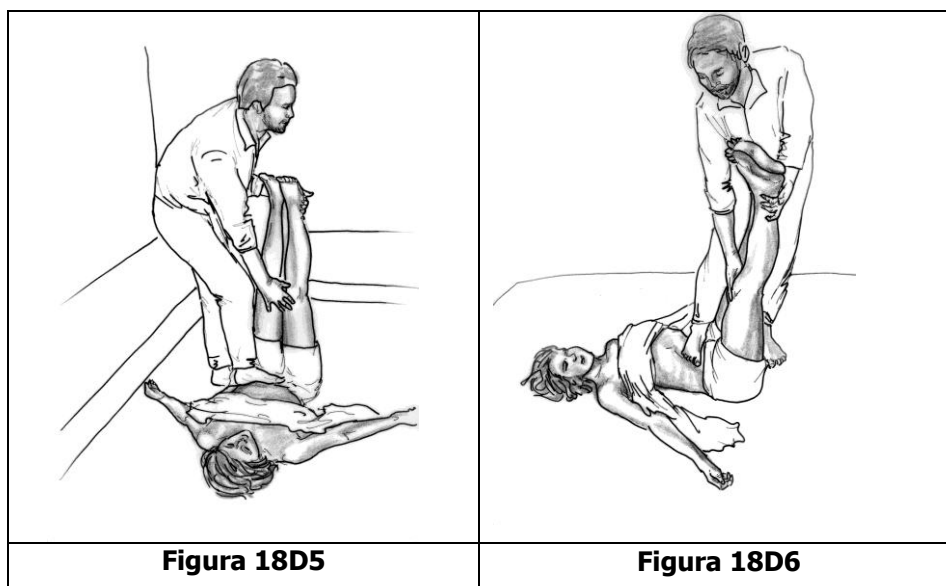
ALONGAMENTOS, TRAÇÕES, ETC..... NAS PERNAS – PARTE ANTERIOR

Alongamento da musculatura posterior do tronco. Paciente em decúbito dorsal apoia os dois pés no joelho do terapeuta, que força a flexão máxima dos dois joelhos em direcção ao abdome do paciente e, a seguir exerce leve pressão sobre esta região. É importante nesta manobra ter cuidado para não elevar a coluna do chão. Mantém-se a pressão por alguns segundos, afrouxa-se e ao retornar mantém-se os pés do paciente apoiados na coxa do terapeuta, para a realização do alongamento da musculatura adutora da coxa. Figura 18D2.

Alongamento da musculatura adutora da coxa: É realizada pelo terapeuta uma abdução de ambas as pernas com o paciente mantendo os joelhos flexionados e pés apoiados na coxa do terapeuta. O terapeuta exerce uma leve pressão para baixo nos joelhos do paciente ao mesmo tempo que abre as pernas, para alongar a musculatura adutora. Figura 18D3.



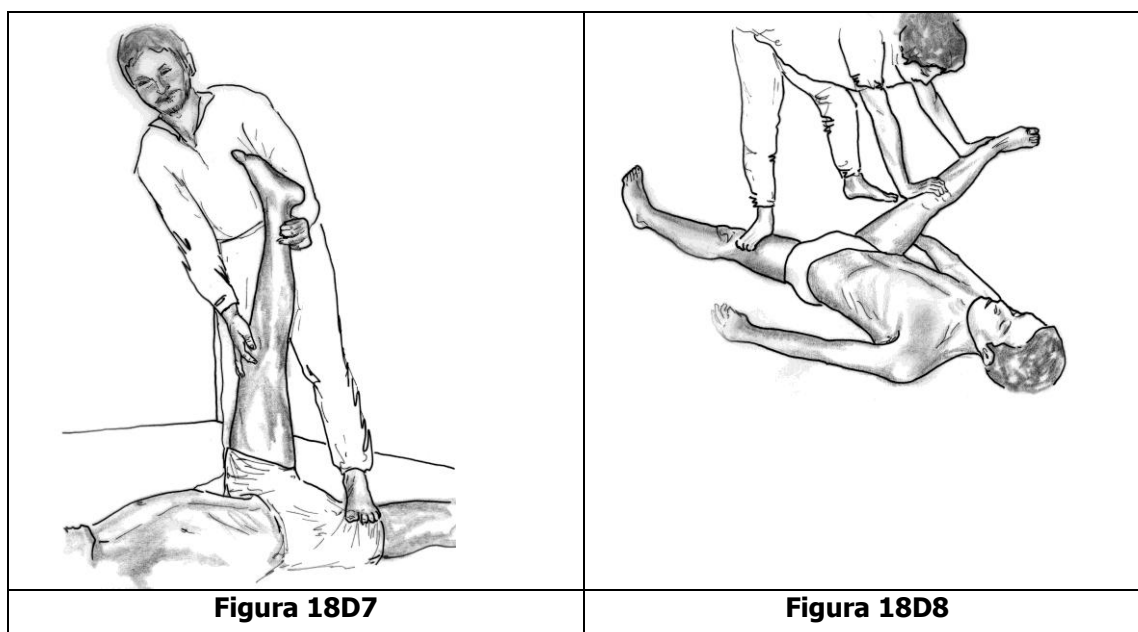
Alongamento de isqueos tibiais com fixação da pelve. Paciente em decúbito dorsal. O terapeuta eleva as duas pernas do paciente pelos tornozelos e os apoia em seu antebraço de forma paralela. A outra mão procura apoio na região dos joelhos para que a perna não se dobre. Apoia o pé na região abdominal do paciente, a fim de que a coluna não se eleve, e lentamente vai aproximando a flexão do quadril a 90 graus, solicitando a extensão do joelho com a mão que está apoiada no mesmo e, quando chegar ao seu limite máximo, pedir também a flexão dorsal dos pés. O terapeuta deve estar atento para que o quadril não se eleve. Abaixar lentamente após manter essa tracção por alguns segundos. O terapeuta aproveita este momento para dar seguimento a outro movimento: segura uma das pernas para realizar o mesmo movimento numa perna de cada vez, como veremos a seguir. Figuras 18D5 - 18D6.



Alongamento dos isquios tibiais - uma perna de cada vez. O terapeuta pega um dos pés do paciente pelo tornozelo e apoia-o em seu antebraço, sendo que a outra mão fica na parte anterior do joelho, mantendo-o em extensão. A outra perna mantém-se no solo, com o joelho em extensão e o terapeuta suporta-a com o seu pé, na parte média da coxa. Lentamente, através do movimento do seu antebraço e do seu tronco, que se dirige para a frente, faz com que todo o membro inferior chegue a uma flexão de 90 graus de flexão do quadril, com extensão máxima do joelho. Figura **18D7**

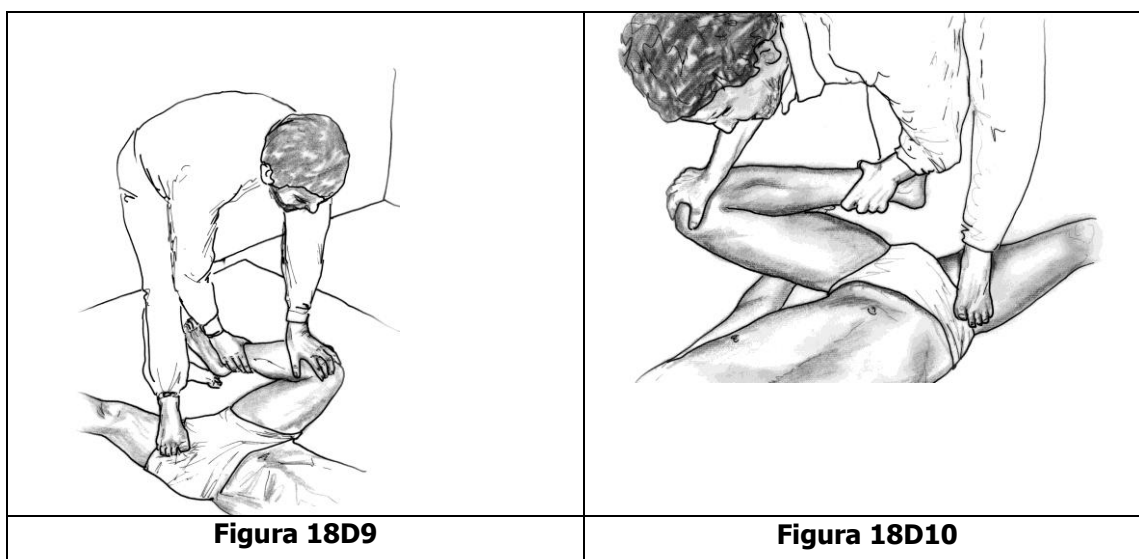
Faz antes de passar para a outra perna a seguinte sequência:

Na sequência do movimento anterior, lentamente, leva a perna em direcção ao chão para realizar o alongamento também da musculatura adutora da coxa, com a perna estendida, procurando abri-la em extensão máxima. O terapeuta deve ter uma mão segurando a perna no tornozelo e a outra apoiada nos joelhos e um pé apoiado na parte média das coxas do paciente para que o quadril não se levante. Depois realiza as mesmas manobras na outra perna. Figura 18D8

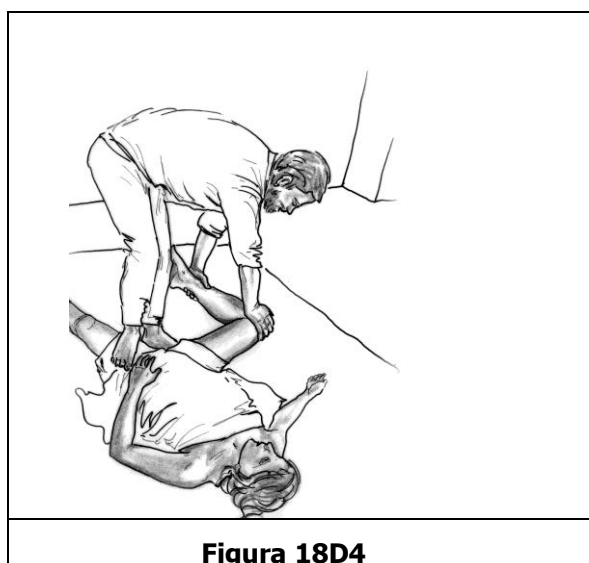


Alongamento da musculatura posterior do tronco - uma perna de cada vez. O terapeuta fixa uma das pernas do paciente pisando levemente na parte superior da coxa, para não haver levantamento do quadril e, com as mãos levanta a outra perna abduzindo-a e levemente vai empurrando-a em direcção ao abdómen até ao limite máximo. Força um pouco, sem que o quadril se levante, segura por alguns segundos e passa para o movimento seguinte na sequência deste. Figura 18D9.

Alongamento da musculatura adutora da coxa. Paciente e terapeuta na mesma posição que a manobra anterior. A variante será o alongamento da musculatura adutora da coxa em rotação para fora, de forma oblíqua, e em direcção ao chão, na lateral. Para realizá-la, o terapeuta segura o tornozelo com uma das mãos e com a outra mão flexiona a perna em direcção ao abdómen e vai rodando todo o membro inferior para fora em seu máximo de abdução: a força é para fora e para baixo na direcção oblíqua lateral. Para não haver compensações na pélvis um dos pés do terapeuta apoia e prende a parte média da coxa. Realiza a mesma manobra na outra perna. Figura 18D10.

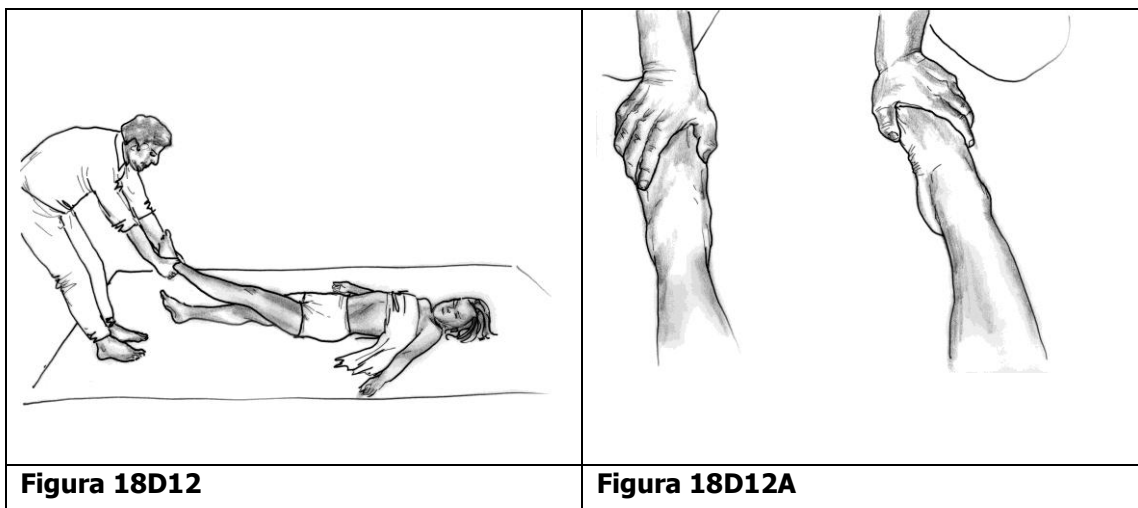


Alongamento da musculatura adutora da coxa - uma perna de cada vez: o terapeuta fixa a coxa do paciente com um dos pés, para evitar compensações da pélvis, abduz a perna do paciente com o joelho em flexão, segura com uma das mãos no tornozelo e, com a outra mão apoiada em cima do joelho força a perna em direcção ao chão procurando obter a extensão máxima da musculatura adutora da coxa. O terapeuta pode realizar um pequeno vai e vem para forçar ainda mais o alongamento. Realiza o mesmo movimento na outra perna. Figura 18D4.



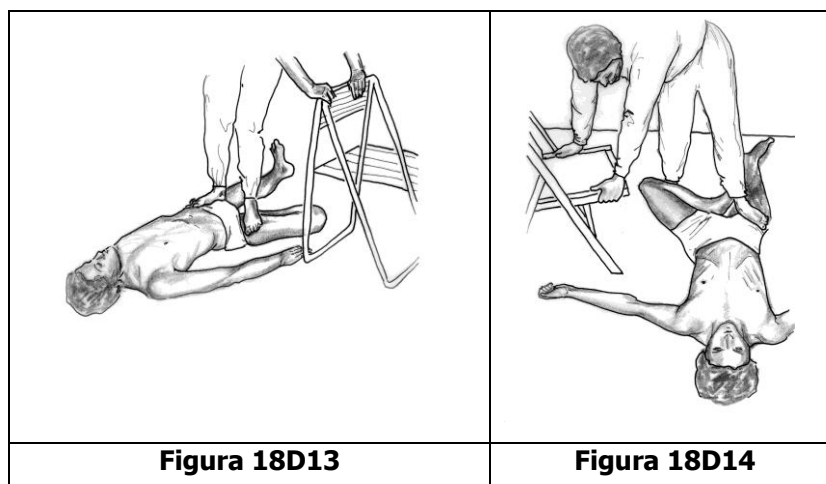
Paciente em decúbito dorsal, com as pernas estendidas e relaxadas. O terapeuta segura com as duas mãos o calcanhar e o ante-pé de uma das pernas elevando-a um pouco puxa-a em direcção a si, estendendo-a ao máximo. Faz o mesmo com a outra perna. Figura 18D12.

O terapeuta pode puxar as duas pernas ao mesmo tempo também, como alternativa para alongar ainda mais. O terapeuta aproveita e segura na ponta dos pés para alongar também a musculatura superior do pé. Figura 18D12A



Paciente em decúbito dorsal com uma das pernas em abdução e a outra com o joelho estendido. O terapeuta apoia as mãos sobre uma cadeira, para balancear o peso da parte do seu corpo que vai estar em cima do paciente, e coloca primeiro um pé em cima da parte superior da coxa da perna estendida do paciente, espinha ilíaca anterior, e o outro pé na região média da coxa da perna em abdução e faz duas ou três pressões sobre a mesma, provocando uma certa rotação lateral da pélvis. Ao descer, o terapeuta tira primeiro o pé que está sobre a pélvis e depois o outro. Esta tracção só será realizada quando o paciente possuir uma boa abertura nos músculos em abdução e tem como objectivo ampliá-la um pouco mais. Deverá ser realizada sem provocar dor ou compensação na coluna lombar. Figura 18D13.

Se a musculatura adutora da coxa do paciente ainda estiver curta o terapeuta, ao subir, coloca primeiro um pé em cima da parte superior da coxa da perna estendida, espinha ilíaca anterior e, neste caso, o terapeuta coloca o outro pé na região próxima do joelho da perna em abdução. O peso do terapeuta deve ficar, a princípio, no pé que está sobre a coxa da perna estendida. Figura 18D14.

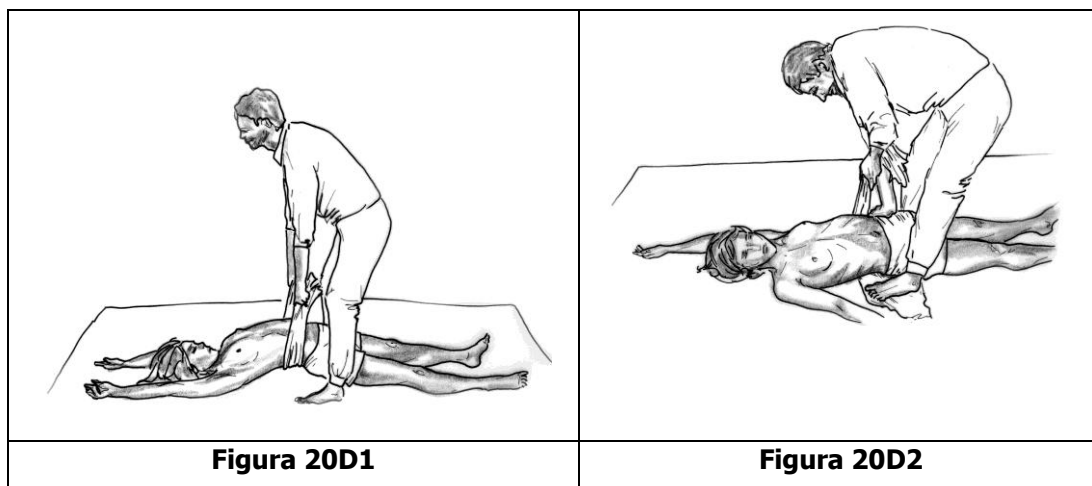


Assim que o terapeuta colocar o pé na região próxima do joelho da coxa da perna abduzida, realiza um vai e vem alternando o peso entre um pé e o outro. Esse movimento roda a pélvis de um lado para outro e é muito agradável. Ao executar o movimento o terapeuta deve soltar completamente o peso de um dos pés e lentamente e levemente passar o peso para o outro pé. Esse movimento ao fazer a pélvis rodar naturalmente, libera o movimento natural do quadril para além de alongar os músculos da perna abduzida. O terapeuta realiza esta manobra de ambos os lados do corpo do paciente e deve fazer pelo menos três rotações em cada perna.

MOVIMENTO ESPECIAL NA BARRIGA E QUADRIL

Depois de terminar a massagem na barriga pode-se realizar esse movimento especial para realinhamento do quadril, ossos da bacia, coluna vertebral e caixa torácica, se o paciente necessitar. Para a realização desta manobra o paciente deverá estar deitado, relaxado, com os braços estirados acima da cabeça. O terapeuta deve ficar em pé, na altura do quadril, e introduzir uma toalha grande dobrada na altura do 2º chakra, dois dedos e meio abaixo do umbigo. O paciente deverá manter a respiração normal. Aos poucos, o terapeuta eleva o corpo do paciente levantando a toalha com as duas mãos. O corpo todo levanta-se, na altura da barriga, formando uma curva. O paciente deve relaxar e deixar a respiração fluida para colher os benefícios desta posição. Depois de alguns segundos lentamente o terapeuta desce a toalha. Figura 20D1.

A seguir, com a toalha em baixo do paciente, o terapeuta levanta um dos lados com uma das mãos para trabalhá-lo em torção. O outro lado do corpo permanece encostado no chão. Para que a toalha e o corpo não escorreguem, o terapeuta sustenta-a com o pé pisando firmemente e junto ao corpo. Segurando nesta posição de torção, o terapeuta realiza com uma das mãos o alongamento para a lateral da parte do quadril que está no ar, empurrando-o para baixo e para fora, enquanto o segura com a toalha no ar. Esta posição ajuda enormemente pessoas que possuam problemas de apêndice, desvios na bacia e coluna vertebral. Após a realização desta torção, lentamente, o terapeuta desfaz a posição e realiza a mesma manobra do lado oposto. Figura 20D2.

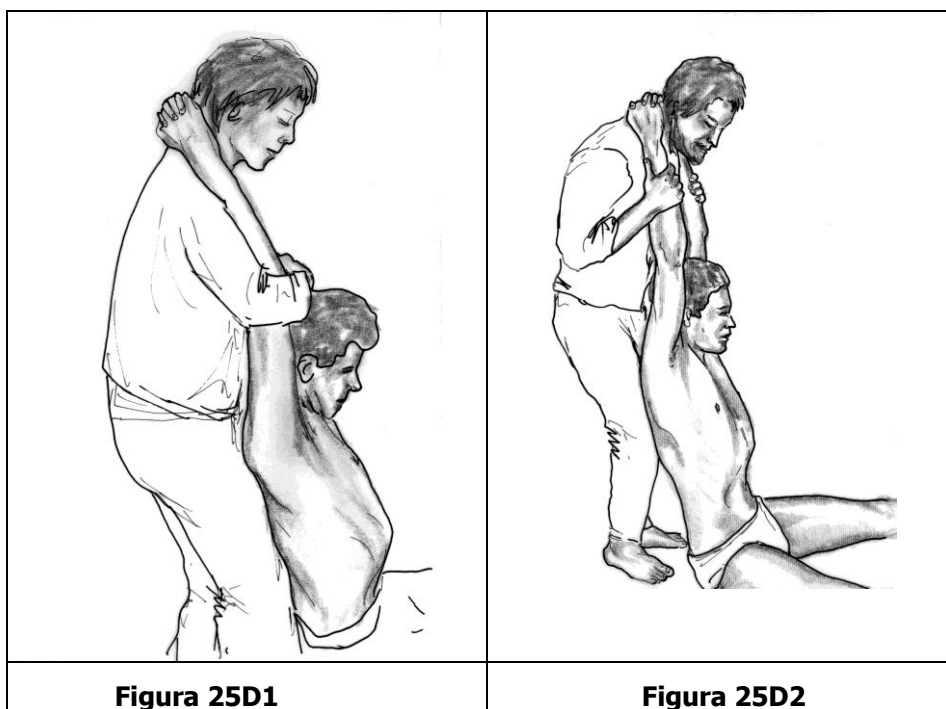


TRAÇÕES E ALONGAMENTOS QUE PODERÃO SER REALIZADOS DEPOIS DA MASSAGEM NOS BRAÇOS:

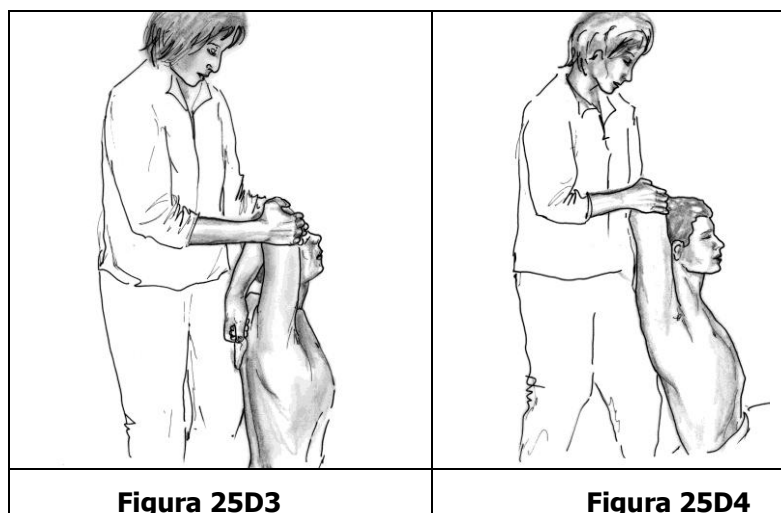
Estes movimentos devem ser realizados com a máxima atenção por parte do terapeuta. O terapeuta deve identificar o problema que o paciente tem, e escolher a manobra que mais convém para o alongamento desejado.

O terapeuta pede ao paciente para se sentar e permanecer com as pernas ligeiramente abertas para lhe dar sustentação. O corpo deve estar relaxado e a coluna recta. Esta posição é a ideal para que o terapeuta realize algumas trações e alongamentos em toda a coluna vertebral e músculos peitorais.

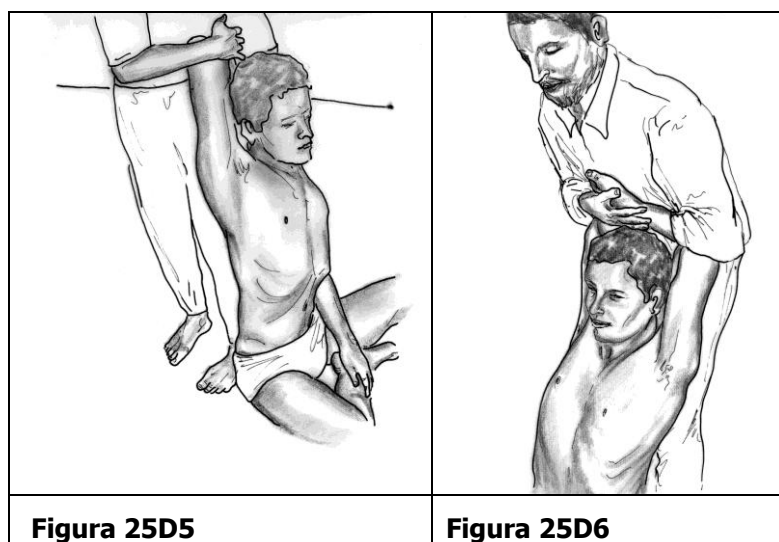
1º) O terapeuta deve ficar em pé atrás do paciente. O paciente entrelaça os dedos em volta do pescoço do terapeuta. O terapeuta encosta as pernas no paciente, para dar apoio e não deixar a coluna lordosar. O terapeuta segura nos braços do paciente na altura do cotovelo, no sentido de alongar os braços, e realiza um pequeno levantamento do paciente procurando alongar a sua coluna. O terapeuta ao mesmo tempo que levanta o corpo do paciente, empurra para a frente a coluna vertebral com as pernas (joelhos) do mesmo, num vai e vem. Segura alguns instantes e lentamente solta. A respiração deve manter-se normal. O corpo do paciente deve ser mantido bem relaxado. Esta postura alonga a coluna e auxilia na abertura da caixa torácica e chakra cardíaco. Figuras 25D1 – 25D2.



O terapeuta permanece na mesma posição da manobra anterior. O terapeuta solicita um dos braços do paciente e dobra-o acima dos ombros do paciente colocando a mão na parte traseira do ombro. O outro braço do paciente fica solto ao longo do corpo. O terapeuta apoia uma das suas mãos em cima da mão do paciente na parte traseira do ombro e com a outra mão segurando na altura do cotovelo do braço do paciente, puxa-o para traz procurando alongar ao máximo toda a musculatura dessa região. Com as pernas apoiadas nas costas do paciente, concomitantemente, o terapeuta levemente empurra para a frente o corpo do paciente. O terapeuta pode realizar um pequeno vai e vem para alongar ainda mais a musculatura. O corpo do paciente deverá estar o tempo todo erecto sem pender para nenhum lado. Esta manobra ajuda a abrir os vórtices de energia do pulmão e a caixa torácica, para além dos alongamentos musculares. Realiza-se da mesma forma do outro lado. Figuras 25D3 – 25D4 – 25D5.



O terapeuta realiza a mesma manobra anterior com os dois braços do paciente dobrados ao mesmo tempo. Os cotovelos devem ser mantidos paralelos. Os joelhos do terapeuta permanecem encostados na coluna do paciente. Nesta posição, o terapeuta entrelaça os braços do paciente e puxa-os para traz ao mesmo tempo que empurra suavemente a coluna para a frente. Ocorre neste movimento o alongamento dos músculos e tendões dos braços além da abertura do peito com rectificação da coluna. Favorece também a abertura do chacra cardíaco. Figura 25D6.



Caso o paciente tenha uma boa abertura, as mãos e os braços do terapeuta podem passar para traz da cabeça do paciente para alongar ainda mais. Figura 25D7.

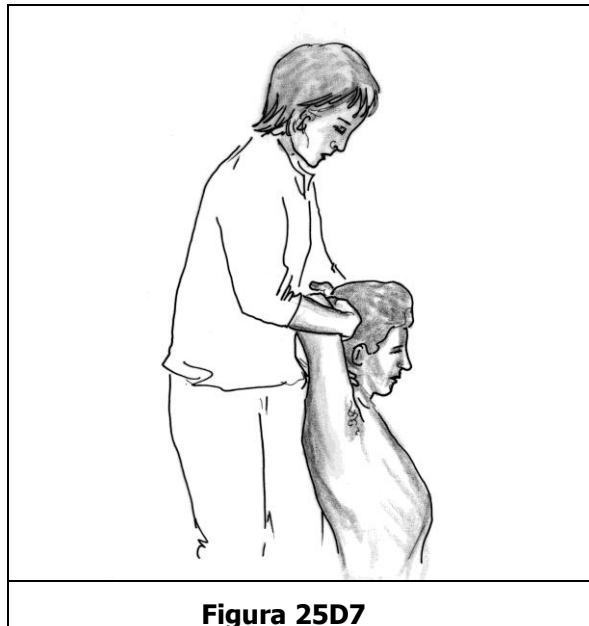


Figura 25D7

OUTROS MOVIMENTOS ESPECIAIS A SEREM EXECUTADOS NA CAIXA TORÁCICA, MUSCULOS TRAPEZOIDAIS E OMBROS

O terapeuta suporta as costelas flutuantes do paciente, uma mão de cada lado, com a polpa dos dedos. Apoia os seus braços sobre o peito do paciente e tracciona para cima a caixa torácica do paciente ao mesmo tempo que pressiona os ombros do mesmo para baixo com o seu cotovelo. Neste ponto do trabalho o terapeuta solicita ao paciente que inspire e expire relaxadamente. Essa manobra abre as costelas e toda a caixa torácica. Figura 22D11.

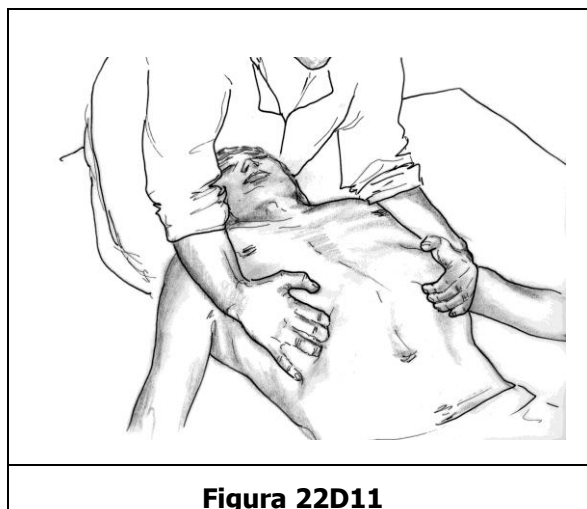
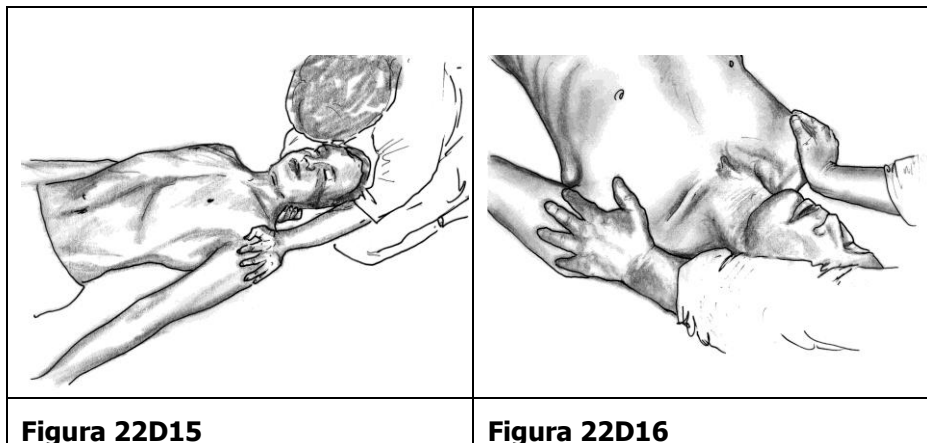


Figura 22D11

O terapeuta segura a nuca do paciente e tracciona-a com uma das mãos em direcção cefálica e com a

outra empurra o ombro contra-lateral para baixo. Pede ao paciente para relaxar. Repete-se do outro lado. Figura 22D15.

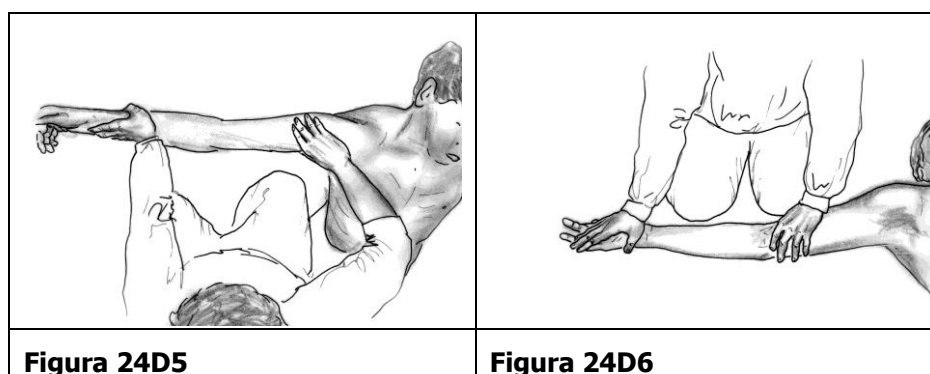
O terapeuta coloca as mãos sobre os ombros do paciente e empurra várias vezes para o solo e para baixo. Figura 22D16.



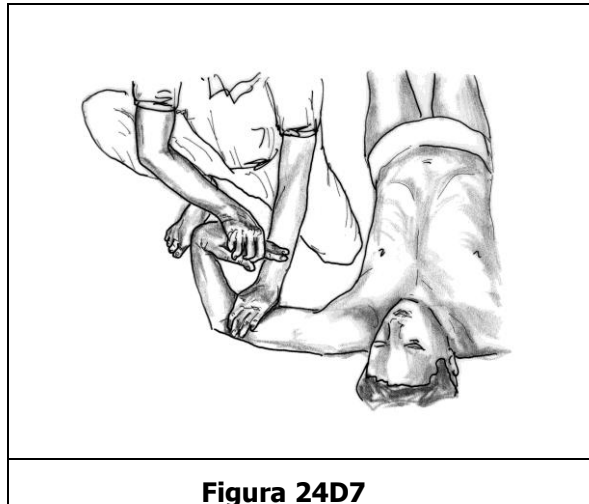
MASSAGEM NOS MEMBROS SUPERIORES – BRAÇOS ESTENDIDOS COM A PALMA DA MÃO VOLTADA PARA CIMA

Se o paciente tem a musculatura do braço muito tensa e curta o terapeuta deve fazer alguns movimentos de massagem especiais para conseguir estender e alongar essa musculatura. O terapeuta eleva o braço do paciente até que ele forme um ângulo de 90° com o corpo e passa a realizar massagens nesta posição com a palma das mãos e com a polpa dos dedos. Figura 24D5.

O terapeuta inicia nos músculos superiores do braço pressionando-os para baixo e desliza até à palma das mãos do paciente. A polpa dos dedos deve também actuar fazendo pressão e soltura dos músculos de todo o braço. Figura 24D6.

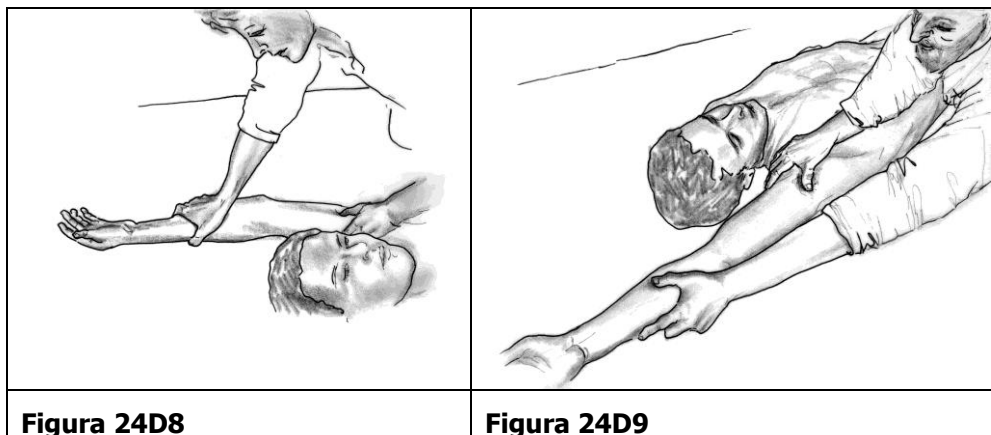


Pode nesta posição realizar também uma massagem elevando o braço do paciente e dobrando-o juntamente com a mão a 90°. Faz massagens na massa muscular do braço alongando-a, ao mesmo tempo que mantém o alongamento da musculatura do dorso da mão que deve estar também a 90° do braço. O terapeuta inicia a massagem nos ombros e termina prendendo a região interna do cotovelo com a sua palma da mão forçando-a em direcção ao solo, ao mesmo tempo que faz o alongamento dos músculos dorsais da mão do paciente. Figura 24D7.

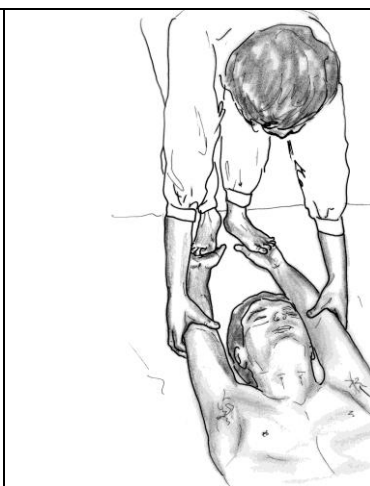
**Figura 24D7**

Após realizar a manobra nesta posição, o terapeuta eleva o braço do paciente até que fique acima da cabeça do paciente e realiza com mais vigor uma massagem profunda com a palma das mãos e com a polpa dos dedos polegares, procurando estender ao máximo toda a musculatura para cima. Figura 24D8.

Procura também abrir ao máximo a região escapular, pressionando o meio da axila com o polegar. Nesta região situa-se um vórtice de energia importante. Figura 24D9.

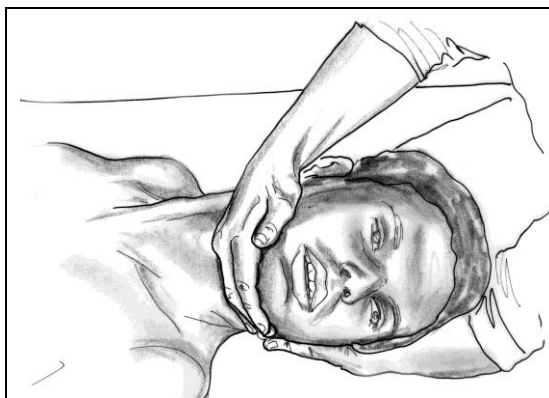
**Figura 24D8****Figura 24D9**

Quando o braço estiver em extensão máxima, o terapeuta realiza, após ter feito massagem nos dois braços, a seguinte manobra de alongamento da musculatura do braço, caso seja necessário, para dar uma maior abertura para a caixa torácica do paciente. O terapeuta coloca os dois braços do paciente em amplitude e extensão máxima acima do corpo, posicionando-se atrás do paciente, em pé, e prende com os seus pés a palma das mãos do paciente contra o solo segurando-os em extensão máxima. A massagem pode ser estendida até à ponta dos dedos, e com as suas mãos força a rotação externa dos membros superiores empurrando-os a seguir em direção ao solo. Primeiro realiza segurando na região próxima dos ombros (figura 24D10) depois junto aos cotovelos (figura 24D11).

**Figura 24D10****Figura 24D11**

MASSAGEM NOS MEMBROS SUPERIORES - PESCOÇO

Depois de terminar a massagem no pescoço se as vértebras cervicais ainda estiverem ainda tensas e comprimidas, o terapeuta realiza o alongamento das mesmas. Ainda na posição com a cabeça de lado, uma mão na nuca e a outra no queixo do paciente o terapeuta realiza uma pequena tracção para cima, puxando o queixo para traz em seu máximo, procurando alongar intensamente o pescoço. Feito isso, realiza a mesma manobra do outro lado. Figura 26D12 – 26D13.

**Figura 26D12****Figura 26D13**

Após realizar as massagens do outro lado, retorna lentamente a cabeça na posição normal e ainda com uma mão na nuca e a outra no alto da cabeça tracciona o pescoço para trás. A seguir lentamente levanta a cabeça do paciente procurando encostar o queixo no peito. O terapeuta procura ir até o ponto máximo e lentamente retorna a cabeça para a posição normal. O paciente deve manter a cabeça e o pescoço bem relaxados e soltos. Figura 26D14.

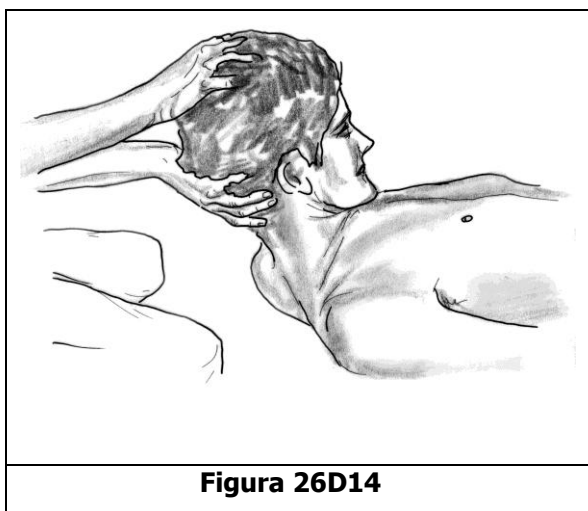


Figura 26D14

ANEXO: TABELA COM PROPRIEDADES DOS ÓLEOS ESSENCIAIS

LEGENDA R – Óleo Relaxante Rg – Óleo Regenerativo E – Óleo estimulante	Propriedades principais do óleo	Acne	Ansiedade	Artrite	Hipertensão	Hipotensão	Odor Corporal	Celulite	Constipações	Obstipação	Depressão	Diarreia	Eczema	Desmaios	Dor de Cabeça
Manjerição	R Rg		X						X		X			X	X
Louro	R			X			X								
Benjoim	E			X			X		X						
Bergamota	R Rg	X	X								X				
Cedro	R	X											X		
Camomila	R	X	X	X						X	X	X	X	X	X
Canela	R					X			X			X			
Consolda	R											X			
Cipreste	R		X				X	X			X	X	X		
Eucalipto	E	X		X					X			X			X
Funcho	E									X					
Incenso	R								X						
Gerânio	R Rg	X							X		X	X	X		
Hissopo	R E				X	X			X				X		
Jasmim	R		X								X		X		
Zimbro	R Rg	X	X					X				X	X		
Alfazema	R, Rg	X	X	X	X		X		X		X	X		X	X
Limão	E	X			X				X			X			
Erva-limão	E	X					X				X				X
Manjerona	R		X	X	X					X					X
Melissa	R Rg		X		X							X			X
Mirra	E								X			X	X		
Nérolí	R		X				X				X				
Laranja	Rg		X		X					X	X				
Salsa	E														
Pachuli	R	X	X					X			X		X		
Hortelã Pimenta	E					X	X					X		X	X
Pinheiro	E			X			X		X						
Rosa	R		X	X						X	X				
Alecrim	E					X		X	X	X	X			X	X
Salva	E		X		X						X				
Salva-brava	R E		X		X						X				
Sândalo	R	X	X								X		X		
Malaleuca	E								X						
Tomilho	E		X												
Ylang-ylang	R		X		X						X				

LEGENDA R – Óleo Relaxante Rg – Óleo Regenerativo E – Óleo estimulante	Propriedades principais do óleo	Regulação Hormonal	Indigestão	Insônia	Problemas de Menopausa	Problemas Menstruais	Menstruação Irregular	Menstruação Dolorosa	Fadiga Psicológica	Dores Musculares	Náuseas	Obesidade	Síndrome Pré Menstrual	Reumatismo	Problemas Sexuais	Sinusite	Stress	Retensão de Líquidos
Manjerição	R Rg		X		X				X		X		X					
Louro	R													X				
Benjoim	E																	
Bergamota	R Rg																	
Cedro	R			X											X			
Camomila	R	X	X	X	X	X	X	X					X	X			X	
Canela	R									X					X			
Consolda	R					X		X		X								
Cipreste	R			X	X		X			X		X	X	X				X
Eucalipto	E									X				X		X		
Funcho	E				X						X	X						
Incenso	R			X														
Gerânio	R Rg	X			X								X		X		X	X
Hissopo	R E			X		X												
Jasmim	R							X							X			
Zimbro	R Rg		X			X	X	X	X				X	X				X
Alfazema	R Rg		X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X	X
Limão	E		X		X									X				
Erva-limão	E		X															
Manjerona	R		X	X				X		X				X			X	
Melissa	R Rg	X	X		X	X	X	X	X		X		X				X	
Mirra	E		X															
Néoli	R			X	X								X	X		X		
Laranja	Rg	X	X		X													
Salsa	E																	X
Pachuli	R											X			X			
Hortelã Pimenta	E		X								X						X	
Pinheiro	E								X	X				X		X		X
Rosa	R			X	X	X	X	X			X		X		X			
Alecrim	E		X			X	X		X	X		X	X					X
Salva	E				X		X		X	X		X	X					X
Salva-brava	R E			X	X	X	X	X	X				X		X			
Sândalo	R			X							X		X		X		X	
Malaleuca	E																	
Tomilho	E					X			X				X	X	X			
Ylang-ylang	R															X		

BIBLIOGRAFIA:

- Leadbeater, C. W.. *The Chacras*, Theosophical Publishing House, 1980.
- Massagem Ayur-Védica em vídeo cassete – Guia Prático – Vol. 1 e 2 – Edição do autor.
- Motoyoma, Hirosh. *Theories of the Chakras: Bridge to Higher Consciousness*. Theosophical Publishing House, 1988.
- Ozanic, Naomi. *The Elements of The Chakras*. Element Books Limited, 1990.
- Radha Silvananda Swami. *Kundalini Yoga for the West*. Shambala Publications, 1978.
- Volmar, Klansbernd. *Fahrplan durch die Chakren*. Werkstatt Edition, 1985.
- Edde, Gérard. *A Medicina Ayur-Védica*. IBRASA, São Paulo, 1985.
- Gerson, Scott. *Ayurveda – A Antiga Medicina Indiana*. Editorial Estampa1, Lisboa, 1993.
- Brennan, Barbara Ann. *Mãos de Luz*. Pensamento, São Paulo, 1995.
- Cardim, Valter Carlos. *Cristais – Manual Prático e Teórico*. Dinapress, Lisboa, 1999.
- Bienfait, Marcel. *Os Desequilíbrios Estáticos*. Summus Editorial, São Paulo, 1995.
- Rolf, Ida P.. *Rolfing – A Integração das Estruturas Humanas*. Martins Fontes, São Paulo, 1990.
- Wildwood, Christine. *Aromatherapy – Massage with essential oils*. Element Books Limited, USA, 1991.